

NEUROLOGIS KOMUNITAS DI LAHAN BASAH

Nurhalisa Wibawa
Bernadetta Germia Aridamayanti
Rifda Nur Achriyana Arif
Herawati



Neurologis Komunitas di Lahan Basah

Nurhalisa Wibawa

Bernadetta Germia Aridamayanti

Rifda Nur Achriyana Arif

Herawati



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Neurologis Komunitas di Lahan Basah

Penulis: Nurhalisa Wibawa
Bernadetta Germia Aridamayanti
Rifda Nur Achriyana Arif
Herawati

ISBN: 978-634-7219-45-9

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Achmad Faisal

Cetakan Pertama: Mei, 2025

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

All Right Reserved

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.**



PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Prakata

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku ini berhasil disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran mengenai Neurologis Komunitas di Lahan Basah. Buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca, khususnya mahasiswa, tenaga kesehatan, dan peneliti, dalam memahami bagaimana faktor lingkungan dan budaya mempengaruhi kesehatan saraf di komunitas tertentu. Penulisan buku ini bertujuan untuk mengupas berbagai aspek gangguan persyarafan yang sering terjadi di masyarakat lahan basah, faktor risiko yang berkontribusi, serta strategi pencegahan dan penanganannya. Dengan menggabungkan kajian ilmiah dan pendekatan berbasis budaya, diharapkan buku ini mampu menjadi referensi yang bermanfaat dalam dunia akademik dan praktik keperawatan serta kesehatan masyarakat.

Ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kami berharap buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis tetapi juga menjadi motivasi bagi para pembaca untuk lebih memahami dan mengembangkan serta intervensi yang relevan dengan kesehatan saraf dalam konteks lingkungan dan budaya.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi pijakan bagi pengembangan ilmu keperawatan dan kesehatan masyarakat di masa mendatang. Selamat membaca dan semoga ilmu yang diperoleh dari buku ini dapat diterapkan dengan baik untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Maret, 2025

Penulis



Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
Bab 1 Pendahuluan.....	1
A. Dimensi Lingkungan dan Budaya dalam Gangguan Sistem Saraf di Komunitas Lahan Basah	1
B. Masalah Neurologis di Komunitas Lahan Basah: Dampak Lingkungan dan Praktik Tradisional.....	3
C. Karakteristik Masyarakat Lahan Basah dan Budaya Banjar	6
D. Pendekatan Kontekstual Berbasis Lingkungan dan Budaya.....	12
E. Melestarikan Budaya Lokal dalam Konteks Kesehatan.....	14
F. Penutup	15
G. Referensi	21
Bab 2 Masyarakat Lahan Basah dan Budaya Banjar	23
A. Pendahuluan	23
B. Pola Hidup dan Mata Pencarian Masyarakat Banjar	27
C. Kebiasaan dan Adat Istiadat yang Berkaitan dengan Lingkungan Lahan Basah.....	29
D. Kontribusi Lingkungan Sosial dan Ekonomi Terhadap Kesehatan di Lahan Basah.....	33
E. Penutup	36
F. Referensi	40
Bab 3 Profil Epidemiologis Risiko Gangguan Sistem Saraf di Wilayah Lahan Basah	41
A. Pendahuluan	41
B. Paparan Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Sistem Syaraf	44
C. Pola Konsumsi (Makanan Khas, Air, dan Kebiasaan Hidup) Terhadap Kesehatan Syaraf	47
D. Kebiasaan Kerja dan Risiko Ergonomis di Lingkungan Lahan Basah	50
E. Genetik dan Predisposisi Gangguan Persyarafan	54

F. Penutup	57
G. Referensi	62

Bab 4 Jenis dan Mekanisme Gangguan Persyarafan Pada Masyarakat di Lahan Basah	63
A. Pendahuluan	63
B. Penyakit Neurotoksik Akibat Paparan Lingkungan	65
C. Gangguan Persyarafan Akibat Infeksi dan Penyakit Endemik	69
D. Peran Gaya Hidup dalam Memengaruhi Penyakit Neurodegeneratif.....	73
E. Gangguan Saraf dalam Konteks Komunitas.....	76
F. Penutup	78
G. Referensi	81

Bab 5 Preventif, Intervensi, dan Implementasi Keperawatan	87
A. Pendahuluan	87
B. Strategi Pencegahan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal	91
C. Pendekatan Keperawatan Komunitas dalam Menangani Gangguan Persyarafan	93
D. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi dan Promosi Kesehatan.....	100
E. Model Intervensi Berbasis Masyarakat untuk Kesehatan Syaraf.....	104
F. Penutup	106
G. Referensi	108

Bab 6 Penutup.....	113
A. Ringkasan	114
B. Implikasi Sosial-Budaya dan Lingkungan terhadap Pendidikan Keperawatan dan Pelayanan Kesehatan	116
C. Strategi Kesehatan dan Pendidikan Keperawatan Berbasis Budaya dan Lingkungan di Komunitas Lahan Basah.....	119
D. Penutup	124
E. Referensi	127

Glosarium	128
------------------------	------------

Bab 1

Pendahuluan

A. Dimensi Lingkungan dan Budaya dalam Gangguan Sistem Saraf di Komunitas Lahan Basah

Gangguan persyarafan merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat berdampak luas pada kehidupan individu dan masyarakat. Penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pusat maupun perifer, menyebabkan gangguan fungsi motorik, sensorik, hingga kognitif. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalami gangguan tersebut, tetapi juga oleh keluarga dan komunitas sekitarnya. Gangguan persyarafan dapat mengurangi produktivitas seseorang, meningkatkan ketergantungan terhadap orang lain, serta meningkatkan beban ekonomi akibat biaya pengobatan yang tinggi. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian gangguan persyarafan sangat penting untuk menentukan strategi pencegahan dan penanganan yang tepat.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam kajian gangguan persyarafan adalah kondisi lingkungan tempat seseorang tinggal. Masyarakat yang hidup di lahan basah memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat di wilayah lain. Wilayah lahan basah umumnya memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, paparan air yang berkepanjangan, serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih terbatas dibandingkan daerah perkotaan (Abdurrahman et al., 2021). Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap berbagai aspek kesehatan, termasuk kesehatan sistem persyarafan. Misalnya, paparan kelembapan yang tinggi dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan risiko peradangan saraf dan gangguan sirkulasi darah yang berdampak pada fungsi saraf perifer. Selain itu, aktivitas fisik yang berulang dan pekerjaan khas masyarakat lahan basah, seperti

bertani di lahan rawa atau menjadi nelayan, juga dapat menyebabkan tekanan berlebih pada sistem saraf.

Selain faktor lingkungan, budaya masyarakat juga berperan dalam menentukan pola kesehatan dan pengobatan. Masyarakat Banjar yang tinggal di lahan basah memiliki tradisi dan kebiasaan yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal. Pola makan, kebiasaan hidup, serta cara mereka merespons penyakit turut berpengaruh terhadap kejadian gangguan persyarafan (Astuty et al., 2023). Misalnya, konsumsi makanan tinggi garam dan rendah serat yang umum dalam masyarakat Banjar dapat meningkatkan risiko hipertensi, yang merupakan salah satu faktor utama penyebab stroke. Selain itu, kepercayaan terhadap pengobatan tradisional masih sangat kuat di kalangan masyarakat Banjar, di mana terapi seperti pijat urut, bekam, dan penggunaan ramuan herbal sering kali menjadi pilihan utama sebelum mencari pengobatan medis. Meskipun beberapa metode tradisional ini memiliki manfaat, keterlambatan dalam mendapatkan perawatan medis yang tepat dapat memperburuk kondisi pasien yang mengalami gangguan persyarafan.

Dengan adanya faktor lingkungan khas lahan basah dan pengaruh budaya Banjar terhadap pola kesehatan masyarakat, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam kontribusi kedua faktor ini terhadap kejadian gangguan persyarafan. Buku ini membuka wawasan baru tentang bagaimana interaksi antara lingkungan dan budaya mempengaruhi kesehatan masyarakat lokal. Faktor lingkungan seperti kelembapan tinggi dan pola hidup masyarakat di lahan basah yang memiliki pengaruh khusus terhadap sistem saraf. Selain itu, kepercayaan dan praktik kesehatan tradisional yang dianut oleh masyarakat Banjar juga dapat memberikan pandangan unik dalam menangani gangguan persyarafan. Kajian ini sangat relevan tidak hanya dalam ranah medis, tetapi juga dalam konteks sosial-budaya yang lebih luas.

Buku ini bertujuan untuk menganalisis pola gangguan persyarafan yang terjadi di masyarakat lahan basah serta bagaimana budaya Banjar memengaruhi persepsi dan penanganan gangguan tersebut. Dengan memahami hubungan antara lingkungan, budaya, dan kesehatan, diharapkan hasil ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi bidang keperawatan dan kesehatan masyarakat dalam menyusun strategi

pengecambahan dan intervensi yang lebih efektif. Selain itu, dalam buku ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelestarian budaya kesehatan masyarakat Banjar, sehingga nilai-nilai kearifan lokal dapat tetap dipertahankan sambil tetap memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang optimal.

Dengan demikian, buku ini akan menjadi langkah awal yang penting dalam mengisi kesenjangan informasi mengenai gangguan persyarafan di masyarakat yang tinggal di kawasan lahan basah. Keterbatasan data yang ada saat ini mengenai bagaimana lingkungan khas dan budaya Banjar memengaruhi kesehatan saraf membuat kajian ini sangat relevan. Buku yang terfokus pada dua aspek ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang berperan dalam tingginya prevalensi gangguan persyarafan di wilayah tersebut.

Melalui pendekatan yang mempertimbangkan faktor lingkungan dan budaya, strategi kesehatan yang dikembangkan diharapkan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan memahami bagaimana interaksi antara kedua faktor ini memengaruhi kesehatan, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat memberikan dampak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Masalah Neurologis di Komunitas Lahan Basah: Dampak Lingkungan dan Praktik Tradisional

Gangguan persyarafan merupakan salah satu masalah kesehatan yang semakin mendapat perhatian di Indonesia. Berdasarkan data Riskesdas 2021, stroke tetap menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian, dengan angka kejadian mencapai 10,9 per 1.000 penduduk. Selain itu, sekitar 30–50% penderita diabetes mellitus mengalami neuropati perifer, yang dapat menyebabkan kelemahan otot, gangguan sensorik, dan nyeri kronis yang berkepanjangan. Gangguan persyarafan seperti ini memperlihatkan beban kesehatan yang signifikan bagi masyarakat, terutama pada kelompok yang rentan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran dan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran untuk menekan angka kejadian.

Faktor lingkungan juga memainkan peran besar dalam memicu gangguan persyarafan, termasuk paparan kelembapan tinggi, infeksi, serta pola hidup yang kurang sehat. Masyarakat yang tinggal di wilayah lahan basah, seperti di Kalimantan Selatan, memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan saraf karena kondisi geografis yang khas. Kelembapan yang terus-menerus, sanitasi yang kurang optimal, serta kebiasaan hidup yang tidak mendukung kesehatan saraf memperburuk kondisi ini. Di wilayah ini, gangguan persyarafan dapat menjadi masalah kesehatan yang lebih kompleks karena interaksi antara lingkungan dan kebiasaan lokal. Oleh karena itu, perhatian khusus dan upaya preventif di wilayah lahan basah sangat dibutuhkan untuk mencegah tingginya angka gangguan persyarafan.

Lahan basah memiliki lingkungan dengan tingkat kelembapan tinggi serta paparan air yang konstan, yang berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan. Paparan air yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko infeksi bakteri dan virus, seperti *leptospirosis*, yang diketahui dapat menyebabkan komplikasi neurologis. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Lambung Mangkurat (2023) menunjukkan bahwa wilayah dengan karakteristik lahan basah memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit infeksi yang dapat berdampak pada sistem saraf, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor perikanan, pertanian, dan transportasi air. Selain itu, suhu yang cenderung lebih rendah akibat kelembapan tinggi dapat memicu gangguan saraf, seperti Bell's palsy, yang menyebabkan kelumpuhan wajah sementara. Kombinasi antara faktor lingkungan dan pekerjaan yang terkait dengan paparan air menjadi salah satu penyebab tingginya prevalensi gangguan saraf di wilayah ini.

Tidak hanya risiko infeksi dan gangguan saraf, faktor kelembapan yang tinggi di lahan basah juga dapat memperburuk kondisi kesehatan lainnya. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini sering mengalami masalah pada sistem pernapasan dan otot, yang juga dapat memengaruhi sistem saraf secara keseluruhan. Selain itu, pola hidup masyarakat yang sering berkaitan dengan pekerjaan berat di lingkungan lembap, seperti bertani dan menangkap ikan, dapat mempercepat terjadinya gangguan pada sistem persyarafan. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang tepat melalui edukasi kesehatan, perbaikan sanitasi, serta intervensi medis yang khusus bagi masyarakat di lahan basah sangat diperlukan. Penelitian lebih lanjut

diperlukan untuk memperkuat pemahaman mengenai dampak kondisi lingkungan terhadap kesehatan saraf di wilayah lahan basah ini.

Selain faktor lingkungan, budaya dan kebiasaan masyarakat Banjar yang tinggal di lahan basah juga berperan dalam kejadian serta penanganan gangguan persyarafan. Pola makan yang tinggi garam, seperti konsumsi ikan asin dan makanan olahan lainnya, dapat meningkatkan risiko hipertensi, yang merupakan faktor utama penyebab stroke. Di sisi lain, kepercayaan terhadap pengobatan tradisional masih sangat kuat, sehingga banyak penderita gangguan persyarafan lebih memilih terapi pijat atau ramuan herbal dibandingkan dengan pengobatan medis. Beberapa masyarakat juga masih mengaitkan gangguan persyarafan, seperti kejang atau lumpuh mendadak, dengan faktor mistis, sehingga keterlambatan dalam mendapatkan penanganan medis menjadi hal yang umum terjadi. Hal ini diperparah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah lahan basah, yang membuat akses terhadap diagnosis dan terapi gangguan persyarafan menjadi lebih sulit (Syahrin & Hamid, 2024).

Selain keterbatasan akses medis, pengaruh budaya dalam menentukan langkah penanganan kesehatan sangat kuat di kalangan masyarakat Banjar. Tradisi dan keyakinan lokal sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan tepat waktu. Sering kali, pengobatan medis hanya dijadikan pilihan terakhir ketika pengobatan tradisional tidak menunjukkan hasil yang diinginkan. Keterlambatan dalam pengobatan ini memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, terutama pada kasus gangguan persyarafan yang memerlukan penanganan cepat. Oleh karena itu, pendekatan yang memperhitungkan aspek budaya dan tradisi diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penanganan medis dalam mengatasi gangguan persyarafan.

Penelitian mengenai gangguan persyarafan di Indonesia masih banyak berfokus pada faktor degeneratif dan genetik, sementara kajian mengenai pengaruh ekologi lahan basah serta budaya Banjar terhadap gangguan persyarafan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis gangguan persyarafan yang umum terjadi di masyarakat lahan basah, menganalisis keterkaitan antara faktor lingkungan dan budaya dengan prevalensi gangguan tersebut, serta mengeksplorasi

bagaimana kebiasaan masyarakat dalam menangani masalah ini. Hasil dari ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak interaksi antara ekologi dan budaya terhadap kesehatan saraf. Dengan demikian, akan membuka peluang untuk pengembangan strategi kesehatan yang lebih spesifik dan efektif bagi masyarakat yang tinggal di wilayah lahan basah.

Melalui buku ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan berbasis budaya dalam upaya pencegahan dan pengobatan gangguan persyarafan di masyarakat lahan basah. Dengan memahami keterkaitan antara lingkungan, budaya, dan kesehatan saraf, hasil ini dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan kesehatan yang lebih efektif serta mendukung program kesehatan masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Hal ini juga berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya menjaga kesehatan saraf dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap lingkungan dan budaya setempat. Selain itu, temuan ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau dan sesuai untuk komunitas di wilayah lahan basah. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia.

C. Karakteristik Masyarakat Lahan Basah dan Budaya Banjar

Lahan basah merupakan wilayah dengan kondisi lingkungan yang khas, ditandai oleh ekosistem perairan yang mendominasi sebagian besar area, seperti rawa, sungai, danau, serta hutan mangrove. Di Indonesia, lahan basah tersebar luas di Kalimantan, Sumatra, Papua, dan sebagian wilayah Sulawesi. Ekosistem ini memainkan peran penting dalam mendukung keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kalimantan Selatan adalah salah satu daerah yang paling dikenal dengan ekosistem lahan basahnya, di mana masyarakat Banjar bermukim dan menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Kehidupan masyarakat di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lahan basah, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun Kesehatan (Sholahuddin et al., 2021).

Ekosistem lahan basah memiliki ciri utama berupa kelembapan tinggi, fluktuasi pasang surut air, serta tanah yang cenderung lunak atau berawa. Kondisi ini memengaruhi pola kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek

perumahan, mobilitas, dan jenis pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Rumah-rumah tradisional di lahan basah umumnya dibangun di atas tiang atau menggunakan sistem rumah terapung (lanting), yang dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan permukaan air. Mobilitas masyarakat di wilayah ini juga lebih bergantung pada jalur air, menggunakan perahu atau klotok sebagai alat transportasi utama untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain (Ati et al., 2025). Selain itu, pekerjaan di sektor perikanan, pertanian, dan transportasi air menjadi sangat umum di daerah ini, sesuai dengan kondisi geografis lahan basah.

Dari segi kesehatan, kondisi geografis ini dapat memengaruhi pola penyakit yang berkembang di masyarakat lahan basah. Kelembapan tinggi di lingkungan ini dapat meningkatkan risiko infeksi, baik dari bakteri, virus, maupun jamur, yang berkontribusi terhadap gangguan persyarafan. Misalnya, *leptospirosis* adalah salah satu penyakit yang umum ditemukan di daerah lahan basah dan dapat menyebabkan komplikasi *neurologis* seperti *meningitis* dan *neuropati perifer*. Selain itu, lingkungan yang sering tergenang air juga menjadi habitat bagi berbagai vektor penyakit seperti nyamuk, yang dapat menularkan penyakit ensefalitis dan demam berdarah, yang pada kasus berat bisa berdampak pada sistem saraf.

Fluktuasi suhu dan tekanan udara di lahan basah memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan saraf. Suhu udara yang lebih dingin akibat kelembapan tinggi dapat memperburuk kondisi pasien dengan penyakit saraf kronis, seperti *neuropati diabetik* dan *radikulopati*, yang menyebabkan nyeri dan kelemahan otot. Selain itu, pola aktivitas masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan lahan basah, seperti bekerja dalam kondisi basah atau berendam lama di air, meningkatkan risiko gangguan saraf. Tekanan berkepanjangan pada sistem saraf perifer dapat menyebabkan kondisi seperti *sindrom lorong karpal* dan *neuropati kompresi* lainnya. Faktor lingkungan ini turut berperan dalam meningkatkan prevalensi gangguan persyarafan di kalangan masyarakat lahan basah.

Masyarakat Banjar memiliki budaya yang erat kaitannya dengan lingkungan lahan basah, di mana pola makan mereka merupakan salah satu aspek yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam setempat (Sholahuddin et al., 2021). Hidangan sehari-hari masyarakat Banjar sering kali

didominasi oleh makanan yang tinggi garam dan menggunakan bahan pengawet alami, seperti ikan asin, wadi (ikan yang difermentasi), serta berbagai jenis makanan berkuah seperti soto Banjar dan habang. Penggunaan garam yang berlebihan dalam proses pengawetan makanan tradisional ini dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, yang dikenal sebagai salah satu penyebab utama stroke dan gangguan persyarafan lainnya. Konsumsi makanan dengan kadar garam tinggi ini tidak hanya berdampak pada pembuluh darah otak, tetapi juga memicu terjadinya aterosklerosis yang dapat memperburuk kondisi kesehatan saraf. Budaya konsumsi makanan asin yang telah berlangsung turun-temurun ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menurunkan prevalensi gangguan persyarafan di kalangan masyarakat Banjar.

Selain pola makan yang tinggi garam, masyarakat Banjar juga cenderung mengonsumsi makanan yang bersantan dan digoreng, yang meningkatkan risiko penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Diabetes mellitus, terutama yang tidak terkontrol dengan baik, sering kali menjadi penyebab utama terjadinya neuropati perifer, suatu kondisi di mana saraf-saraf perifer mengalami kerusakan dan menyebabkan gejala seperti nyeri, kesemutan, atau mati rasa. Di daerah lahan basah, prevalensi diabetes cenderung lebih tinggi karena kombinasi antara pola makan dan minimnya aktivitas fisik yang terstruktur (Fajriah et al., 2021). Kebiasaan mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan rendah serat semakin memperburuk kondisi metabolik yang mempengaruhi kesehatan saraf. Selain itu, rendahnya konsumsi sayur-mayur dalam pola makan tradisional juga berkontribusi terhadap kekurangan nutrisi yang penting untuk menjaga kesehatan saraf, seperti vitamin B dan antioksidan. Akibatnya, masyarakat Banjar di daerah lahan basah memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap gangguan persyarafan yang berkaitan dengan gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat.

Selain itu, masyarakat Banjar memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, seperti ketupat, lontong, dan nasi, yang sering dikombinasikan dengan lauk goreng atau bersantan. Pola makan ini meningkatkan risiko diabetes mellitus, yang merupakan salah satu penyebab utama neuropati perifer. Konsumsi makanan berlemak dan bersantan secara berlebihan dapat memperburuk kontrol gula darah pada penderita diabetes. Selain itu, kekurangan serat dan konsumsi sayur yang relatif lebih sedikit

dalam pola makan tradisional juga berkontribusi pada peningkatan risiko gangguan metabolik. Kondisi metabolik yang tidak terkendali ini dapat memperparah gangguan persyarafan, terutama neuropati perifer.

Dari segi aktivitas fisik, masyarakat Banjar yang tinggal di lahan basah cenderung memiliki pekerjaan yang berhubungan erat dengan lingkungan air, seperti nelayan, petani di lahan rawa, dan pedagang yang memanfaatkan jalur sungai sebagai transportasi utama. Aktivitas sehari-hari ini sering kali dilakukan dalam posisi tubuh yang kurang variatif atau dengan tekanan berulang pada anggota tubuh tertentu. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan gangguan persyarafan, salah satunya adalah neuropati akibat kompresi saraf. Misalnya, nelayan yang terus-menerus melakukan gerakan berulang saat menarik jala di perairan sering mengalami tekanan pada saraf median di pergelangan tangan, yang berisiko menyebabkan sindrom lorong karpal. Kondisi ini dapat memicu gejala seperti nyeri, kesemutan, hingga kelemahan pada tangan, sehingga mengganggu kemampuan kerja mereka. Selain nelayan, petani di lahan rawa juga menghadapi risiko gangguan persyarafan yang serupa, terutama karena posisi tubuh yang cenderung membungkuk dalam waktu lama saat bekerja di sawah atau ladang. Tekanan berulang pada tulang belakang dapat memicu terjadinya *hernia nukleus pulposus (HNP)* atau saraf terjepit, yang menyebabkan nyeri punggung bawah dan memengaruhi mobilitas. Para petani sering kali mengabaikan keluhan ini dan lebih memilih pengobatan tradisional seperti pijat atau jamu, dibandingkan mencari pengobatan medis yang tepat. Selain itu, pedagang yang menggunakan perahu atau klotok untuk transportasi di sungai juga berisiko mengalami gangguan persyarafan akibat paparan dingin dan kelembapan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, profesi masyarakat Banjar yang berhubungan dengan lahan basah memberikan tantangan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait dengan pencegahan dan penanganan gangguan saraf.

Selain itu, bekerja dalam kondisi lingkungan yang lembap dan dingin dapat memperburuk gejala gangguan saraf, terutama bagi mereka yang sudah mengalami kondisi seperti radikulopati atau nyeri saraf kronis. Paparan terus-menerus terhadap suhu rendah dan kelembapan tinggi meningkatkan risiko inflamasi pada saraf, yang dapat memperparah rasa nyeri. Petani di lahan basah, yang sering membungkuk dalam waktu lama saat bekerja di

sawah atau rawa, berisiko tinggi mengalami *hernia nukleus pulposus (HNP)* atau saraf terjepit. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri hebat di punggung, kesulitan bergerak, serta kelemahan otot. Kombinasi antara faktor lingkungan dan aktivitas fisik berat ini memperbesar terjadinya gangguan persyarafan di kalangan masyarakat lahan basah.

Masyarakat Banjar masih sangat menghargai sistem pengobatan tradisional dalam menangani berbagai penyakit, termasuk gangguan persyarafan (Riana et al., 2022). Pengobatan alternatif seperti pijat refleksi, bekam, dan penggunaan ramuan herbal menjadi pilihan utama, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang sulit mengakses layanan kesehatan modern. Menurut laporan Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan (2022), sekitar 60% masyarakat di wilayah lahan basah lebih memilih pengobatan tradisional sebelum mencari bantuan medis modern. Hal ini terutama berlaku untuk kasus-kasus seperti nyeri saraf, kebas, hingga kelumpuhan sementara. Kebiasaan ini mencerminkan kepercayaan kuat terhadap efektivitas terapi tradisional, meskipun terkadang keterlambatan dalam mencari pengobatan medis dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien.

Kepercayaan terhadap penyebab non-medis juga masih cukup kuat dalam masyarakat Banjar. Beberapa kondisi neurologis, seperti kejang, stroke mendadak, atau kelumpuhan wajah (*Bell's palsy*), sering dikaitkan dengan gangguan mistis atau pengaruh makhluk halus. Hal ini menyebabkan banyak pasien yang mengalami gejala neurologis lebih dulu mendatangi tokoh spiritual atau orang pintar sebelum memeriksakan diri ke dokter. Meskipun beberapa metode tradisional seperti pijat bisa membantu dalam kasus tertentu, keterlambatan dalam mendapatkan perawatan medis yang tepat sering kali memperburuk kondisi pasien (Rahmadi, 2022).

Beberapa tanaman herbal yang sering digunakan masyarakat Banjar untuk mengatasi masalah saraf antara lain jahe, kunyit, dan pegagan, yang dipercaya dapat meningkatkan sirkulasi darah dan meredakan nyeri saraf. Jahe dikenal memiliki sifat anti-inflamasi, sedangkan kunyit mengandung kurkumin yang dapat membantu mengurangi peradangan. Pegagan diyakini dapat memperbaiki fungsi saraf dan membantu regenerasi sel saraf. Namun, penggunaan obat herbal tanpa pengawasan medis dapat berisiko karena

interaksi dengan obat-obatan modern yang dikonsumsi pasien. Oleh karena itu, penting untuk mengombinasikan pengobatan tradisional dengan pengobatan medis secara hati-hati.

Jika dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah non-lahan basah, terdapat beberapa perbedaan dalam risiko dan pola penanganan gangguan persyarafan. Masyarakat perkotaan atau yang tinggal di dataran tinggi cenderung lebih banyak mengalami gangguan persyarafan akibat gaya hidup sedentari, obesitas, dan paparan stres tinggi, yang berkontribusi pada meningkatnya kasus neuropati diabetik dan stroke. Sementara itu, masyarakat lahan basah lebih banyak mengalami gangguan persyarafan akibat faktor lingkungan, seperti paparan kelembapan tinggi, infeksi akibat genangan air, dan postur tubuh yang tidak ergonomis dalam pekerjaan.

Masyarakat perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan modern, termasuk spesialis neurologi dan terapi fisik yang penanganan gangguannya lebih cepat dan efektif. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lahan basah lebih bergantung pada pengobatan tradisional, seperti pijat refleksi dan ramuan herbal, yang sering kali menyebabkan keterlambatan diagnosis. Hal ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang modern, terutama di daerah terpencil. Akibatnya, banyak kasus gangguan persyarafan, seperti neuropati atau kelumpuhan sementara, yang tidak segera tertangani, memperburuk prognosis penyakit tersebut. Dengan demikian, perbedaan akses layanan kesehatan antara perkotaan dan daerah lahan basah menjadi salah satu faktor utama dalam penanganan gangguan persyarafan.

Selain faktor akses, lingkungan lahan basah yang lembap dan dingin juga berpengaruh terhadap kesehatan saraf. Kondisi ini memperburuk gejala penyakit saraf kronis, seperti neuropati diabetik dan radikulopati, yang menyebabkan nyeri dan kelemahan otot. Pekerjaan di lahan basah, seperti nelayan dan petani rawa, juga meningkatkan risiko gangguan saraf akibat gerakan berulang atau posisi tubuh yang tidak ergonomis. Pola makan masyarakat Banjar, yang tinggi garam dan pengawet alami, turut berkontribusi terhadap peningkatan risiko hipertensi, yang merupakan penyebab utama stroke dan gangguan saraf lainnya.

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi intervensi berbasis budaya yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lahan basah.

D. Pendekatan Kontekstual Berbasis Lingkungan dan Budaya

Permasalahan utama adalah tingginya angka gangguan persyarafan yang terjadi di masyarakat lahan basah serta bagaimana faktor budaya memengaruhi respons terhadap kondisi tersebut. Berbagai gangguan persyarafan yang umum ditemukan meliputi stroke, neuropati diabetik, dan sindrom lorong karpal, yang sebagian besar berkaitan dengan faktor risiko seperti pola makan tinggi garam dan rendah serat, paparan kelembapan tinggi, serta pekerjaan fisik yang berulang. Namun, pemahaman mengenai bagaimana faktor lingkungan khas lahan basah berkontribusi terhadap kejadian gangguan persyarafan masih terbatas. Selain itu, budaya Banjar memiliki pengaruh yang kuat terhadap pola pengobatan masyarakat. Banyak individu yang lebih memilih terapi tradisional seperti pijaturut, bekam, dan penggunaan ramuan herbal dibandingkan pengobatan medis.

Beberapa gangguan persyarafan juga masih dikaitkan dengan kepercayaan supranatural, yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan medis yang tepat. Kepercayaan ini membuat masyarakat sering kali menunda untuk mendapatkan penanganan medis, yang pada akhirnya memperburuk kondisi mereka. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan modern di daerah lahan basah memperparah situasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai gangguan persyarafan dan pentingnya penanganan medis yang cepat serta tepat.

Dengan demikian, dapat diharapkan adanya perbaikan akses terhadap layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lahan basah. Dalam konteks tersebut, bertujuan untuk mendeskripsikan pola gangguan persyarafan yang umum terjadi di masyarakat lahan basah serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejadian penyakit tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyebab dan dampaknya. Fokus utama adalah mengidentifikasi jenis gangguan saraf yang paling sering dialami oleh masyarakat, serta bagaimana lingkungan lahan basah yang khas memengaruhi kondisi kesehatan saraf mereka, sehingga dapat merumuskan strategi pencegahan

yang lebih efektif. Selain itu, menganalisis keterkaitan antara budaya Banjar dan cara masyarakat dalam menangani gangguan persyarafan, baik dalam hal persepsi terhadap penyakit maupun metode pengobatan yang dipilih, yang menunjukkan betapa pentingnya aspek budaya dalam penanganan kesehatan.

Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai pendekatan yang lebih efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan persyarafan di masyarakat lahan basah, sehingga program intervensi yang dirancang akan lebih tepat sasaran. Dengan menggali lebih dalam hubungan antara lingkungan, budaya, dan kesehatan, hasil ini dapat menjadi dasar pengembangan strategi kesehatan yang lebih terarah dan berbasis komunitas, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan yang lebih kontekstual ini diharapkan tidak hanya mampu mencegah penyakit, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, sambil tetap menghormati nilai-nilai tradisional yang mereka anut.

Buku ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko spesifik yang berkaitan dengan kondisi lahan basah dan bagaimana faktor-faktor ini berkontribusi terhadap kejadian gangguan persyarafan, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh lingkungan terhadap kesehatan saraf masyarakat. Beberapa faktor yang diduga memiliki peran penting meliputi paparan kelembapan tinggi yang dapat memperburuk kondisi saraf, pola hidup yang kurang aktif akibat ketergantungan pada transportasi air, serta aktivitas pekerjaan seperti nelayan dan petani di lahan rawa yang berpotensi menyebabkan cedera saraf akibat postur kerja yang tidak ergonomis, yang jika tidak ditangani dengan tepat, dapat meningkatkan risiko gangguan saraf jangka panjang.

Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat dikembangkan strategi intervensi yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat lahan basah, sehingga upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, pendekatan yang berbasis pada karakteristik lingkungan dan budaya setempat diharapkan mampu menghasilkan program kesehatan yang lebih terarah dan berkelanjutan, yang tidak hanya dapat mencegah gangguan persyarafan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat

secara keseluruhan. Kombinasi antara pemahaman ilmiah dan penghargaan terhadap nilai-nilai tradisional diharapkan mampu menciptakan solusi yang lebih holistik dalam menangani permasalahan kesehatan di wilayah ini.

Sebagai hasil akhir, buku ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan persyarafan pada masyarakat lahan basah. Pendekatan yang berbasis budaya akan menjadi salah satu aspek utama dalam rekomendasi ini, mengingat pentingnya budaya Banjar dalam kehidupan masyarakat. Dengan cara ini, strategi intervensi yang diusulkan dapat lebih mudah diterima dan diterapkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif, khususnya bagi komunitas yang tinggal di daerah dengan karakteristik lingkungan yang unik seperti lahan basah.

E. Melestarikan Budaya Lokal dalam Konteks Kesehatan

Harapan dari buku ini adalah memberikan berbagai manfaat, baik dalam bidang ilmu keperawatan, kesehatan masyarakat, maupun pelestarian budaya. Dengan memahami bagaimana faktor lingkungan khas lahan basah dan budaya Banjar memengaruhi persepsi serta penanganan gangguan persyarafan, buku ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan strategi kesehatan yang lebih efektif dan berbasis kearifan lokal.

Dalam bidang ilmu keperawatan, buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana faktor lingkungan dan budaya berperan dalam pengelolaan pasien dengan gangguan persyarafan. Perawat dan tenaga medis sering kali menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan di daerah dengan kondisi geografis dan sosial yang khas seperti lahan basah. Pemahaman mengenai pola hidup masyarakat, termasuk kebiasaan pengobatan tradisional yang masih kuat, dapat membantu perawat dalam memberikan edukasi kesehatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Astuty et al., 2023). Selain itu, buku ini dapat menjadi referensi bagi tenaga keperawatan dalam mengembangkan pendekatan yang lebih personal dan berbasis budaya dalam menangani pasien dengan gangguan persyarafan. Dengan demikian, perawatan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi

juga mempertimbangkan latar belakang budaya pasien agar lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat.

Dari segi kesehatan masyarakat, hal ini dapat berkontribusi dalam perencanaan strategi pencegahan dan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Gangguan persyarafan merupakan masalah kesehatan yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, hasil ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang program edukasi kesehatan yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan budaya. Misalnya, jika ditemukan bahwa kebiasaan masyarakat Banjar dalam mengonsumsi makanan tinggi garam berkontribusi terhadap meningkatnya risiko stroke, maka kampanye kesehatan dapat difokuskan pada promosi pola makan yang lebih sehat dengan pendekatan yang tetap menghormati budaya setempat. Selain itu, juga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah lahan basah, dengan mempertimbangkan hambatan geografis serta kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional.

Selain manfaat dalam bidang kesehatan, juga memiliki nilai penting dalam pelestarian budaya. Budaya Banjar merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat lahan basah, termasuk dalam cara mereka menghadapi tantangan kesehatan. Dengan mendokumentasikan bagaimana masyarakat Banjar menangani gangguan persyarafan, dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan kesehatan berbasis kearifan lokal. Selain itu, dapat menjadi arsip berharga yang mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi turun-temurun memengaruhi pola hidup serta cara masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka. Pemahaman ini penting tidak hanya bagi bidang kesehatan, tetapi juga dalam konteks kajian budaya dan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

F. Penutup

Buku ini bertujuan untuk mengkaji gangguan persyarafan yang terjadi pada masyarakat lahan basah dengan memperhatikan keterkaitannya dengan budaya Banjar, yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Faktor lingkungan khas lahan basah, seperti kelembapan tinggi, paparan air yang berkepanjangan, serta aktivitas fisik yang berulang-ulang seperti

pekerjaan sebagai nelayan dan petani, berkontribusi terhadap tingginya risiko gangguan persyarafan. Di samping itu, pola hidup yang dipengaruhi oleh kondisi geografis juga memengaruhi kesehatan saraf masyarakat, terutama dalam hal kebiasaan duduk atau bekerja dalam posisi yang tidak ergonomis selama waktu yang lama.

Selain faktor lingkungan, budaya Banjar yang sangat menghargai pengobatan tradisional, seperti penggunaan ramuan herbal, bekam, dan pijat refleksi, juga memengaruhi cara masyarakat menangani gangguan persyarafan. Masyarakat sering kali lebih percaya pada terapi tradisional dibandingkan layanan medis modern, sehingga sering terlambat dalam memperoleh diagnosis dan penanganan yang tepat. Ketergantungan pada metode pengobatan ini, yang terkadang masih terkait dengan kepercayaan lokal, dapat memperpanjang masa sakit atau bahkan memperburuk kondisi saraf yang sudah ada, sehingga menghambat pemulihan dan pengobatan yang optimal.

Pola konsumsi makanan tinggi garam dan rendah serat yang umum dalam masyarakat Banjar, seperti ketupat, lontong, dan ikan asin, turut menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko hipertensi dan stroke, yang merupakan salah satu penyebab utama gangguan persyarafan. Konsumsi makanan asin berlebihan memicu peningkatan tekanan darah tinggi, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah serta saraf, dan meningkatkan risiko penyakit saraf degeneratif seperti neuropati. Meski demikian, kebiasaan ini masih melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang membuat risiko gangguan saraf semakin tinggi di daerah tersebut.

Sayangnya, rendahnya kesadaran masyarakat Banjar terhadap pentingnya asupan gizi yang seimbang serta efek jangka panjang dari pola makan yang tidak sehat semakin memperparah kondisi ini. Pola makan yang lebih kaya serat dan rendah garam sering kali diabaikan, meskipun risiko penyakit saraf dan hipertensi yang mengintai. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pola makan yang sehat, serta dorongan untuk beralih ke pola makan yang lebih seimbang demi mencegah dampak buruk gangguan persyarafan di masa depan.

Selain pola makan, metode pengobatan yang dipilih masyarakat juga berperan dalam proses pemulihan gangguan persyarafan. Masih banyak masyarakat yang lebih mempercayai terapi tradisional seperti pijat urut, bekam, dan penggunaan ramuan herbal dibandingkan dengan pengobatan medis. Meskipun beberapa metode tradisional ini dapat membantu mengurangi gejala tertentu, keterlambatan dalam mendapatkan perawatan medis yang tepat sering kali memperburuk kondisi pasien, terutama bagi mereka yang mengalami stroke atau neuropati akibat penyakit kronis.

Kepercayaan terhadap mitos kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanganan gangguan persyarafan. Beberapa masyarakat masih mengaitkan penyakit saraf dengan gangguan supranatural atau kelelahan akibat kerja keras. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran terhadap faktor risiko medis yang sebenarnya, seperti tekanan darah tinggi, kadar gula darah yang tidak terkontrol, serta faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya gangguan persyarafan.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kesehatan yang diterapkan di masyarakat lahan basah harus mempertimbangkan faktor lingkungan dan budaya setempat. Intervensi kesehatan yang berbasis kearifan lokal, seperti mengombinasikan edukasi kesehatan dengan pendekatan budaya, akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pencegahan serta pengobatan gangguan persyarafan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih cepat mengenali gejala dan mencari pengobatan yang sesuai.

Berdasarkan temuan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat lahan basah dalam menghadapi gangguan persyarafan. Salah satu saran yang perlu diterapkan adalah pengadaan program edukasi kesehatan yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya Banjar. Dengan pendekatan yang lebih mengutamakan penggunaan bahasa lokal dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati, materi edukasi akan lebih mudah diterima serta dipahami oleh masyarakat, sehingga dapat mendorong perubahan pola pikir terhadap pengobatan modern dan kesehatan secara keseluruhan. Hal ini dapat

membantu mengatasi ketergantungan pada pengobatan tradisional yang sering kali tidak memadai untuk menangani gangguan persyarafan.

Selain program edukasi, upaya lain yang tidak kalah penting adalah memperkuat akses layanan kesehatan di daerah lahan basah, yang hingga kini masih menghadapi berbagai kendala geografis dan infrastruktur. Pemerintah, bersama dengan tenaga kesehatan, perlu mengupayakan pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih memadai dan tersebar merata di seluruh wilayah lahan basah. Di samping itu, peningkatan jumlah tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani gangguan persyarafan sangat diperlukan agar masyarakat dapat mendapatkan layanan yang tepat dan cepat. Dengan adanya dukungan fasilitas yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan pengobatan yang sesuai dan efektif.

Tidak hanya itu, penyediaan program pelayanan kesehatan keliling juga sangat penting, terutama untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan sulit diakses. Dengan adanya layanan kesehatan keliling, masyarakat lahan basah dapat lebih cepat mendapatkan diagnosis dini serta pengobatan yang tepat untuk gangguan persyarafan yang mereka alami. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pengobatan tradisional yang sering kali terlambat dalam memberikan solusi medis yang efektif, serta mencegah perkembangan gangguan persyarafan ke tahap yang lebih parah.

Terakhir, sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat juga harus ditingkatkan agar pendekatan terhadap kesehatan lebih komprehensif dan berkelanjutan. Program-program yang dirancang bersama, seperti kampanye kesehatan terpadu dan partisipasi masyarakat dalam mempromosikan pola hidup sehat, dapat menciptakan kesadaran yang lebih luas dan berkesinambungan dalam upaya pencegahan gangguan persyarafan. Upaya ini tidak hanya akan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga mengurangi beban layanan kesehatan di masa mendatang.

Integrasi pengobatan tradisional dengan medis juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan gangguan persyarafan. Mengingat masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap terapi tradisional, tenaga kesehatan dapat bekerja sama dengan pengobat tradisional untuk memastikan metode yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip medis yang tepat. Pendekatan kolaboratif ini dapat menciptakan keseimbangan antara kepercayaan lokal dan kemajuan medis, sehingga masyarakat dapat merasa lebih nyaman dalam menjalani pengobatan. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih terbuka terhadap pengobatan medis tanpa harus meninggalkan sepenuhnya kepercayaan terhadap metode tradisional yang mereka yakini selama ini.

Selain itu, kampanye kesehatan mengenai pentingnya pola makan sehat dan aktivitas fisik yang tepat perlu diperkuat untuk menanggulangi gangguan persyarafan. Penyuluhan yang berfokus pada bahaya konsumsi garam berlebihan, pentingnya asupan gizi seimbang, serta manfaat olahraga dalam menjaga kesehatan saraf perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Mengingat pola makan yang kurang sehat masih menjadi masalah utama, penyuluhan ini harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi masyarakat lahan basah. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan risiko kesehatan yang mereka hadapi dapat meningkat, sehingga pola hidup sehat dapat diterapkan dalam keseharian. Tidak hanya terkait pola hidup sehat, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek lingkungan yang dapat memperburuk gangguan persyarafan, seperti kelembapan tinggi di daerah lahan basah yang dapat memicu masalah kesehatan. Langkah preventif berupa peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, penyediaan peralatan medis yang sesuai, serta penguatan program pelayanan kesehatan di daerah terpencil sangat diperlukan. Dengan adanya perhatian pada faktor lingkungan, masyarakat lahan basah dapat lebih terlindungi dari risiko gangguan persyarafan yang diakibatkan oleh kondisi geografis yang unik ini.

Terakhir, perlunya peningkatan peran tokoh masyarakat dalam mendorong perubahan perilaku sehat juga tidak boleh diabaikan. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan dan perilaku masyarakat setempat, termasuk dalam hal kesehatan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat

sangat penting untuk mempromosikan perubahan perilaku yang lebih sehat, termasuk penerimaan terhadap pengobatan medis modern. Sinergi yang baik antara ketiga pihak ini akan menghasilkan pendekatan kesehatan yang lebih holistik dan berbasis komunitas, sehingga penanganan gangguan persyarafan dapat lebih optimal.

Dengan adanya upaya yang lebih terarah dan berbasis budaya, diharapkan masyarakat lahan basah dapat lebih memahami, mencegah, dan menangani gangguan persyarafan secara lebih efektif. Pendekatan yang memperhitungkan lingkungan khas lahan basah dan pola hidup masyarakat Banjar akan membantu merancang strategi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, integrasi antara pengetahuan medis modern dengan kearifan lokal, seperti penggunaan obat herbal dan praktik tradisional, dapat memperkuat upaya pencegahan dan pengobatan. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih merata dan tepat sasaran.

Melalui pendekatan yang mempertimbangkan kondisi lingkungan dan budaya setempat, strategi kesehatan yang dikembangkan dapat memberikan dampak yang lebih optimal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini tidak hanya akan membantu mencegah gangguan persyarafan, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan saraf secara berkelanjutan. Program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan penyuluhan berbasis komunitas dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap kesehatan saraf. Dengan demikian, kesehatan masyarakat lahan basah dapat ditingkatkan secara keseluruhan dan risiko gangguan persyarafan dapat ditekan.

G. Referensi

- Abdurrahman, Syahrin, M. N. Al, Vadia, E., Salsabella, N., & Rajab, A. (2021). Wetland Environment Deteritorialization In The Perspective Of Political Ecology In Banjar Regency. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.53622/ij3pei.v1i01.6>
- Astuty, S., Yuwanto, Alfirdaus, L. K., & Akhmad, B. A. (2023). Understanding Wetland Environmental Risk Mitigation Communication Strategy: A case study in Banjarmasin. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(2), 166–173. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i2.737>
- Ati, A., Aldiansyah, S., Hasan, H., Windayani, W., Bahar, H., Qadri, M. S., Ladianto, A. J., & Putra, A. (2025). *Perubahan Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan Menggunakan Metode Maximum Likelihood*. 10(1), 80–89.
- Fajriah, N., Suryaningsih, Y., Zainuddin, Z., Masriani, R., & Rahadhian, L. N. R. (2021). Eksplorasi Etnomatematika Budaya Di Lingkungan Lahan Basah Sebagai Sarana Mengembangkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik. *EDU-MAT: Jurnal Pendidikan Matematika*, 9(2), 121–130. <https://doi.org/10.20527/edumat.v9i2.11858>
- Rahmadi. (2022). *Agama dan Budaya Masyarakat Banjar*. Zahir Publishing.
- Riana, D. R., Yayuk, R., Jahdiah, Suryatin, E., & Hidayatullah, D. (2022). Tuturan Bermakna Budaya sebagai Pembelajaran Kearifan Lokal Masyarakat Banjar: Studi Etnopedagogi. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 11(2), 301–318. <https://doi.org/10.26499/rnh.v11i2.5196>
- Sholahuddin, A., Fitriyana, R., Sya'ban, M. F., & Sadiqin, I. K. (2021). Students' Caring Attitudes To Wetland Environment: A Case Of Environmental Education In Banjar District Indonesia. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 10(1), 149–158. <https://doi.org/10.15294/jpii.v10i1.27838>
- Syahrin, M. N. Al, & Hamid, I. (2024). *Deteritorialisasi Lingkungan dan Bentuk-Bentuk Alih Fungsi Lahan Basah di Kabupaten Banjar (Studi di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut)*. 8(2), 827–835.

Bab 2

Masyarakat Lahan Basah dan Budaya Banjar

A. Pendahuluan

Lahan basah merupakan ekosistem yang memiliki ciri khas berupa lahan yang tergenang air secara permanen atau musiman sehingga memiliki peran penting dalam keseimbangan lingkungan. Ekosistem ini mencakup rawa, sungai, dan daerah pesisir yang mendukung keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna yang hidup di dalamnya. Di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, lahan basah tidak hanya menjadi bagian dari lanskap alam, tetapi juga membentuk budaya dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Suku Banjar yang mendiami daerah ini telah lama beradaptasi dengan kondisi lahan basah sehingga banyak aspek kehidupan mereka dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Keberadaan lahan basah tidak hanya mempengaruhi mata pencaharian, tetapi juga membentuk kebiasaan, adat istiadat, serta sistem sosial masyarakat Banjar.

Masyarakat Banjar memiliki keterikatan erat dengan lahan basah, yang tercermin dalam pola hidup mereka sehari-hari, terutama dalam hal mobilitas dan mata pencaharian. Sungai tidak hanya menjadi jalur transportasi utama, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi, seperti perdagangan dan perikanan. Sebagian besar masyarakat Banjar menggantungkan hidup pada sumber daya alam yang tersedia di sekitar mereka, seperti mencari ikan di sungai, bertani di lahan rawa, atau berdagang di pasar terapung. Alat transportasi air, seperti perahu atau kelotok masih digunakan hingga saat ini, meskipun perkembangan infrastruktur darat semakin meningkat. Adaptasi terhadap kondisi lahan basah ini membuat masyarakat Banjar memiliki keterampilan khusus dalam mengelola sumber daya alam yang terus berubah akibat pasang surut air.

Selain mata pencaharian, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat Banjar juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan lahan basah, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Rumah adat Banjar yang berbentuk rumah panggung dirancang khusus untuk mengantisipasi banjir atau genangan air yang kerap terjadi di daerah rawa (Khairiyati et al., 2022). Tradisi dan ritual adat juga menunjukkan bagaimana masyarakat Banjar menghormati dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, seperti upacara “baayun anak” yang sering dilakukan di rumah panggung atau di tepi sungai. Pola interaksi sosial masyarakat Banjar pun banyak dilakukan di sekitar perairan, yang terlihat dalam aktivitas sehari-hari seperti mandi di sungai, mencuci pakaian, dan bahkan berjualan di pasar terapung. Keberadaan sungai bukan hanya sebagai sarana kehidupan, tetapi juga menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi bagi masyarakat setempat.

Namun, kondisi sosial dan ekonomi turut memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan masyarakat Banjar di lahan basah, terutama dalam hal kesejahteraan dan akses terhadap fasilitas dasar. Tingkat pendidikan yang masih bervariasi di kalangan masyarakat Banjar berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur dan transportasi. Modernisasi membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat Banjar, tetapi tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih bergantung pada ekonomi tradisional (Khairiyati et al., 2022). Jika tidak diantisipasi dengan baik, perubahan ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan menurunkan kualitas hidup masyarakat Banjar di masa depan.

Di sisi lain, pola hidup masyarakat yang masih sangat bergantung pada air sungai dan rawa juga membawa tantangan dalam aspek kesehatan dan sanitasi. Kualitas air sungai yang semakin menurun akibat pencemaran menjadi faktor utama meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti infeksi saluran pernapasan akibat kelembaban tinggi serta penyakit kulit akibat air yang tidak higienis (Kissinger et al., 2023). Selain itu, kebiasaan mengonsumsi air sungai tanpa pengolahan yang memadai masih banyak ditemukan di beberapa daerah, yang meningkatkan risiko penyakit

pencernaan seperti diare dan infeksi saluran kemih. Penyakit berbasis lingkungan ini diperparah dengan minimnya fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah pedalaman yang jauh dari pusat layanan medis. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan sangat diperlukan untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, masyarakat Banjar tetap memiliki keunggulan dalam bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai gotong royong yang masih kuat dalam kehidupan sosial mereka membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai kesulitan, baik yang bersifat ekonomi maupun lingkungan. Banyak tradisi yang mereka pertahankan juga mengajarkan bagaimana menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestariannya, sehingga ekosistem lahan basah tetap lestari. Kearifan ini menjadi modal penting dalam mengembangkan strategi keberlanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kelestarian budaya dan lingkungan. Jika nilai-nilai ini terus dipertahankan dan dikolaborasikan dengan kebijakan yang tepat, maka masyarakat Banjar dapat terus berkembang tanpa kehilangan identitas budaya mereka.

Peran pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan juga sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya serta lingkungan lahan basah. Peningkatan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan, seperti jalan dan jembatan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah rawa, akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi tanpa merusak ekosistem. Program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif dan pengolahan hasil perikanan juga dapat membantu meningkatkan pendapatan serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang semakin terbatas. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang lebih serius dalam mengatasi masalah pencemaran sungai dan deforestasi lahan basah yang mengancam ekosistem alami. Dengan adanya kebijakan yang tepat, masyarakat Banjar dapat terus berkembang tanpa mengorbankan lingkungan yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Selain dukungan dari pemerintah, pendidikan juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjar dan

mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem lahan basah. Dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan, masyarakat akan lebih memahami bagaimana mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan tidak hanya mengandalkan eksploitasi semata. Pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan, sehingga kebiasaan yang kurang higienis dapat dikurangi secara bertahap. Generasi muda yang memiliki akses pendidikan lebih baik akan memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan inovasi yang mendukung kehidupan masyarakat lahan basah tanpa harus meninggalkan budaya mereka. Jika pendidikan terus ditingkatkan, maka akan lahir masyarakat yang lebih mandiri dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan lebih baik.

Keberlanjutan masyarakat Banjar di lahan basah bergantung pada keseimbangan antara pelestarian budaya, adaptasi terhadap perubahan, serta perlindungan terhadap lingkungan. Modernisasi memang membawa manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi jika tidak diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai tradisional dan lingkungan, maka identitas masyarakat Banjar bisa terkikis. Oleh karena itu, program pembangunan di daerah lahan basah harus memperhatikan aspek budaya, agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan warisan leluhur yang telah terbentuk selama berabad-abad. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan juga sangat penting, agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Jika keseimbangan ini dapat dicapai, maka masyarakat Banjar akan tetap mampu berkembang dan beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri mereka.

Dengan memahami karakteristik masyarakat lahan basah dan budaya Banjar, dapat dilihat bagaimana lingkungan alam berperan dalam membentuk kebiasaan, mata pencaharian, serta tantangan sosial dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang dapat mendukung keberlanjutan lingkungan lahan basah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjar agar tetap dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Dukungan dari pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak yang berkepentingan sangat diperlukan agar masyarakat lahan basah dapat hidup lebih sejahtera tanpa harus mengorbankan alam yang telah memberikan mereka kehidupan. Jika berbagai tantangan dapat diatasi dengan

pendekatan yang tepat, maka masyarakat Banjar akan mampu menghadapi masa depan dengan lebih baik dan tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungannya.

B. Pola Hidup dan Mata Pencarian Masyarakat Banjar

Masyarakat lahan basah di Kalimantan Selatan memiliki pola hidup yang sangat bergantung pada lingkungan perairan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kesehatan, termasuk sistem persyarafan. Faktor lingkungan, seperti paparan air yang terkontaminasi logam berat dan senyawa beracun dari aktivitas pertambangan atau limbah industri, dapat meningkatkan risiko gangguan neurologis (Abdurrahman et al., 2021). Konsumsi ikan dan hasil sungai yang terkontaminasi merkuri, misalnya, dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat, seperti tremor, gangguan koordinasi, dan penurunan fungsi kognitif. Selain itu, kondisi tempat tinggal yang lembap dan minim ventilasi juga berpotensi meningkatkan risiko infeksi saraf akibat jamur atau bakteri yang berkembang di lingkungan tersebut.

Budaya masyarakat Banjar yang erat dengan sungai tidak hanya mempengaruhi aktivitas ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada risiko kesehatan saraf akibat pola kerja yang berat dan repetitif. Aktivitas seperti mendayung, mengangkat beban, atau berdiri lama di air dapat meningkatkan risiko gangguan saraf perifer, terutama bagi para nelayan dan petani. Tekanan yang berulang pada bagian tubuh tertentu, seperti tangan, bahu, dan punggung, sering kali mengakibatkan masalah kesehatan seperti neuropati perifer dan nyeri skiatik. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya ergonomi dalam bekerja juga memperparah risiko gangguan saraf ini, membuat pekerjaan yang dilakukan setiap hari semakin berpotensi merusak kesehatan.

Di sisi lain, tidak adanya akses yang memadai terhadap layanan kesehatan di wilayah lahan basah semakin memperburuk kondisi ini. Masyarakat sering kali tidak memiliki pengetahuan atau sarana untuk mencegah atau mengobati gangguan saraf yang mereka alami. Hal ini berdampak pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya postur tubuh yang benar saat bekerja serta penyediaan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau menjadi solusi penting untuk mengurangi risiko gangguan saraf di kalangan masyarakat Banjar. Kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat

diperlukan untuk menciptakan program kesehatan yang tepat guna dan berkelanjutan.

Selain faktor fisik, pola konsumsi masyarakat juga berkontribusi terhadap risiko gangguan persyarafan. Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam, seperti ikan asin dan hasil olahan laut lainnya, dapat meningkatkan tekanan darah yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan sistem saraf. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan saraf akibat gangguan sirkulasi darah, meningkatkan risiko stroke serta komplikasi neurologis lainnya. Di sisi lain, pola makan yang kurang seimbang dengan asupan vitamin B yang rendah, terutama B1, B6, dan B12, dapat menyebabkan neuropati perifer yang ditandai dengan kesemutan, kelemahan otot, hingga gangguan koordinasi gerak.

Gaya hidup dan kebiasaan masyarakat juga berperan dalam meningkatnya risiko gangguan saraf. Kebiasaan duduk lama di atas lanting atau rumah panggung dengan posisi yang kurang ergonomis dapat menyebabkan tekanan pada saraf punggung dan tungkai. Selain itu, penggunaan obat-obatan herbal tanpa pengawasan medis juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan, karena beberapa ramuan tradisional yang dikonsumsi masyarakat Banjar berpotensi mengandung senyawa neurotoksik yang dapat merusak sistem saraf dalam jangka panjang. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai di daerah lahan basah juga memperburuk kondisi ini, karena banyak kasus gangguan persyarafan yang tidak terdiagnosis atau tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik dalam mengatasi gangguan persyarafan pada masyarakat lahan basah, baik melalui edukasi kesehatan, peningkatan akses layanan medis, maupun perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Pemerintah dan tenaga medis perlu meningkatkan penyuluhan tentang faktor risiko gangguan saraf, terutama terkait pola makan, aktivitas fisik, serta bahaya paparan zat beracun dari lingkungan. Selain itu, pengembangan fasilitas kesehatan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat lahan basah, seperti puskesmas terapung atau layanan kesehatan berbasis komunitas, menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan dini gangguan persyarafan. Dengan pendekatan yang tepat, kesehatan saraf masyarakat lahan basah dapat lebih terjaga, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Masyarakat Banjar yang hidup di lahan basah Kalimantan Selatan memiliki pola mata pencaharian yang sangat bergantung pada sungai dan lingkungan perairan. Profesi nelayan menjadi salah satu mata pencaharian utama, di mana mereka menangkap ikan di sungai-sungai dan rawa-rawa yang menjadi sumber penghidupan sehari-hari. Selain itu, banyak juga yang menjadi petani dengan memanfaatkan lahan basah untuk bercocok tanam, terutama pada tanaman padi yang tahan genangan. Pengrajin tradisional juga berperan dalam ekonomi lokal, menghasilkan produk kerajinan tangan dari bahan alam sekitar, seperti anyaman rotan dan bambu. Pola mata pencaharian ini memperlihatkan keterkaitan erat antara masyarakat Banjar dan lingkungan perairan yang mendukung kehidupan mereka.

Namun, mata pencaharian yang bergantung pada lingkungan tersebut juga menghadapi tantangan yang cukup serius. Perubahan kondisi lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan limbah industri mengancam kelestarian sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. Kontaminasi air dengan logam berat, seperti merkuri, tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga mengurangi hasil tangkapan ikan yang menjadi sumber penghasilan utama nelayan. Di sisi lain, lahan pertanian pun rentan terhadap banjir dan perubahan cuaca ekstrem, yang dapat mengganggu produktivitas tanaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan perairan agar mata pencaharian masyarakat Banjar dapat terus berkelanjutan.

C. Kebiasaan dan Adat Istiadat yang Berkaitan dengan Lingkungan Lahan Basah

Kebiasaan dan adat istiadat masyarakat Banjar di lahan basah sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari mereka yang bergantung pada sungai dan rawa. Masyarakat Banjar telah lama hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar sungai, seperti ikan, tanaman air, dan kayu bakar. Tradisi menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti jala dan bubu merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dilestarikan hingga kini. Aktivitas ini bukan hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari ritual budaya yang sering kali dikaitkan dengan kepercayaan terhadap roh penjaga sungai. Sebagai contoh, upacara "baayun banua" dilakukan sebagai bentuk

penghormatan terhadap alam yang dipercaya memberikan rezeki melalui hasil tangkapan ikan.

Adat-istiadat masyarakat Banjar juga mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dan air sebagai elemen penting dalam kehidupan mereka. Sungai tidak hanya digunakan sebagai sumber penghidupan, tetapi juga berfungsi sebagai jalur transportasi dan tempat berinteraksi sosial. Kebiasaan mandi dan mencuci di sungai sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, meskipun kini mulai digantikan oleh akses air bersih di beberapa daerah. Namun, bagi sebagian masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, sungai masih menjadi sumber utama untuk kebutuhan air sehari-hari. Upacara "batumbang" atau tradisi membersihkan sungai bersama-sama dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas air yang melimpah.

Selain penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari, adat Banjar juga memiliki aturan khusus terkait cara menjaga kelestarian lingkungan lahan basah. Masyarakat di beberapa desa masih menerapkan hukum adat untuk melarang kegiatan yang dapat merusak ekosistem sungai dan rawa. Sebagai contoh, menebang pohon secara sembarangan di sekitar lahan basah dianggap tabu karena dipercaya dapat memicu bencana banjir atau kekeringan (Riana et al., 2022). Selain itu, masyarakat juga diharuskan menjaga vegetasi alami di sekitar sungai untuk mencegah erosi dan menjaga kualitas air. Tradisi ini membuktikan bahwa masyarakat Banjar telah memiliki kesadaran ekologis yang tinggi sejak zaman dahulu, meskipun tanpa intervensi dari pihak luar.

Penggunaan ramuan alami yang berasal dari tumbuhan lahan basah juga menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Banjar dalam menjaga kesehatan. Tumbuhan seperti akar kuning dan daun sambiloto sering digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai macam penyakit, termasuk demam dan gangguan pencernaan. Penggunaan tanaman obat ini tidak hanya menunjukkan pengetahuan lokal yang kaya, tetapi juga menjadi simbol keterhubungan manusia dengan alam. Pada beberapa ritual penyembuhan, ramuan ini dikombinasikan dengan doa-doa atau mantra yang diucapkan oleh dukun atau balian. Dengan demikian, pengobatan

tradisional ini mencerminkan perpaduan antara ilmu pengetahuan lokal dan spiritualitas yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kebiasaan dalam membangun rumah juga menunjukkan adaptasi masyarakat Banjar terhadap lingkungan lahan basah yang berawa. Rumah panggung yang terbuat dari kayu ulin, yang dikenal kuat dan tahan lama, menjadi pilihan utama untuk menghadapi kondisi tanah yang lembek dan rentan banjir. Rumah-rumah panggung ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga melindungi penghuni dari ancaman banjir dan serangan hewan air seperti ular atau buaya. Selain itu, rumah panggung memberikan ruang bawah untuk menyimpan perahu yang digunakan sehari-hari. Struktur rumah ini mencerminkan kearifan lokal dalam beradaptasi dengan alam, sekaligus menjadi identitas arsitektur khas masyarakat Banjar. Masyarakat Banjar juga memiliki kebiasaan bergotong royong dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan lahan basah. Gotong royong ini biasanya dilakukan untuk membersihkan sungai, memperbaiki jalan setapak, atau memperbaiki rumah panggung yang rusak. Nilai kebersamaan ini sangat kental dalam kehidupan masyarakat Banjar, karena mereka menyadari bahwa kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan seluruh komunitas. Misalnya, saat terjadi banjir besar, seluruh warga desa akan saling membantu dalam evakuasi dan mendirikan tempat penampungan sementara. Kebiasaan ini tidak hanya menunjukkan solidaritas sosial, tetapi juga sebagai cara masyarakat mengatasi bencana alam secara kolektif.

Dalam hal pertanian, masyarakat Banjar mengembangkan teknik bertani yang disesuaikan dengan kondisi lahan basah, seperti sistem sawah apung. Sawah apung atau lebak lebung merupakan teknik bertani yang memanfaatkan genangan air musiman untuk menanam padi. Sistem ini memungkinkan petani tetap bisa bercocok tanam meskipun tanahnya berawa dan sulit dikeringkan. Tradisi ini telah dilakukan turun-temurun, dan dianggap sebagai cara yang ramah lingkungan untuk memanfaatkan lahan basah tanpa merusaknya. Namun, dengan adanya perubahan iklim dan urbanisasi, praktik pertanian tradisional ini mulai terancam keberadaannya. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan teknik ini sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat lahan basah.

Adat dalam menangani kematian juga menunjukkan hubungan masyarakat Banjar dengan lahan basah dan air. Ketika ada warga yang meninggal dunia, prosesi pemakaman sering kali melibatkan sungai sebagai jalur transportasi jenazah menuju lokasi pemakaman. Perahu yang dihias dengan kain putih digunakan untuk membawa jenazah, dan prosesi ini disertai dengan doa-doa serta taburan bunga di sungai sebagai bentuk penghormatan terakhir. Tradisi ini tidak hanya menunjukkan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal, tetapi juga sebagai simbol keterhubungan manusia dengan alam, di mana sungai dianggap sebagai jalur menuju alam keabadian. Prosesi ini menjadi bagian dari adat yang memperkuat ikatan spiritual antara manusia, alam, dan Tuhan.

Pengelolaan sumber daya alam juga diatur melalui hukum adat yang bertujuan melindungi kelestarian lahan basah. Salah satu contohnya adalah larangan menangkap ikan pada waktu-waktu tertentu untuk memberikan kesempatan bagi ikan berkembang biak. Kearifan lokal ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada hasil perairan. Meskipun tekanan modernisasi mulai mengancam praktik-praktik ini, banyak masyarakat Banjar yang tetap teguh memegang nilai-nilai tradisional mereka. Hal ini membuktikan bahwa adat-istiadat yang diwariskan secara turun-temurun memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pada akhirnya, kebiasaan dan adat-istiadat masyarakat Banjar yang berkaitan dengan lingkungan lahan basah menunjukkan keseimbangan antara tradisi, budaya, dan ekosistem. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan iklim, masyarakat Banjar terus berupaya melestarikan adat istiadat mereka sambil beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menjaga kelestarian tradisi ini, karena selain memiliki nilai budaya, praktik-praktik ini juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang menghargai kearifan lokal, diharapkan masyarakat Banjar dapat terus hidup berdampingan dengan alam tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Inisiatif ini penting untuk menjaga keseimbangan ekologis lahan basah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Kontribusi Lingkungan Sosial dan Ekonomi Terhadap Kesehatan di Lahan Basah

Faktor sosial juga memegang peran penting dalam mempengaruhi kesehatan masyarakat Banjar di lahan basah Kalimantan Selatan. Salah satu faktor utamanya adalah pendidikan yang rendah, yang membatasi pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan diri, terutama dalam hal sanitasi, yang berakibat pada tingginya angka infeksi penyakit, seperti diare dan infeksi kulit. Kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan juga membuat masyarakat cenderung menyepelekan gejala penyakit hingga kondisi menjadi lebih serius dan sulit untuk ditangani.

Budaya dan adat istiadat yang turun-temurun memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat Banjar. Salah satu pengaruh terbesar adalah kepercayaan yang masih kuat terhadap pengobatan tradisional yang dilakukan oleh dukun atau balian. Pengobatan tradisional ini sering kali menggunakan ramuan herbal atau melibatkan ritual spiritual yang dianggap mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit (Riana et al., 2022). Masyarakat di pedalaman Banjar cenderung lebih memilih pendekatan ini dibandingkan dengan layanan kesehatan modern, terutama karena kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun nilai budaya ini penting, ketergantungan yang berlebihan pada pengobatan tradisional dapat menghambat akses terhadap penanganan medis yang lebih efektif.

Ketika masyarakat mengandalkan pengobatan tradisional untuk penyakit yang memerlukan intervensi medis cepat, risiko komplikasi kesehatan meningkat. Misalnya, infeksi yang bisa diatasi dengan antibiotik dalam perawatan medis mungkin dibiarkan berkembang karena penanganan yang terlambat dengan metode tradisional. Dalam beberapa kasus, penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi juga sering tidak terdeteksi atau tidak diobati dengan benar karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya diagnosis dini dan pengobatan modern. Hal ini menyebabkan kondisi kesehatan masyarakat Banjar yang tinggal di daerah terpencil sering kali menjadi lebih parah sebelum mereka mencari bantuan medis yang sesuai.

Salah satu alasan masyarakat Banjar lebih memilih pengobatan tradisional adalah akses yang terbatas terhadap fasilitas kesehatan modern, terutama di daerah pedalaman dan lahan basah. Keterbatasan infrastruktur, seperti transportasi yang sulit, dan biaya yang tinggi untuk mencapai pusat layanan kesehatan membuat masyarakat lebih nyaman mengandalkan dukun atau balian yang tersedia di desa mereka. Selain itu, kurangnya edukasi mengenai pentingnya kesehatan preventif dan layanan medis modern juga memperkuat kepercayaan mereka pada metode tradisional. Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa beberapa penyakit memerlukan perawatan medis yang tidak dapat disembuhkan hanya dengan ramuan herbal atau ritual.

Namun, bukan berarti pengobatan tradisional harus dihilangkan sepenuhnya, karena metode ini memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting bagi masyarakat Banjar. Solusi yang lebih baik adalah mengintegrasikan pengobatan tradisional dengan pendekatan medis modern melalui program kesehatan yang kolaboratif. Edukasi mengenai kapan pengobatan modern diperlukan harus ditingkatkan, sementara pengobatan tradisional tetap dihormati sebagai bagian dari warisan budaya. Dengan demikian, kesejahteraan kesehatan masyarakat Banjar dapat lebih terjamin tanpa harus menghilangkan identitas budaya mereka yang telah melekat selama berabad-abad.

Struktur sosial masyarakat yang cenderung tertutup dan bergantung pada komunitas juga memengaruhi cara mereka mengakses layanan kesehatan. Di beberapa daerah, akses terhadap fasilitas kesehatan modern masih dianggap tabu atau dianggap terlalu mahal, sehingga banyak yang memilih untuk tetap bergantung pada dukungan sosial dari komunitas mereka sendiri. Hal ini menciptakan tantangan bagi upaya peningkatan kesehatan masyarakat, karena edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya layanan medis modern sering kali sulit diterima. Untuk itu, pendekatan yang memperhatikan aspek sosial dan budaya setempat sangat penting dalam meningkatkan kesadaran kesehatan dan mengubah pola pikir masyarakat Banjar agar lebih terbuka terhadap layanan kesehatan modern.

Faktor ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap kondisi kesehatan masyarakat Banjar di wilayah lahan basah. Sebagian besar penduduk bekerja

sebagai nelayan, petani tambak, atau pedagang kecil yang bergantung pada hasil alam dan kondisi cuaca. Ketidakstabilan pendapatan membuat banyak keluarga kesulitan untuk mendapatkan makanan bergizi sehingga masalah gizi buruk dan stunting masih menjadi perhatian. Selain itu, biaya transportasi dan pengobatan yang tinggi sering kali membuat masyarakat enggan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Program bantuan seperti BPJS Kesehatan memang telah membantu, tetapi masih ada kendala dalam penggunaannya, terutama di daerah terpencil yang minim akses informasi dan fasilitas kesehatan.

Selain aspek ekonomi, budaya dan kebiasaan turun-temurun juga berpengaruh terhadap pola kesehatan masyarakat. Beberapa kelompok masih lebih percaya pada pengobatan tradisional daripada medis modern, sehingga banyak penyakit baru ditangani ketika sudah dalam kondisi parah. Misalnya, masyarakat di beberapa daerah lebih mengandalkan balian atau dukun dalam menangani penyakit daripada pergi ke puskesmas. Selain itu, pola hidup yang masih bergantung pada lingkungan sungai, seperti mandi dan mencuci di perairan yang tercemar, turut meningkatkan risiko penyakit kulit dan infeksi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis budaya dalam edukasi kesehatan agar masyarakat lebih mudah menerima perubahan yang positif tanpa merasa kehilangan identitas budayanya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat dalam meningkatkan layanan kesehatan yang lebih inklusif. Penyediaan puskesmas terapung, program edukasi kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lahan basah harus terus dikembangkan agar kondisi kesehatan dapat membaik. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti telemedicine dapat menjadi alternatif untuk mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil. Dengan sinergi berbagai pihak, diharapkan kesehatan masyarakat Banjar di wilayah lahan basah dapat meningkat, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera.

Kepercayaan terhadap pengobatan tradisional juga masih kuat di kalangan masyarakat Banjar. Pengobatan berbasis ramuan herbal, pijat tradisional, hingga praktik dukun sering kali menjadi pilihan utama sebelum mencari

bantuan medis modern. Beberapa tanaman yang tumbuh di lahan basah, seperti akar kuning dan daun sambiloto, dipercaya memiliki khasiat untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk demam dan infeksi. Sementara itu, praktik balian, yang melibatkan doa dan ritual spiritual masih digunakan untuk mengobati penyakit yang dianggap berkaitan dengan gangguan roh atau energi negatif. Meskipun pengobatan tradisional memiliki nilai budaya yang penting, keterbatasannya dalam menangani penyakit serius membuat integrasi dengan layanan medis modern menjadi tantangan tersendiri.

E. Penutup

Masyarakat Banjar telah lama hidup berdampingan dengan lahan basah, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada ekosistem ini. Sungai dan rawa menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, di mana banyak aktivitas ekonomi seperti perikanan dan perdagangan dilakukan. Rumah panggung yang dibangun oleh masyarakat Banjar merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang tergenang air, menunjukkan betapa eratnya hubungan mereka dengan alam. Selain itu, perahu menjadi sarana transportasi utama, memfasilitasi mobilitas mereka di tengah wilayah berair. Oleh karena itu, kearifan lokal yang mereka miliki mencerminkan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam di lahan basah.

Meski masyarakat Banjar memiliki kearifan lokal yang kuat, tantangan modernisasi semakin menggerus beberapa tradisi mereka. Teknologi dan perkembangan ekonomi membuat masyarakat lebih memilih cara hidup yang lebih praktis, sehingga beberapa praktik tradisional mulai ditinggalkan. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan juga mengganggu keseimbangan ekosistem, mempengaruhi ketersediaan ikan dan sumber daya lainnya yang sebelumnya melimpah. Selain itu, pembangunan yang tidak terkontrol dapat merusak habitat alami, menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan lahan basah. Untuk menghadapi perubahan ini, diperlukan inovasi yang memadukan tradisi dengan teknologi modern agar ekosistem tetap terjaga.

Selain modernisasi, masalah kesehatan juga menjadi tantangan yang signifikan bagi masyarakat Banjar di daerah lahan basah. Penggunaan air sungai sebagai sumber utama untuk kebutuhan sehari-hari sering kali menyebabkan masalah kesehatan, terutama karena kualitas air yang

tercemar. Penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi kulit, dan malaria sering kali muncul akibat kondisi sanitasi yang kurang memadai. Limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai tanpa pengolahan juga memperburuk kondisi kesehatan masyarakat setempat. Untuk itu, sangat penting adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya sanitasi dan pengelolaan limbah yang lebih baik.

Walaupun demikian, masyarakat Banjar memiliki modal sosial yang kuat melalui tradisi gotong royong dan kebersamaan. Nilai-nilai ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong gerakan kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai tradisi lokal yang menekankan pentingnya menjaga alam dapat diintegrasikan dengan upaya pelestarian lingkungan. Kearifan lokal yang mereka miliki dapat menjadi dasar yang kokoh dalam merancang kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat Banjar dapat menghadapi tantangan yang ada dengan tetap menjaga identitas budayanya.

Selain kearifan lokal, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat lahan basah, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar. Pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi air yang lebih baik dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Banjar, yang selama ini terkendala oleh akses yang terbatas. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan program pelestarian lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif warga. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan, masyarakat Banjar juga memerlukan akses yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah lahan basah sering kali menghambat anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan adanya peningkatan fasilitas pendidikan dan program beasiswa, generasi muda Banjar dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah mereka. Selain itu, pendidikan lingkungan dapat menjadi fokus penting dalam kurikulum sekolah, mengajarkan pentingnya pelestarian lahan basah kepada generasi berikutnya. Upaya ini akan

memastikan keberlanjutan kearifan lokal yang selama ini menjaga keseimbangan ekosistem.

Tak hanya pendidikan, akses kesehatan yang memadai juga menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Banjar yang hidup di daerah lahan basah. Keterbatasan fasilitas kesehatan membuat banyak warga harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan medis yang layak, sehingga keterlambatan penanganan sering terjadi. Program kesehatan berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi warga lokal dapat menjadi solusi efektif untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada mereka. Selain itu, edukasi tentang pentingnya kesehatan preventif, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan penerapan sanitasi yang baik, perlu ditingkatkan guna mengurangi risiko penyebaran penyakit. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan tenaga kesehatan, masalah kesehatan di daerah lahan basah dapat ditangani dengan lebih baik.

Kearifan lokal dalam pertanian pasang surut yang dimiliki masyarakat Banjar juga perlu terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya dan strategi adaptasi lingkungan. Sistem pertanian ini telah terbukti ramah lingkungan, karena memanfaatkan perubahan pasang surut air secara alami tanpa perlu merusak lahan gambut. Dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip tradisional, penggunaan teknologi modern yang tepat guna dapat meningkatkan hasil pertanian tanpa menimbulkan dampak negatif pada ekosistem. Pemerintah dan lembaga riset juga dapat berperan penting dalam memperkenalkan teknologi baru yang relevan dengan kebutuhan petani lokal. Sinergi antara teknologi dan kearifan lokal akan menjamin keberlanjutan sistem pertanian ini, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain pertanian, masyarakat Banjar juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekowisata berbasis lahan basah. Wilayah lahan basah yang unik dan kaya akan keanekaragaman hayati dapat menjadi daya tarik wisata alam yang berkelanjutan. Pasar terapung, yang telah menjadi ikon budaya Banjar, dapat dikemas sebagai destinasi wisata yang menarik, tidak hanya untuk transaksi jual beli, tetapi juga sebagai media untuk memperkenalkan budaya lokal kepada pengunjung. Pengelolaan ekowisata yang baik, dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama, dapat memberikan keuntungan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dengan

demikian, ekowisata dapat menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan bagi masyarakat Banjar.

Peran pemerintah dalam mendukung keberlanjutan masyarakat lahan basah sangat penting, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, dan transportasi air yang memadai, akan memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Selain itu, kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya air dan pengendalian limbah, harus diperkuat untuk menjaga ekosistem lahan basah dari kerusakan. Kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya akan memastikan bahwa perkembangan ekonomi dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan lahan basah.

Terakhir, pasar terapung yang menjadi ciri khas kehidupan ekonomi masyarakat Banjar juga memegang peran penting dalam menjaga hubungan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Pasar ini bukan hanya tempat untuk bertransaksi, tetapi juga menjadi pusat interaksi sosial bagi masyarakat lahan basah. Aktivitas perdagangan di atas air mencerminkan adaptasi unik masyarakat terhadap lingkungan lahan basah yang dinamis. Melalui pelestarian pasar terapung, kearifan lokal dan nilai-nilai sosial dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Upaya promosi pasar terapung sebagai objek wisata juga dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal, sekaligus menjaga tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad.

F. Referensi

- Abdurrahman, Syahrin, M. N. Al, Vadia, E., Salsabella, N., & Rajab, A. (2021). Wetland Environment Deteritorialization In The Perspective Of Political Ecology In Banjar Regency. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.53622/ij3pei.v1i01.6>
- Arisanty, D., Anis, M. Z. A., Hastuti, K. P., Angriani, P., Alviawati, E., Putro, H. P. N., & Syarifuddin. (2021). *Peranan Masyarakat dan Pemerintah pada Lahan Gambut: Upaya Pencegahan Kebakaran Lahan*. CV. Jendela Hasanah. [https://repositori.dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/24820/Peranan Pemerintah dan Masyarakat Pada Lahan Gambut.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositori.dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/24820/Peranan%20Pemerintah%20dan%20Masyarakat%20Pada%20Lahan%20Gambut.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Khairiyati, L., Marlinae, L., Waskito, A., & Rahmat, A. N. (2022). Buku Ajar Pengantar Lingkungan Lahan Basah. In *CV Mine*.
- Kissinger, Hatta, G. M., Soendjoto, M. A., & Abidin, Z. (2023). *Buku Ajar Pengantar Lingkungan Lahan Basah*. CV Banyubening Cipta Sejahtera.
- Kristianus. (2024). *Lahan Basah Kalimantan Selatan: Peran Penting dan Tantangan Keberlanjutan*. Borneo Review. <https://borneoreview.co/lahan-basah-kalimantan-selatan-peran-penting-dan-tantangan-keberlanjutan/>
- Riana, D. R., Yayuk, R., Jahdiah, Suryatin, E., & Hidayatullah, D. (2022). Tuturan Bermakna Budaya sebagai Pembelajaran Kearifan Lokal Masyarakat Banjar: Studi Etnopedagogi. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 11(2), 301–318. <https://doi.org/10.26499/rnh.v11i2.5196>

Bab 3

Profil Epidemiologis Risiko Gangguan Sistem Saraf di Wilayah Lahan Basah

A. Pendahuluan

Lahan basah memiliki karakteristik lingkungan yang unik, seperti kelembapan tinggi, keberadaan air tergenang, serta ekosistem yang kaya akan flora dan fauna. Kondisi ini mendukung keberlanjutan ekosistem, tetapi juga memunculkan tantangan kesehatan, terutama terkait risiko penyakit menular. Air tergenang menjadi tempat berkembang biaknya berbagai vektor penyakit, seperti nyamuk, yang dapat menyebarkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Selain itu, kelembapan tinggi juga memfasilitasi pertumbuhan mikroorganisme patogen yang dapat menginfeksi manusia dan hewan. Faktor-faktor ini menciptakan risiko kesehatan yang signifikan bagi komunitas yang hidup di sekitar lahan basah.

Risiko lain dari lahan basah adalah akumulasi zat beracun di dalam air, yang dapat berdampak negatif pada sistem saraf dalam jangka panjang. Racun ini dapat berasal dari polutan industri, pestisida, atau limbah rumah tangga yang mencemari perairan. Paparan berkelanjutan terhadap bahan-bahan berbahaya ini dapat memengaruhi fungsi saraf, menyebabkan gangguan neurologis pada manusia dan hewan yang bergantung pada sumber daya lahan basah. Oleh karena itu, pengelolaan lahan basah yang baik sangat penting untuk melindungi ekosistem sekaligus menjaga kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Salah satu dampak lingkungan lahan basah terhadap kesehatan saraf adalah meningkatnya risiko infeksi yang menyerang sistem saraf pusat. Air tergenang di lahan basah menjadi habitat ideal bagi bakteri dan parasit yang dapat menyebabkan infeksi otak, seperti meningitis dan ensefalitis. Kondisi kelembapan yang tinggi serta vegetasi di sekitar perairan juga mendukung berkembangnya nyamuk yang membawa virus berbahaya, seperti virus *West Nile*, yang dapat memengaruhi sistem saraf. Paparan ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lahan basah. Selain itu, risiko infeksi saraf ini juga meningkat seiring dengan rendahnya kualitas air dan buruknya sanitasi.

Selain infeksi, masyarakat di lahan basah juga sering terpapar logam berat dan bahan kimia yang dilepaskan dari aktivitas manusia, seperti merkuri dan timbal. Logam berat ini dapat mencemari air dan tanah, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia melalui air minum atau makanan yang terkontaminasi. Akumulasi zat-zat berbahaya ini dapat memicu gangguan neurologis, termasuk penurunan fungsi kognitif, tremor, hingga neuropati perifer. Dampak ini dapat terjadi dalam jangka panjang, dengan konsekuensi kesehatan yang serius bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan limbah dan kontrol polusi di lahan basah sangat diperlukan untuk melindungi kesehatan saraf masyarakat sekitar.

Selain itu, pola konsumsi masyarakat lahan basah yang bergantung pada ikan air tawar dan tanaman rawa juga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan saraf. Ikan gabus, misalnya, yang kaya omega-3 dan albumin, dapat membantu regenerasi sel saraf dan menjaga fungsi kognitif. Namun, risiko kontaminasi logam berat seperti merkuri pada ikan dari perairan tercemar dapat menyebabkan kerusakan saraf dalam jangka panjang. Tanaman rawa seperti kangkung juga mampu menyerap logam berat dari tanah atau air yang tercemar, sehingga bila dikonsumsi terus-menerus, dapat berdampak buruk pada perkembangan saraf, terutama pada anak-anak. Selain itu, air gambut dengan tingkat keasaman tinggi dapat memengaruhi keseimbangan elektrolit dalam tubuh, yang berdampak pada fungsi saraf dan otot.

Secara keseluruhan, lingkungan lahan basah membawa tantangan besar bagi kesehatan saraf masyarakat, melalui paparan zat beracun, infeksi penyakit, serta pola konsumsi yang berpotensi membahayakan. Paparan logam berat dari makanan dan air yang terkontaminasi mengancam kesehatan saraf, sementara infeksi dari bakteri dan virus di habitat lahan basah juga dapat menyebabkan penyakit neurologis serius. Kondisi lingkungan ini memperkuat pentingnya mitigasi dan pencegahan masalah kesehatan dengan melakukan pengelolaan limbah yang lebih baik dan pemantauan kualitas air yang ketat. Selain itu, masyarakat juga perlu diedukasi tentang bahaya mengonsumsi makanan dari lingkungan yang tercemar. Dengan langkah-langkah pencegahan ini, diharapkan risiko gangguan saraf pada masyarakat lahan basah dapat diminimalkan.

Selain infeksi dan kontaminasi, perubahan iklim dan degradasi lingkungan juga memperparah risiko bagi kesehatan saraf di lahan basah. Perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu mempercepat perkembangan mikroorganisme patogen serta meningkatkan pencemaran lingkungan (Syahrin & Hamid, 2024). Akibatnya, vektor penyakit seperti nyamuk menjadi lebih cepat berkembang dan menyebar luas, meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang memengaruhi sistem saraf. Selain itu, polusi udara dari aktivitas pembakaran lahan turut memperburuk kualitas udara, yang bila terhirup dalam jangka panjang, berpotensi memicu gangguan neurologis seperti sakit kepala kronis atau penurunan kemampuan kognitif. Kondisi ini menuntut penanganan serius dari pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan ekosistem lahan basah.

Dengan adanya tantangan-tantangan ini, penting untuk menerapkan pendekatan holistik dalam menangani permasalahan kesehatan di lahan basah. Tidak hanya dengan fokus pada pengelolaan lingkungan, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang sehat. Edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, pola hidup sehat, serta kerjasama lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan. Penerapan teknologi ramah lingkungan dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga harus diprioritaskan. Dengan sinergi berbagai pihak, diharapkan masyarakat lahan basah dapat hidup dengan sehat dan aman dari risiko gangguan saraf yang diakibatkan oleh lingkungan mereka.

B. Paparan Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Sistem Syaraf

Lahan basah memiliki karakteristik lingkungan yang khas, seperti kelembapan tinggi, keberadaan air tergenang, serta ekosistem sungai yang kaya akan flora dan fauna (Annisa & Prastitasari, 2021). Kondisi ini menciptakan lingkungan yang unik, tetapi juga membawa berbagai risiko bagi kesehatan, termasuk gangguan pada sistem saraf. Kelembapan yang tinggi mendukung pertumbuhan mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan infeksi, sementara air yang tergenang sering kali menjadi tempat berkembang biaknya berbagai vektor penyakit. Selain itu, keberadaan zat alami dan buatan yang terakumulasi di perairan dan tanah juga dapat berdampak pada sistem saraf dalam jangka panjang.

Salah satu dampak lingkungan lahan basah terhadap kesehatan saraf adalah meningkatnya risiko infeksi yang menyerang sistem saraf pusat. Air yang tergenang menjadi habitat bagi berbagai bakteri dan parasit yang dapat menyebabkan infeksi otak, seperti meningitis dan ensefalitis. Selain itu, kelembapan tinggi dan banyaknya vegetasi di sekitar perairan menjadikan daerah ini sebagai tempat yang ideal bagi serangga seperti nyamuk, yang dapat menularkan penyakit yang berpengaruh pada sistem saraf. Beberapa spesies nyamuk yang hidup di ekosistem lahan basah membawa virus dan parasit yang dapat menginfeksi otak serta saraf perifer.

Selain infeksi, masyarakat lahan basah juga berisiko mengalami paparan zat beracun yang dapat mengganggu fungsi sistem saraf. Beberapa zat ini berasal dari sumber alami, seperti logam berat yang terkandung dalam tanah dan air, serta dari aktivitas manusia, seperti penggunaan pestisida dalam pertanian atau limbah industri yang mencemari perairan. Paparan zat beracun ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai gangguan neurologis, mulai dari tremor hingga penurunan fungsi kognitif yang serius. Salah satu risiko utama bagi kesehatan saraf di masyarakat lahan basah adalah paparan logam berat, terutama merkuri dan timbal, yang sering ditemukan di perairan yang tercemar. Merkuri dapat terakumulasi dalam rantai makanan, terutama pada ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Paparan merkuri dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, dengan gejala seperti gangguan koordinasi, tremor, kesulitan berbicara, serta gangguan kognitif. Timbal, yang dapat berasal dari limbah industri atau cat yang terlarut dalam air, juga memiliki efek

neurotoksik yang serius, terutama pada anak-anak, dengan dampak seperti penurunan *IQ* dan gangguan perkembangan saraf.

Sumber pencemaran logam berat di lahan basah berasal dari berbagai aktivitas manusia, termasuk pertambangan, limbah industri, dan penggunaan pestisida dalam pertanian rawa. Di beberapa daerah, aktivitas pertambangan emas menggunakan merkuri untuk ekstraksi logam mulia, yang kemudian mencemari sungai dan rawa-rawa (Masruddin & Mulasari, 2021). Limbah industri dari pabrik yang membuang zat kimia berbahaya ke aliran sungai juga berkontribusi terhadap pencemaran air dan tanah. Selain itu, penggunaan pestisida dan herbisida dalam pertanian di wilayah lahan basah dapat mencemari sumber air, menyebabkan paparan bahan kimia yang dapat mengganggu sistem saraf.

Dampak neurotoksik dari logam berat dan zat kimia ini bersifat jangka panjang, dengan gejala yang sering kali baru muncul setelah paparan bertahun-tahun. Gangguan neurologis yang umum akibat paparan ini meliputi penurunan daya ingat, tremor, neuropati perifer, dan gangguan motorik. Selain itu, anak-anak yang terpapar sejak usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan otak serta gangguan perilaku. Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahaya ini, terutama karena pencemaran logam berat dan zat kimia sering kali tidak terlihat secara langsung.

Selain logam berat, pestisida yang digunakan dalam pertanian di lahan basah juga berpotensi menyebabkan gangguan saraf. Pestisida organofosfat dan karbamat, yang sering digunakan untuk mengendalikan hama tanaman, diketahui memiliki efek toksik terhadap sistem saraf dengan cara menghambat enzim yang berperan dalam fungsi saraf normal. Paparan pestisida ini dapat terjadi melalui makanan, air minum, atau langsung melalui kontak kulit saat mengaplikasikannya di ladang. Efek jangka panjang dari paparan pestisida termasuk gangguan memori, penurunan refleks, hingga peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif seperti *Parkinson*. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat di lahan basah untuk memahami bahaya penggunaan bahan kimia ini dan mengadopsi metode pertanian yang lebih ramah lingkungan.

Selain paparan zat beracun, infeksi penyakit juga menjadi faktor utama yang dapat mengganggu sistem saraf masyarakat di lahan basah. Penyakit akibat gigitan nyamuk, seperti malaria dan *Japanese encephalitis*, menjadi ancaman serius di daerah dengan banyak perairan tergenang. Malaria, yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium*, dapat menyebabkan komplikasi berat seperti malaria serebral, di mana parasit menyerang otak dan menyebabkan peradangan yang dapat mengakibatkan kejang, koma, bahkan kematian (Pradana et al., 2021). *Japanese encephalitis*, yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk *Culex*, dapat menyebabkan peradangan otak yang berakibat pada gangguan kesadaran, gangguan motorik, serta kerusakan saraf permanen.

Selain penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, infeksi bakteri dari air yang tercemar juga menjadi ancaman bagi kesehatan saraf masyarakat lahan basah. *Leptospirosis*, yang disebabkan oleh bakteri *Leptospira*, dapat menyebar melalui air yang terkontaminasi urin hewan, seperti tikus. Infeksi ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti meningitis, yang ditandai dengan peradangan selaput otak dan sumsum tulang belakang. Gejala meningitis akibat *leptospirosis* meliputi sakit kepala hebat, leher kaku, kejang, dan gangguan kesadaran yang dapat berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan cepat.

Selain *leptospirosis*, meningitis akibat bakteri dari air kotor, seperti *Neisseria meningitidis* atau *Streptococcus pneumoniae*, juga merupakan ancaman bagi masyarakat yang sering bersentuhan dengan air tercemar. Infeksi ini biasanya terjadi akibat konsumsi atau kontak dengan air yang mengandung bakteri patogen. Meningitis bakteri dapat menyebabkan kerusakan saraf yang permanen, termasuk gangguan pendengaran, kelumpuhan, hingga keterbelakangan mental pada anak-anak.

Secara keseluruhan, lingkungan lahan basah memberikan berbagai tantangan bagi kesehatan saraf masyarakat, baik melalui paparan zat beracun maupun infeksi penyakit. Upaya mitigasi, seperti pengelolaan limbah yang lebih baik, penggunaan pestisida yang lebih aman, serta peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko gangguan persyarafan di wilayah ini. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran dan infeksi serta

cara pencegahannya sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat lahan basah, seperti pola konsumsi (makanan khas, air, dan kebiasaan hidup) terhadap kesehatan saraf.

C. Pola Konsumsi (Makanan Khas, Air, dan Kebiasaan Hidup) Terhadap Kesehatan Syaraf

Masyarakat lahan basah memiliki pola konsumsi yang sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama ikan air tawar dan tanaman yang tumbuh di rawa, yang menjadi sumber utama kebutuhan gizi mereka (Rahman et al., 2022). Ikan tidak hanya menyediakan protein penting, tetapi juga asam lemak esensial yang berperan dalam kesehatan saraf, sehingga mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu ikan yang banyak dikonsumsi adalah ikan gabus, yang dikenal karena kandungan albumin yang tinggi. Albumin ini berperan dalam proses penyembuhan jaringan, termasuk dalam regenerasi sel-sel saraf yang rusak. Selain itu, kandungan omega-3 pada ikan gabus berkontribusi dalam menjaga fungsi kognitif, serta mencegah kerusakan saraf akibat peradangan atau proses penuaan.

Konsumsi ikan gabus secara teratur memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan masyarakat lahan basah, namun risiko kontaminasi dari perairan tercemar tetap menjadi perhatian. Perairan yang terkontaminasi oleh logam berat, seperti merkuri, dapat berdampak negatif pada kesehatan saraf masyarakat yang mengonsumsi ikan dari perairan tersebut (Rahman et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk memastikan kualitas air tetap terjaga guna mengurangi risiko paparan logam berat yang berbahaya. Tanaman rawa, seperti kangkung, yang sering dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat, juga berpotensi menyerap zat-zat beracun dari lingkungan. Hal ini menambah urgensi untuk menjaga kebersihan ekosistem lahan basah demi kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat setempat.

Selain ikan gabus, ikan lele juga menjadi bagian dari pola makan masyarakat lahan basah karena mudah dibudidayakan dan memiliki harga yang terjangkau. Lele mengandung protein tinggi yang mendukung regenerasi sel, tetapi ada risiko kontaminasi logam berat seperti merkuri dan timbal pada ikan yang hidup di perairan tercemar. Logam berat dapat terakumulasi di dalam tubuh ikan dan berpindah ke manusia melalui konsumsi, yang dapat menyebabkan gangguan sistem saraf seperti tremor, penurunan fungsi

kognitif, hingga neuropati. Oleh karena itu, konsumsi ikan dari perairan alami perlu diimbangi dengan upaya pemantauan kualitas air dan pola budidaya yang lebih aman.

Selain ikan, masyarakat lahan basah juga mengonsumsi sayuran rawa, seperti kangkung rawa dan purun, yang menjadi bagian penting dari pola makan sehari-hari. Kangkung rawa sering dikonsumsi sebagai sumber serat dan vitamin, yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan dan imunitas tubuh. Namun, jika tanaman ini tumbuh di lingkungan yang tercemar, seperti perairan dengan kandungan logam berat, maka tanaman ini dapat menyerap zat beracun seperti timbal dan arsenik dari air dan tanah. Akumulasi logam berat dalam sayuran ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan saraf, terutama jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Beberapa efek kesehatan yang mungkin terjadi termasuk penurunan daya ingat, gangguan perkembangan saraf pada anak-anak, hingga risiko penyakit saraf yang lebih serius di kemudian hari.

Purun, sebagai tanaman rawa lainnya, sering dimanfaatkan untuk kerajinan tangan atau tikar tradisional, tetapi juga memiliki potensi dikonsumsi sebagai bahan makanan di beberapa daerah. Meskipun penggunaannya tidak sebesar kangkung, perhatian terhadap kualitas lingkungan tempat tanaman ini tumbuh tetap penting. Sama seperti kangkung rawa, purun dapat menyerap zat-zat berbahaya dari lingkungannya, yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia jika tidak diawasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menjaga kualitas air dan tanah di sekitar lahan basah guna meminimalkan risiko paparan zat beracun melalui konsumsi tanaman dan ikan. Edukasi tentang keamanan pangan dan pemantauan lingkungan juga sangat diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat yang tinggal di ekosistem lahan basah.

Selain dimanfaatkan sebagai bahan makanan, tanaman liar seperti purun juga memiliki potensi dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Beberapa jenis purun dimanfaatkan sebagai bahan baku anyaman untuk kerajinan tangan, sementara ekstraknya mulai diteliti karena kandungan bioaktifnya yang berpotensi sebagai antiinflamasi dan antimikroba. Dengan pemanfaatan yang tepat, tanaman liar dari lahan basah dapat memberikan manfaat ganda

bagi masyarakat, baik dalam aspek kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi.

Meski demikian, pemanfaatan tanaman liar tetap memerlukan perhatian terhadap faktor lingkungan dan keberlanjutan. Pencemaran air dan tanah akibat aktivitas industri atau pertanian dapat meningkatkan risiko akumulasi logam berat atau zat berbahaya dalam tanaman ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dan regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan konsumsi serta keberlanjutan.

Air yang dikonsumsi masyarakat lahan basah berasal dari berbagai sumber, termasuk air sungai dan air gambut. Air gambut memiliki tingkat keasaman yang tinggi dan kandungan zat organik yang berlebihan. Konsumsi air dengan keasaman tinggi dapat mempengaruhi sistem saraf dengan mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh, yang berdampak pada fungsi saraf dan otot. Jika tidak diolah dengan baik, air gambut juga dapat mengandung bakteri patogen yang berisiko menyebabkan infeksi dan gangguan kesehatan lainnya.

Selain air gambut, sebagian masyarakat masih mengandalkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Air sungai di beberapa wilayah telah mengalami pencemaran akibat aktivitas industri, pertambangan, dan pertanian, yang meningkatkan risiko terpapar logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Logam berat yang masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi air tercemar dapat merusak sistem saraf dengan cara menghambat fungsi neurotransmitter, merusak sel-sel otak, dan meningkatkan risiko gangguan neurologis seperti gangguan memori dan kesulitan berkonsentrasi. Oleh karena itu, akses terhadap sumber air bersih menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan saraf masyarakat lahan basah.

Selain pola makan dan konsumsi air, kebiasaan hidup masyarakat lahan basah juga berpengaruh terhadap kesehatan saraf. Salah satu kebiasaan yang umum ditemukan adalah konsumsi alkohol tradisional, seperti tuak dan arak Banjar. Minuman ini dibuat dari fermentasi bahan alami dan sering dikonsumsi dalam acara adat maupun sebagai bagian dari pergaulan sosial. Namun, konsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan dapat berdampak negatif pada sistem saraf. Alkohol memiliki efek neurotoksik yang dapat merusak sel-

sel otak, menyebabkan gangguan koordinasi, serta meningkatkan risiko neuropati perifer. Dalam jangka panjang, konsumsi alkohol berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan fungsi kognitif dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif seperti demensia.

Selain konsumsi alkohol, masyarakat lahan basah juga memiliki kebiasaan merokok dengan daun nipah. Daun nipah sering digunakan sebagai bahan pembungkus tembakau lokal, yang kemudian dikonsumsi dalam bentuk rokok tradisional. Kandungan nikotin dalam tembakau memiliki efek langsung terhadap sistem saraf, yaitu dengan merangsang pelepasan dopamin yang memberikan efek sementara berupa rasa tenang dan peningkatan kewaspadaan. Namun, dalam jangka panjang, paparan nikotin dapat menyebabkan kecanduan, gangguan tidur, serta peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif. Selain itu, bahan kimia lain dalam asap rokok dapat menyebabkan stres oksidatif yang mempercepat kerusakan sel saraf. Secara keseluruhan, pola konsumsi masyarakat lahan basah memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan saraf. Konsumsi ikan dan sayuran rawa dapat memberikan manfaat jika dikonsumsi dengan bijak, tetapi risiko kontaminasi logam berat perlu diwaspadai. Sumber air yang digunakan juga menentukan tingkat paparan terhadap zat berbahaya yang dapat mempengaruhi sistem saraf. Selain itu, kebiasaan hidup seperti konsumsi alkohol dan merokok turut menjadi faktor risiko yang dapat berdampak negatif dalam jangka panjang. Upaya edukasi dan peningkatan akses terhadap sumber makanan dan air yang lebih aman menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan saraf masyarakat di wilayah lahan basah. Kebiasaan kerja dan risiko ergonomis di lingkungan lahan basah.

D. Kebiasaan Kerja dan Risiko Ergonomis di Lingkungan Lahan Basah

Masyarakat yang tinggal di lahan basah sering kali bergantung pada sumber daya alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama dalam hal makanan dan pekerjaan (Fedele et al., 2021). Selain ikan, sayuran seperti kangkung rawa menjadi sumber pangan penting, tetapi juga berisiko terkontaminasi oleh logam berat yang terakumulasi di tanah atau air yang tercemar. Paparan logam berat seperti timbal dan merkuri dari makanan dapat berdampak buruk pada kesehatan saraf, terutama pada anak-anak yang lebih rentan terhadap gangguan perkembangan neurologis. Selain itu, pekerjaan di lahan basah, seperti menangkap ikan atau bercocok tanam di

rawa, menuntut tenaga fisik yang besar dan sering dilakukan dalam kondisi yang ekstrem, seperti paparan air dingin dan kelembapan tinggi. Kondisi ini meningkatkan risiko kelelahan fisik dan masalah saraf seperti neuropati perifer, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja dengan optimal.

Tantangan lain yang dihadapi masyarakat lahan basah adalah paparan bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam pertanian atau yang merembes ke lingkungan dari aktivitas industri. Pestisida dan herbisida yang digunakan untuk melindungi tanaman dapat meresap ke air dan tanah, sehingga meningkatkan risiko paparan zat neurotoksik bagi penduduk sekitar. Dalam jangka panjang, paparan bahan kimia ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat, seperti penurunan daya ingat, tremor, dan bahkan kerusakan otak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam pengelolaan lingkungan dan edukasi kesehatan bagi masyarakat lahan basah untuk mengurangi risiko paparan terhadap faktor-faktor yang berbahaya bagi kesehatan saraf. Edukasi mengenai bahaya bahan kimia serta pemantauan kualitas lingkungan harus menjadi prioritas dalam upaya menjaga kesehatan mereka.

Di samping itu, kebiasaan konsumsi makanan instan dan kurangnya variasi dalam pola makan juga dapat memperburuk kondisi kesehatan nelayan. Banyak nelayan yang lebih memilih makanan praktis dengan kandungan gizi rendah karena keterbatasan waktu dan akses terhadap bahan makanan segar selama melaut. Pola makan yang kurang seimbang ini tidak hanya berisiko menyebabkan defisiensi vitamin dan mineral penting, tetapi juga meningkatkan potensi penyakit metabolik seperti diabetes dan hipertensi, yang turut berkontribusi terhadap gangguan saraf.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya edukasi dan penyediaan akses pangan yang lebih baik bagi komunitas nelayan. Program intervensi gizi, seperti penyuluhan tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang dan penyediaan suplemen bagi kelompok berisiko, dapat membantu mencegah dampak negatif dari kekurangan nutrisi. Selain itu, inovasi dalam penyimpanan dan distribusi bahan makanan segar di lingkungan nelayan dapat mendukung perbaikan pola makan dan meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.

Sementara itu, petani lahan basah juga menghadapi risiko neurologis akibat paparan pestisida dan herbisida. Penggunaan bahan kimia ini dalam pertanian rawa dapat berdampak pada sistem saraf jika tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai. Pestisida tertentu, seperti organofosfat dan karbamat, diketahui memiliki efek neurotoksik yang dapat menyebabkan gangguan memori, tremor, hingga gangguan fungsi motorik. Petani yang terpapar pestisida secara langsung melalui kulit atau pernapasan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gejala neurologis, seperti sakit kepala kronis, kelemahan otot, dan gangguan sensorik.

Paparan pestisida dalam jangka panjang dapat menyebabkan akumulasi zat beracun dalam tubuh, yang mengganggu fungsi sistem saraf dan mempercepat proses degenerasi sel saraf. Beberapa jenis pestisida diketahui memiliki efek neurotoksik yang dapat merusak neurotransmitter, menghambat enzim penting dalam fungsi otak, serta memicu peradangan kronis yang berkontribusi terhadap kerusakan saraf. Masyarakat yang tinggal di daerah pertanian atau pesisir dengan intensitas penggunaan pestisida tinggi berisiko lebih besar mengalami gangguan ini, terutama jika sumber air yang mereka gunakan telah terkontaminasi.

Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan upaya mitigasi yang mencakup pengawasan ketat terhadap penggunaan pestisida, penerapan metode pertanian ramah lingkungan, serta edukasi masyarakat tentang dampak kesehatan dari paparan pestisida. Alternatif seperti penggunaan pestisida nabati, rotasi tanaman, dan pengelolaan hama secara biologi dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia berbahaya. Selain itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi kelompok rentan, seperti petani dan masyarakat yang bergantung pada sumber air terkontaminasi, penting dilakukan untuk mendeteksi dini dampak neurotoksik dan mencegah komplikasi jangka panjang.

Selain paparan lingkungan dan bahan kimia, posisi kerja masyarakat lahan basah juga berkontribusi terhadap risiko gangguan saraf. Banyak pekerjaan yang dilakukan dalam posisi yang kurang ergonomis, seperti membungkuk terlalu lama saat mencari ikan atau menanam padi di rawa. Posisi ini dapat menyebabkan tekanan berlebihan pada saraf tulang belakang, yang berujung pada nyeri saraf dan gangguan postur tubuh. Dalam jangka

panjang, kebiasaan ini dapat menyebabkan radikulopati lumbal, yaitu gangguan saraf yang menyebabkan nyeri menjalar dari punggung bawah hingga ke kaki.

Pekerjaan manual yang dilakukan secara berulang, seperti menjaring ikan atau menanam padi, juga dapat meningkatkan risiko *carpal tunnel syndrome* (CTS). Kondisi ini terjadi akibat tekanan berulang pada saraf median di pergelangan tangan, yang menyebabkan kesemutan, nyeri, dan kelemahan otot di tangan. Bagi nelayan dan petani yang mengandalkan kekuatan tangan untuk bekerja, CTS dapat mengganggu produktivitas serta menurunkan kualitas hidup.

Beban fisik yang tinggi dalam pekerjaan sehari-hari juga meningkatkan risiko cedera punggung akibat mengangkat beban berat. Nelayan yang sering membawa hasil tangkapan atau mengangkat jaring dalam jumlah besar berisiko mengalami hernia diskus, yang dapat menyebabkan tekanan pada saraf tulang belakang. Begitu pula dengan petani yang harus mengangkat beban berat di lahan basah dengan pijakan yang tidak stabil, yang dapat meningkatkan risiko cedera akibat keseimbangan tubuh yang terganggu.

Selain aktivitas fisik yang berat, beberapa pekerjaan di lingkungan lahan basah juga melibatkan posisi duduk dalam waktu lama, seperti saat mengemudikan perahu atau kelotok. Posisi duduk yang tidak ergonomis dalam waktu lama dapat menyebabkan tekanan pada saraf siatik, yang mengarah pada kondisi yang dikenal sebagai *sciatica*. *Sciatica* ditandai dengan nyeri yang menjalar dari punggung bawah hingga ke kaki akibat kompresi saraf siatik. Kondisi ini sering dialami oleh nelayan atau pekerja transportasi air yang harus berada dalam posisi statis untuk waktu yang lama. Jika tidak segera ditangani, nyeri tersebut dapat memburuk dan mengganggu mobilitas serta produktivitas kerja.

Secara keseluruhan, kebiasaan kerja masyarakat lahan basah membawa berbagai tantangan bagi kesehatan saraf. Paparan lingkungan yang ekstrem, seperti suhu dingin dan kelembapan tinggi menjadi faktor utama yang memengaruhi fungsi saraf, terutama pada sistem saraf perifer. Selain itu, penggunaan bahan kimia beracun, seperti pestisida dan herbisida, dapat meningkatkan risiko kerusakan saraf pusat akibat paparan jangka panjang.

Kombinasi antara aktivitas fisik yang berat, paparan bahan kimia, dan posisi kerja yang tidak ergonomis menciptakan kondisi ideal bagi gangguan neurologis. Masyarakat yang bergantung pada ekosistem lahan basah untuk mencari nafkah berisiko tinggi terhadap masalah ini.

Langkah-langkah pencegahan harus diterapkan untuk melindungi masyarakat lahan basah dari gangguan kesehatan saraf yang lebih serius. Salah satu solusi adalah dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ergonomi dalam pekerjaan, terutama bagi mereka yang sering duduk dalam posisi yang tidak nyaman. Penggunaan alat pelindung diri saat bekerja di lingkungan yang ekstrem juga penting untuk meminimalkan risiko cedera saraf. Selain itu, pengelolaan limbah dan bahan kimia yang lebih baik perlu menjadi prioritas utama untuk mencegah paparan neurotoksin. Edukasi yang tepat mengenai keselamatan kerja juga dapat membantu mengurangi risiko gangguan neurologis.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, masyarakat lahan basah dapat tetap produktif tanpa mengorbankan kesehatan saraf mereka. Pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan edukasi kesehatan yang berkelanjutan harus menjadi fokus dalam upaya peningkatan kualitas hidup di wilayah ini. Keselamatan kerja, terutama terkait posisi tubuh dan paparan lingkungan, perlu mendapatkan perhatian lebih. Dukungan dari pemerintah dan organisasi lokal sangat diperlukan untuk memperkuat upaya ini. Hanya dengan pendekatan holistik, risiko gangguan neurologis di masyarakat lahan basah dapat diminimalkan.

E. Genetik dan Predisposisi Gangguan Persyarafan

Faktor genetik berperan penting dalam berbagai gangguan persyarafan, termasuk yang ditemukan di masyarakat lahan basah. Beberapa penyakit saraf memiliki komponen hereditas yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu contoh adalah neuropati hereditas, seperti *Charcot-Marie-Tooth* (CMT), yang menyebabkan kelemahan otot progresif dan hilangnya fungsi sensorik di tangan serta kaki. Penyakit ini terjadi akibat mutasi genetik yang memengaruhi mielin atau akson saraf, mengakibatkan gangguan transmisi sinyal saraf.

Selain neuropati hereditas, epilepsi juga dapat memiliki faktor genetik yang meningkatkan risiko seseorang mengalami kejang. Mutasi pada gen yang mengatur aktivitas neuron, seperti SCN1A dan GABRA1, dapat menyebabkan gangguan keseimbangan eksitasi dan inhibisi di otak, sehingga individu menjadi lebih rentan mengalami kejang. Di masyarakat lahan basah, di mana akses terhadap layanan kesehatan masih terbatas, penderita epilepsi mungkin menghadapi tantangan dalam mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat, sehingga meningkatkan risiko komplikasi jangka panjang.

Selain penyakit yang diwariskan, faktor genetik juga dapat memengaruhi kerentanan atau resistensi seseorang terhadap neurotoksin. Beberapa individu memiliki varian gen tertentu yang membuat mereka lebih rentan terhadap paparan logam berat, seperti merkuri atau timbal, yang sering ditemukan di lingkungan lahan basah akibat pencemaran industri atau aktivitas pertambangan. Gen yang mengkode enzim detoksifikasi, seperti GSTM1 dan GSTT1, berperan dalam mengeliminasi zat beracun dari tubuh. Individu dengan mutasi pada gen-gen ini mungkin mengalami akumulasi racun lebih cepat, meningkatkan risiko gangguan saraf seperti tremor, gangguan kognitif, dan neuropati perifer.

Sebaliknya, beberapa individu memiliki variasi genetik yang memberikan perlindungan terhadap efek neurotoksin. Misalnya, varian pada gen MT (*metallothionein*) dapat meningkatkan kapasitas tubuh dalam mengikat dan mengeluarkan logam berat, sehingga mengurangi dampak toksik terhadap sistem saraf. Pemahaman terhadap faktor genetik ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan berisiko tinggi.

Selain faktor genetik, kondisi lingkungan juga berperan dalam mempercepat munculnya gangguan saraf pada individu yang memiliki predisposisi genetik. Paparan logam berat dan zat kimia beracun di lahan basah dapat memperburuk kondisi neurologis bagi mereka yang memiliki kecenderungan genetik terhadap gangguan saraf. Misalnya, seseorang dengan riwayat keluarga neuropati perifer akan lebih rentan mengalami gejala yang lebih parah jika terpapar pestisida atau logam berat dalam jangka waktu lama.

Interaksi antara faktor genetik dan lingkungan juga terlihat pada penyakit neurodegeneratif, seperti *Parkinson* dan *Alzheimer*. Studi menunjukkan bahwa individu dengan mutasi pada gen LRRK2 atau SNCA memiliki risiko lebih tinggi terkena *Parkinson*, terutama jika mereka juga terpapar bahan kimia seperti insektisida atau herbisida yang sering digunakan dalam pertanian lahan basah. Paparan zat-zat ini dapat memicu stres oksidatif dan peradangan di otak, mempercepat degenerasi neuron dopaminergik yang berperan dalam pengendalian gerakan tubuh (Tsalenchuk et al., 2023).

Di masyarakat lahan basah, terdapat beberapa contoh kasus gangguan saraf yang lebih sering ditemukan karena kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Misalnya, kelelahan kronis dan kelemahan otot yang dialami nelayan dan petani dapat berkaitan dengan neuropati perifer yang diperburuk oleh paparan dingin dan kelembapan tinggi. Pada individu yang secara genetik lebih rentan terhadap gangguan mielin saraf, kondisi lingkungan yang ekstrem dapat mempercepat terjadinya gejala neuropati.

Kasus lain yang dapat diamati adalah kejadian epilepsi yang lebih tinggi di daerah dengan riwayat infeksi sistem saraf, seperti meningitis atau *Japanese encephalitis*, yang umum di wilayah berair. Infeksi tersebut dapat menyebabkan peradangan pada otak, yang berisiko memicu aktivitas listrik abnormal dalam otak dan memicu serangan epilepsi. Individu dengan faktor genetik yang membuat mereka lebih rentan terhadap gangguan eksitasi neuron mengalami gejala epilepsi yang lebih berat setelah terpapar infeksi yang menyerang sistem saraf. Kondisi ini diperburuk oleh lingkungan yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme patogen di lahan basah, yang meningkatkan risiko infeksi sistem saraf. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah berair memiliki risiko lebih besar mengalami gangguan neurologis seperti epilepsi akibat kombinasi faktor genetik dan paparan infeksi.

Selain infeksi, paparan racun dari lingkungan juga dapat memperburuk kondisi epilepsi di wilayah lahan basah. Polutan seperti merkuri dan timbal, yang dapat ditemukan dalam air tercemar, memiliki efek neurotoksik yang dapat meningkatkan risiko serangan epilepsi pada individu yang rentan. Logam berat ini dapat terakumulasi dalam tubuh, menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf, dan memicu aktivitas otak yang tidak normal. Akibatnya, individu yang terpapar polutan ini berisiko mengalami serangan epilepsi

yang lebih sering dan lebih berat. Pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan kontrol polusi menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko gangguan saraf di daerah lahan basah.

Dengan memahami interaksi antara genetik dan lingkungan, masyarakat dapat lebih waspada terhadap faktor risiko yang ada di sekitar mereka. Paparan zat beracun dari lingkungan, seperti logam berat dan polutan lainnya, dapat memperburuk kondisi genetik yang mempengaruhi kesehatan saraf. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengidentifikasi sumber-sumber polusi dan mengurangi risiko paparan. Selain itu, peningkatan kesadaran akan faktor-faktor genetik yang dapat memperburuk kondisi kesehatan saraf juga dapat membantu dalam pencegahan dini. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka dan keluarga dari gangguan neurologis yang mungkin timbul.

Upaya mitigasi, seperti pengurangan paparan zat beracun dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dapat membantu mengurangi dampak negatif dari gangguan saraf yang terkait dengan faktor genetik dan lingkungan. Misalnya, program kesehatan yang difokuskan pada deteksi dini gangguan neurologis dapat memberikan intervensi yang lebih cepat dan efektif. Edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan yang bersih juga merupakan bagian dari upaya pencegahan. Selain itu, akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan dapat meningkatkan deteksi dan pengobatan gangguan saraf secara tepat waktu. Dengan kombinasi upaya mitigasi dan peningkatan layanan kesehatan, risiko gangguan neurologis dapat diminimalkan di masyarakat.

F. Penutup

Memahami keterkaitan antara faktor lingkungan dan genetik sangat penting dalam menjaga kesehatan saraf masyarakat lahan basah, karena lingkungan yang lembap dan terpapar zat beracun dapat memperburuk kondisi kesehatan. Faktor-faktor seperti kelembapan tinggi dan risiko infeksi memberikan tantangan tersendiri yang secara langsung mempengaruhi sistem saraf. Di sisi lain, individu dengan predisposisi genetik terhadap gangguan neurologis menghadapi risiko yang lebih besar jika tinggal di lingkungan yang kurang mendukung. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat

terhadap faktor-faktor risiko ini harus ditingkatkan melalui edukasi yang tepat, sehingga mereka dapat melakukan upaya pencegahan. Sinergi antara pemahaman genetik dan lingkungan menjadi dasar penting untuk melindungi kesehatan saraf.

Selain itu, kombinasi antara faktor lingkungan yang tidak sehat dan genetik dapat mempercepat munculnya gangguan saraf yang lebih parah, seperti kerusakan saraf akibat paparan logam berat atau infeksi. Paparan terhadap zat beracun dan kualitas air yang buruk meningkatkan risiko terkena penyakit saraf, terutama bagi individu yang secara genetik lebih rentan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan tindakan mitigasi, seperti pengelolaan limbah dan pemantauan kualitas air, agar dampak negatif terhadap kesehatan saraf dapat diminimalisir. Masyarakat juga perlu diberikan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai untuk mencegah atau mengobati gangguan saraf lebih dini. Dengan langkah-langkah ini, risiko gangguan neurologis dapat ditekan, dan kualitas hidup masyarakat lahan basah dapat meningkat secara signifikan.

Upaya mitigasi terhadap paparan zat beracun dan infeksi menjadi langkah penting dalam mencegah gangguan saraf pada masyarakat yang tinggal di daerah lahan basah. Pengelolaan limbah yang efisien serta pemantauan kualitas air perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan tidak adanya kontaminasi bahan berbahaya. Selain itu, pengendalian vektor penyakit seperti nyamuk juga harus ditingkatkan, mengingat peran mereka dalam menyebarkan infeksi yang dapat mempengaruhi sistem saraf. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya logam berat seperti merkuri dan timbal juga penting, agar mereka dapat lebih berhati-hati dalam mengonsumsi sumber pangan dari lingkungan yang tercemar. Dengan langkah-langkah ini, risiko gangguan saraf, terutama bagi kelompok rentan, dapat ditekan secara signifikan.

Selain pengelolaan lingkungan, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan juga harus ditingkatkan untuk deteksi dini dan penanganan gangguan saraf. Pemeriksaan rutin terhadap paparan logam berat dan infeksi yang mempengaruhi sistem saraf perlu dilakukan, terutama di wilayah yang memiliki riwayat kontaminasi. Masyarakat juga perlu didorong untuk mengadopsi gaya hidup sehat, termasuk mengonsumsi makanan yang kaya

nutrisi dan minim risiko kontaminasi. Dengan adanya sinergi antara upaya pengelolaan lingkungan dan peningkatan layanan kesehatan, kualitas hidup masyarakat di daerah lahan basah dapat meningkat, dan ancaman gangguan saraf dapat diminimalkan.

Di samping itu, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan sangat penting untuk deteksi dini dan penanganan gangguan neurologis, terutama di daerah lahan basah yang rentan terhadap berbagai penyakit. Pemerintah dan lembaga kesehatan harus berkolaborasi dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan mampu menangani kondisi khusus yang dihadapi oleh masyarakat, seperti paparan zat beracun dan infeksi. Program kesehatan berbasis lingkungan tidak hanya akan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan saraf, tetapi juga memberikan mereka pengetahuan tentang cara mencegah paparan risiko. Penyediaan layanan kesehatan yang tepat waktu, dengan tenaga medis yang memahami karakteristik unik daerah tersebut, akan membantu mengurangi komplikasi yang timbul akibat infeksi atau paparan bahan kimia berbahaya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat lahan basah dapat meningkat secara signifikan.

Lebih jauh lagi, kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya mitigasi terhadap faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan saraf. Program pencegahan penyakit berbasis komunitas dapat dirancang untuk mendeteksi masalah neurologis sejak dini dan memberikan penanganan yang sesuai sebelum kondisi kesehatan memburuk. Selain itu, pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka, seperti pengelolaan limbah yang baik dan pengendalian vektor penyakit, dapat membantu meminimalkan risiko infeksi dan paparan zat berbahaya. Pengintegrasian pengetahuan lokal dengan pendekatan medis modern akan menciptakan sistem kesehatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lahan basah. Dengan demikian, sinergi antara berbagai pihak ini akan menjadi fondasi kuat bagi tercapainya lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pekerja lahan basah seperti nelayan dan petani rawa juga menghadapi risiko besar akibat aktivitas fisik yang berat dan kondisi kerja yang tidak ergonomis. Posisi kerja yang kurang baik dan paparan suhu dingin dalam waktu lama dapat memicu gangguan saraf, seperti *sciatica* dan *neuropati perifer*. Edukasi tentang teknik kerja yang ergonomis dan penggunaan alat pelindung diri menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko tersebut. Dengan bantuan teknologi, seperti penggunaan peralatan kerja yang lebih baik, dampak negatif dari kondisi kerja yang ekstrem ini bisa ditekan. Hal ini akan membantu menjaga produktivitas pekerja sambil melindungi kesehatan saraf mereka.

Di sisi lain, pentingnya konsumsi pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat lahan basah tidak boleh diabaikan, karena sumber pangan mereka seringkali terpapar berbagai zat berbahaya. Ikan air tawar dan sayuran rawa, yang menjadi komponen utama dalam pola makan masyarakat setempat, sering kali mengandung logam berat seperti merkuri dan timbal yang berasal dari pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan kualitas pangan secara berkala dan edukasi mengenai cara memasak yang aman untuk mengurangi paparan zat-zat berbahaya ini. Selain itu, memperkenalkan sumber makanan alternatif yang lebih aman dan kaya gizi, seperti budidaya ikan yang lebih terkontrol atau sayuran organik, dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa harus menghadapi risiko kontaminasi. Dengan cara ini, kesejahteraan gizi masyarakat dapat terjaga, sekaligus meminimalkan risiko gangguan kesehatan saraf akibat kontaminasi lingkungan.

Langkah-langkah pencegahan seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat lahan basah dapat terus bergantung pada sumber daya alam mereka tanpa mengorbankan kesehatan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan fasilitas untuk mendukung praktik konsumsi pangan yang lebih aman. Selain itu, melalui program pemberdayaan masyarakat, penting untuk mengajarkan mereka cara mengidentifikasi dan menghindari sumber pangan yang terkontaminasi.

Edukasi mengenai pentingnya diversifikasi makanan juga harus diprioritaskan agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada satu jenis sumber pangan yang mungkin berisiko tinggi. Dengan kombinasi upaya dari berbagai pihak, masyarakat lahan basah dapat tetap menikmati sumber daya alam mereka secara aman dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, upaya peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan lingkungan yang lebih baik, dan akses layanan kesehatan yang memadai sangatlah penting dalam melindungi kesehatan saraf masyarakat lahan basah. Sinergi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Edukasi dan intervensi yang tepat akan membantu mengurangi risiko gangguan saraf dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah yang tepat, tantangan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat lahan basah dapat diatasi secara efektif. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan kesehatan mereka dalam jangka panjang.

G. Referensi

- Annisa, M., & Prastitasari, H. (2021). Kajian Aspek Biologi Ekonomi Lahan Basah Di Kalimantan Selatan. *Elementary School Journal*, 11(1), 31–39.
- Fedele, G., Donatti, C. I., Bornacelly, I., & Hole, D. G. (2021). Nature-Dependent People: Mapping Human Direct Use Of Nature For Basic Needs Across The Tropics. *Global Environmental Change*, 71, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102368>
- Masruddin, & Mulasari, S. A. (2021). Gangguan Kesehatan Akibat Pencemaran Merkuri (Hg) pada Penambangan Emas Ilegal. *Jurnal Kesehatan Terpadu*, 12(1), 8–15.
- Pradana, A. A., Pramitaningrum, I. K., Aslam, M., & Anindita, R. (2021). Epidemiologi Penyakit Menular. In *Rajawali Pers*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Rahman, M. M., Farhana, Z., Chowdhury, T. T., Uddin, M. T., Islam, M. Z., & Hamiduzzaman, M. (2022). High Nutritional Vulnerability and Associated Risk Factors of Bangladeshi Wetland Community People Aged 50 Years and Older. *Journal of Ageing and Longevity*, 2(2), 102–112. <https://doi.org/10.3390/jal2020010>
- Syahrin, M. N. Al, & Hamid, I. (2024). *Deteritorialisasi Lingkungan dan Bentuk-Bentuk Alih Fungsi Lahan Basah di Kabupaten Banjar (Studi di Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut)*. 8(2), 827–835.
- Tsalenchuk, M., Gentleman, S. M., & Marzi, S. J. (2023). Linking Environmental Risk Factors With Epigenetic Mechanisms In Parkinson's Disease. *Npj Parkinson's Disease*, 9(1). <https://doi.org/10.1038/s41531-023-00568-z>

Bab 4

Jenis dan Mekanisme Gangguan Persyarafan Pada Masyarakat di Lahan Basah

A. Pendahuluan

Lahan basah merupakan ekosistem unik yang memiliki karakteristik lingkungan spesifik, seperti kelembaban tinggi, tanah berawa, dan keanekaragaman hayati yang khas. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini, termasuk masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Indonesia, berinteraksi erat dengan lingkungan mereka, yang mempengaruhi kesehatan, termasuk sistem persyarafan. Gangguan persyarafan pada masyarakat lahan basah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti paparan neurotoksin lingkungan, infeksi endemik, pola hidup, dan faktor budaya. Paparan lingkungan terhadap zat neurotoksik merupakan salah satu penyebab utama gangguan persyarafan di lahan basah. Penggunaan pestisida dalam pertanian dan kontaminasi air oleh logam berat, seperti merkuri dan timbal, dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf. Penelitian menunjukkan bahwa paparan kronis terhadap pestisida organofosfat dapat mengakibatkan neuropati perifer dan gangguan kognitif. Selain itu, konsumsi ikan yang terkontaminasi merkuri dapat menyebabkan keracunan metilmerkuri, yang berdampak negatif pada sistem saraf pusat (Khiriya et al., 2022).

Infeksi dan penyakit endemik juga berperan signifikan dalam gangguan persyarafan di lahan basah. Penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan leptospirosis umum terjadi di daerah ini dan dapat menyebabkan komplikasi neurologis. Misalnya, malaria serebral dapat mengakibatkan ensefalopati dan kerusakan neurologis permanen. Demam berdarah dapat menyebabkan sindrom syok dengue yang berdampak pada sistem saraf pusat, sementara

leptospirosis dapat menyebabkan meningitis aseptik dan neuropati perifer. Pola hidup masyarakat lahan basah, termasuk kebiasaan dan adat istiadat, dapat mempengaruhi risiko penyakit neurodegeneratif. Faktor seperti pola makan tinggi lemak dan rendah serat, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson. Penelitian menunjukkan bahwa diet tinggi lemak jenuh dan rendah antioksidan dapat mempercepat proses neurodegenerasi. Selain itu, paparan kronis terhadap polutan lingkungan dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit neurodegeneratif (Agianto et al., 2025).

Studi kasus pada masyarakat Banjar menunjukkan bahwa faktor budaya dan lingkungan berperan dalam prevalensi gangguan persyarafan. Misalnya, kebiasaan mengonsumsi ikan mentah dalam hidangan tradisional dapat meningkatkan risiko infeksi parasit yang mempengaruhi sistem saraf. Selain itu, praktik pertanian tradisional yang melibatkan penggunaan pestisida tanpa alat pelindung diri meningkatkan paparan neurotoksin. Kondisi lingkungan yang lembab dan sanitasi yang kurang memadai juga meningkatkan risiko infeksi yang dapat mempengaruhi sistem saraf. Pentingnya pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan persyarafan di lahan basah tidak dapat diabaikan. Upaya pencegahan dan intervensi harus mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan pola hidup masyarakat setempat. Edukasi mengenai penggunaan pestisida yang aman, peningkatan sanitasi, dan promosi pola hidup sehat dapat mengurangi risiko gangguan persyarafan. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme gangguan persyarafan spesifik pada masyarakat lahan basah dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif (Kurmawati et al., 2023).

Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Pendekatan berbasis komunitas yang menghormati kearifan lokal dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan akan meningkatkan efektivitas intervensi. Selain itu, pelatihan bagi tenaga kesehatan mengenai identifikasi dan manajemen gangguan persyarafan spesifik di lahan basah akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks global, pemahaman tentang gangguan persyarafan di lahan basah dapat memberikan wawasan berharga untuk mengatasi masalah serupa di wilayah

lain. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara negara dengan ekosistem lahan basah dapat mempercepat pengembangan strategi pencegahan dan pengobatan yang efektif. Selain itu, penelitian kolaboratif dapat mengidentifikasi faktor risiko baru dan mekanisme patofisiologi yang mendasari gangguan persyarafan di lingkungan unik ini. Secara keseluruhan, pendekatan multidisiplin yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan kesehatan diperlukan untuk mengatasi gangguan persyarafan pada masyarakat lahan basah. Dengan memahami interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut, kita dapat mengembangkan strategi yang komprehensif dan efektif untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di ekosistem lahan basah. Pentingnya penelitian lebih lanjut tidak dapat diabaikan (Abdurrahman & Dkk, 2022).

Studi epidemiologi yang mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi prevalensi dan insiden gangguan persyarafan di lahan basah. Selain itu, penelitian eksperimental dapat mengungkap mekanisme molekuler dan seluler yang mendasari efek neurotoksin lingkungan dan infeksi endemik pada sistem saraf. Hasil penelitian ini akan menjadi dasar untuk pengembangan intervensi yang lebih efektif dan spesifik. Edukasi masyarakat juga merupakan komponen kunci dalam pencegahan gangguan persyarafan. Program edukasi yang dirancang dengan mempertimbangkan budaya lokal dapat meningkatkan kesadaran tentang risiko paparan neurotoksin dan pentingnya praktik hidup sehat. Misalnya, pelatihan mengenai teknik pertanian yang aman dan higienis dapat mengurangi paparan pestisida dan risiko infeksi. Selain itu, promosi pola makan seimbang dan aktivitas fisik dapat menurunkan risiko penyakit neurodegeneratif (Rachmawati & Herawati, 2022).

B. Penyakit Neurotoksik Akibat Paparan Lingkungan

Penyakit neurotoksik akibat paparan lingkungan merupakan isu kesehatan yang signifikan, terutama di wilayah lahan basah yang dihuni oleh masyarakat dengan budaya tertentu, seperti suku Banjar di Kalimantan Selatan. Lingkungan lahan basah yang khas, ditambah dengan praktik budaya dan kondisi sosial-ekonomi, dapat meningkatkan risiko terpaparnya masyarakat terhadap agen-agen neurotoksik. Salah satu sumber paparan neurotoksik di lingkungan lahan basah adalah penggunaan pestisida dalam pertanian. Masyarakat Banjar yang mengelola lahan rawa lebak secara

tradisional mungkin terpapar pestisida organofosfat dan karbamat yang dapat menghambat enzim asetilkolinesterase, menyebabkan akumulasi asetilkolin dan gangguan transmisi saraf. Gejala yang timbul meliputi kelemahan otot, kejang, dan, pada kasus yang parah, kelumpuhan. Paparan kronis terhadap pestisida juga dikaitkan dengan perkembangan penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson dan Alzheimer (Ortega & Carmona, 2022).

Selain itu, kontaminasi logam berat seperti merkuri dan timbal di lahan basah dapat menjadi sumber neurotoksisitas. Merkuri dapat terakumulasi dalam rantai makanan dan mempengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan tremor, gangguan kognitif, dan ataksia. Timbal, yang sering ditemukan dalam cat lama atau pipa air, dapat menyebabkan gangguan perkembangan saraf pada anak-anak, termasuk penurunan IQ dan masalah perilaku. Paparan terhadap senyawa organik volatil (VOC) dari aktivitas industri atau penggunaan bahan bakar fosil juga dapat mempengaruhi sistem saraf. Inhalasi VOC seperti benzena dan toluena dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, dan, pada paparan tinggi, kerusakan saraf permanen. Masyarakat lahan basah yang tinggal dekat dengan aktivitas industri atau transportasi mungkin memiliki risiko lebih tinggi terhadap paparan ini. Kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai, yang masih ditemukan di beberapa komunitas Banjar, dapat menyebabkan akumulasi bahan kimia berbahaya di lingkungan. Sampah plastik, misalnya, dapat melepaskan ftalat dan *bisfenol A (BPA)* yang bersifat neurotoksik. Paparan terhadap senyawa-senyawa ini dapat mengganggu fungsi neurotransmitter dan perkembangan otak, terutama pada anak-anak (Graham, 2023; Landrigan et al., 2024).

Selain faktor lingkungan, faktor budaya juga berperan dalam risiko paparan neurotoksik. Misalnya, penggunaan obat tradisional yang mengandung logam berat atau tanaman dengan senyawa neurotoksik dapat meningkatkan risiko gangguan saraf. Penting untuk melakukan edukasi dan penelitian lebih lanjut mengenai keamanan penggunaan obat tradisional ini. Pengolahan lahan basah yang tidak tepat, seperti pengeringan lahan gambut untuk pertanian, dapat melepaskan gas-gas beracun seperti hidrogen sulfida dan metilmerkuri. Gas-gas ini dapat menyebabkan iritasi saraf, sakit kepala, dan gangguan pernapasan yang mempengaruhi oksigenasi otak. Oleh karena itu, praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

sangat penting untuk mencegah paparan ini. Paparan terhadap mikroorganisme patogen di lahan basah, seperti bakteri dan jamur yang menghasilkan toksin, juga dapat menyebabkan gangguan saraf. Misalnya, infeksi oleh bakteri *Clostridium botulinum* dapat menyebabkan botulisme, yang ditandai dengan kelemahan otot dan kelumpuhan akibat toksin yang menghambat pelepasan asetilkolin (Gözübatık Çelik et al., 2022).

Konsumsi ikan atau hewan air lainnya yang terkontaminasi oleh toksin lingkungan dapat menjadi jalur paparan neurotoksik. Misalnya, ikan yang terkontaminasi metilmerkuri dapat menyebabkan gangguan perkembangan saraf pada janin dan anak-anak. Oleh karena itu, pemantauan kualitas air dan biota air sangat penting untuk mencegah paparan ini. Paparan terhadap polutan udara seperti partikel halus (PM2.5) dan ozon juga dapat mempengaruhi sistem saraf. Inhalasi polutan ini dapat menyebabkan peradangan sistemik yang mempengaruhi fungsi otak, meningkatkan risiko stroke dan penyakit neurodegeneratif. Masyarakat lahan basah yang terpapar asap kebakaran hutan atau aktivitas industri mungkin memiliki risiko lebih tinggi terhadap paparan ini. Penggunaan bahan bangunan yang mengandung asbes di rumah tradisional atau modern dapat menyebabkan paparan serat asbes yang bersifat neurotoksik. Inhalasi serat asbes dapat menyebabkan peradangan dan stres oksidatif di otak, yang berkontribusi pada gangguan kognitif dan penyakit neurodegeneratif (Landrigan et al., 2024).

Paparan terhadap pestisida organoklorin, seperti DDT, yang mungkin masih tersisa di lingkungan lahan basah, dapat menyebabkan gangguan saraf. Senyawa ini bersifat lipofilik dan dapat terakumulasi dalam jaringan lemak, termasuk otak, menyebabkan gangguan neurotransmisi dan neurodegenerasi. Kontaminasi air minum oleh nitrat dari pupuk pertanian dapat menyebabkan *methemoglobinemia*, yang mengurangi kapasitas darah untuk mengangkut oksigen ke otak, menyebabkan hipoksia dan kerusakan saraf. Pengelolaan limbah pertanian yang baik diperlukan untuk mencegah kontaminasi ini. Paparan terhadap bahan kimia rumah tangga, seperti pelarut dan pembersih yang mengandung neurotoksin, dapat menyebabkan gejala neurologis seperti sakit kepala, pusing, dan gangguan memori. Edukasi mengenai penggunaan dan penyimpanan bahan kimia yang aman sangat penting untuk mencegah paparan ini. Paparan terhadap radiasi

elektromagnetik dari infrastruktur telekomunikasi atau peralatan listrik dapat mempengaruhi fungsi saraf. Meskipun bukti ilmiah masih terbatas, beberapa studi menunjukkan kemungkinan pening res oksidatif dan gangguan fungsi saraf akibat paparan radiasi elektromagnetik jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak potensial paparan ini terhadap kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah (Agianto et al., 2025).

Selain itu, perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan dapat memperburuk paparan terhadap agen neurotoksik. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan pelepasan senyawa kimia berbahaya dari tanah dan air, serta mempercepat pertumbuhan mikroorganisme patogen yang menghasilkan neurotoksin. Perubahan curah hujan yang ekstrem juga dapat meningkatkan limpasan pertanian yang mengandung pestisida dan logam berat, sehingga meningkatkan kontaminasi sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, upaya mitigasi dan adaptasi sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko penyakit neurotoksik akibat paparan lingkungan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi peningkatan sistem pemantauan kualitas lingkungan, penguatan regulasi terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya, serta pengembangan teknologi pertanian dan industri yang lebih ramah lingkungan (Syahrin & Hamid, 2021).

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dalam edukasi dan kesadaran lingkungan sangat penting untuk mengurangi paparan terhadap agen neurotoksik. Masyarakat perlu diberikan informasi mengenai bahaya potensial dari bahan kimia dan polutan di lingkungan mereka, serta dilatih dalam praktik-praktik yang dapat mengurangi risiko, seperti penggunaan alat pelindung diri dalam pertanian, pengolahan air yang aman, dan pemilihan bahan bangunan yang tidak beracun. Kebijakan kesehatan masyarakat yang berbasis bukti juga diperlukan untuk menangani dampak penyakit neurotoksik akibat paparan lingkungan. Ini mencakup penguatan layanan kesehatan untuk mendeteksi dini dan mengobati gangguan neurologis akibat toksin lingkungan, serta program surveilans yang dapat mengidentifikasi pola penyakit yang terkait dengan paparan bahan kimia berbahaya di lahan basah. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan

berbasis bukti, diharapkan risiko penyakit neurotoksik akibat paparan lingkungan di masyarakat lahan basah, khususnya di komunitas Banjar, dapat diminimalkan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan melindungi kesehatan individu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah lahan basah (Mustakim & Kas, 2023).

C. Gangguan Persyarafan Akibat Infeksi dan Penyakit Endemik

Gangguan persyarafan akibat infeksi dan penyakit endemik merupakan masalah kesehatan yang signifikan, terutama di wilayah lahan basah yang dihuni oleh masyarakat dengan budaya tertentu, seperti suku Banjar di Kalimantan Selatan. Lingkungan lahan basah yang khas, ditambah dengan praktik budaya dan kondisi sosial-ekonomi, dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi yang berdampak pada sistem saraf. Salah satu penyakit endemik yang dapat mempengaruhi sistem saraf adalah malaria. Malaria disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina. Gejala utama malaria meliputi demam, menggigil, dan sakit kepala. Jika tidak ditangani dengan baik, malaria dapat menyebabkan komplikasi serius seperti malaria serebral, yang ditandai dengan kejang, penurunan kesadaran, dan bahkan koma. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya penanganan dini dan pencegahan malaria untuk mencegah dampak negatif pada sistem saraf (Justiz-Vaillant et al., 2025).

Leptospirosis adalah penyakit *zoonosis* yang disebabkan oleh bakteri *Leptospira*, yang dapat menular melalui kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan yang terinfeksi, seperti tikus. Gejala leptospirosis meliputi demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, dan mata merah. Pada kasus yang parah, bakteri dapat menyerang sistem saraf pusat, menyebabkan meningitis atau komplikasi neurologis lainnya. Wilayah dengan sanitasi yang buruk dan sering mengalami banjir, seperti beberapa daerah di Kalimantan Selatan, memiliki risiko lebih tinggi terhadap leptospirosis (Khurtsilava et al., 2024).

Kusta, atau lepra, adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh *Mycobacterium leprae*. Penyakit ini menyerang kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan atas. Kerusakan saraf akibat kusta dapat menyebabkan mati

rasa, kelemahan otot, dan deformitas jika tidak ditangani dengan tepat. Meskipun prevalensi kusta menurun secara global, beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, masih melaporkan kasus baru setiap tahunnya.

Filariasis, atau penyakit kaki gajah, disebabkan oleh infeksi cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini dapat menyebabkan pembengkakan ekstremitas dan, dalam beberapa kasus, dapat mempengaruhi sistem saraf, menyebabkan nyeri dan disfungsi saraf. Daerah endemis filariasis di Indonesia antara lain adalah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Aceh (Khurtsilava et al., 2024).

Fasciolopsiosis adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing trematoda *Fasciolopsis buski*, yang dapat menginfeksi manusia melalui konsumsi tumbuhan air yang terkontaminasi. Meskipun jarang, infeksi ini dapat menyebabkan gejala gastrointestinal dan, pada kasus yang parah, dapat mempengaruhi sistem saraf melalui mekanisme toksik atau imunologis. Penelitian di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa praktik budaya dan kebiasaan konsumsi tumbuhan air mentah dapat meningkatkan risiko infeksi ini (Sandstrom et al., 2025).

Diare adalah masalah kesehatan yang umum terjadi di masyarakat lahan basah. Infeksi bakteri atau virus yang menyebabkan diare dapat menyebabkan dehidrasi berat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf, menyebabkan kebingungan, kejang, atau bahkan koma jika tidak ditangani dengan tepat. Faktor-faktor seperti sanitasi lingkungan yang buruk, praktik pemberian ASI yang tidak optimal, dan budaya lokal dapat meningkatkan risiko diare pada balita di masyarakat Banjar (Yang et al., 2025).

Penyakit kutu air, atau tinea pedis, adalah infeksi jamur pada kulit kaki yang sering terjadi setelah banjir (Aridamayanti, Agianto, et al., 2024). Meskipun bukan infeksi yang mempengaruhi sistem saraf secara langsung, rasa gatal dan nyeri yang ditimbulkan dapat mengganggu kualitas hidup dan aktivitas sehari-hari. Di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, penyakit ini banyak dikeluhkan oleh warga pascabanjir (Agianto et al., 2022; Aridamayanti, Yakin, et al., 2024).

Penyakit endemik lainnya yang dapat mempengaruhi sistem saraf adalah tuberkulosis (TB). TB disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* dan biasanya menyerang paru-paru, tetapi dapat menyebar ke organ lain, termasuk sistem saraf pusat, menyebabkan meningitis TB. Gejala meningitis TB meliputi sakit kepala, demam, dan perubahan status mental, yang dapat berakibat fatal jika tidak diobati. Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TB tertinggi di dunia (Vilar-Pereira et al., 2024).

Hepatitis, terutama hepatitis B dan C, adalah infeksi virus yang menyerang hati. Pada beberapa kasus, infeksi kronis dapat menyebabkan ensefalopati hepatik, suatu kondisi di mana fungsi otak terganggu akibat akumulasi toksin yang biasanya dinetralkan oleh hati. Gejala ensefalopati hepatik meliputi kebingungan, perubahan perilaku, dan, pada kasus yang parah, koma. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita hepatitis B terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Myanmar. Penyakit demam berdarah dengue (DBD) adalah infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti*. Meskipun jarang, DBD dapat menyebabkan komplikasi neurologis seperti ensefalitis atau sindrom syok dengue, yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. DBD hampir selalu menjadi endemi saat Indonesia memasuki musim penghujan. *Japanese encephalitis* (JE) adalah infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk *Culex tritaeniorhynchus*, yang umum ditemukan di daerah pertanian dan lahan basah. Penyakit ini dapat menyebabkan peradangan pada otak, dengan gejala seperti demam tinggi, kejang, dan perubahan kesadaran. Masyarakat yang tinggal di lahan basah, seperti suku Banjar di Kalimantan Selatan, berisiko lebih tinggi terhadap infeksi ini karena lingkungan mereka mendukung populasi nyamuk vektor. Pencegahan melalui vaksinasi dan pengendalian vektor sangat penting untuk menekan angka kejadian Japanese encephalitis di daerah endemis (Gorris et al., 2023).

Selain infeksi virus, infeksi bakteri lain seperti infeksi *Streptococcus pneumoniae* dan *Neisseria meningitidis* juga dapat menyebabkan meningitis, yaitu peradangan pada selaput otak dan sumsum tulang belakang. Meningitis bakterial memiliki angka kematian yang tinggi jika tidak segera ditangani, dengan gejala seperti demam tinggi, kaku kuduk, fotofobia, dan gangguan kesadaran. Kondisi sosial ekonomi yang rendah dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dapat memperburuk dampak penyakit ini di masyarakat lahan basah. *Schistosomiasis*, atau demam keong, merupakan

penyakit parasit yang disebabkan oleh cacing *Schistosoma* yang berkembang dalam tubuh siput air tawar. Penyakit ini dapat mempengaruhi sistem saraf dengan mekanisme imunologis atau langsung melalui invasi larva ke dalam jaringan saraf. Meskipun lebih banyak ditemukan di Sulawesi Tengah, potensi transmisi schistosomiasis di daerah lahan basah Kalimantan tetap perlu diperhatikan. Rabies adalah penyakit infeksi saraf yang fatal dan disebabkan oleh virus rabies yang ditularkan melalui gigitan hewan yang terinfeksi, seperti anjing dan kelelawar. Penyakit ini menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan gejala neurologis progresif, termasuk hidrofobia, kejang, dan akhirnya koma. Pencegahan dengan vaksinasi pada hewan dan manusia sangat penting, terutama di daerah yang memiliki populasi anjing liar yang tinggi (Kemenkes, 2023).

Infeksi jamur juga dapat berdampak pada sistem saraf, terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah. Misalnya, infeksi *Cryptococcus neoformans* dapat menyebabkan meningitis kriptokokus, yang sering ditemukan pada pasien dengan HIV/AIDS. Penyakit ini dapat menyebabkan sakit kepala kronis, penglihatan kabur, dan gangguan kesadaran jika tidak segera diobati. Penyakit Chikungunya, yang disebabkan oleh virus Chikungunya dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes*, sering kali dikaitkan dengan nyeri sendi yang berkepanjangan. Namun, dalam beberapa kasus, virus ini juga dapat menyebabkan komplikasi neurologis seperti ensefalitis dan neuropati perifer. Dengan meningkatnya urbanisasi dan perubahan lingkungan, risiko penyebaran penyakit ini semakin tinggi di wilayah lahan basah (Kemenkes, 2023).

Leishmaniasis, meskipun lebih umum ditemukan di wilayah tropis tertentu, juga dapat menjadi ancaman potensial bagi masyarakat lahan basah. Infeksi yang disebabkan oleh protozoa dari genus *Leishmania* ini dapat menyerang sistem saraf melalui mekanisme inflamasi dan toksik. Penyakit ini ditularkan oleh gigitan lalat pasir dan dapat menyebabkan komplikasi neurologis pada kasus tertentu. Penyakit yang berkaitan dengan perubahan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, seperti pembukaan lahan gambut, juga berkontribusi terhadap peningkatan penyakit infeksi yang mempengaruhi sistem saraf. Pelepasan gas-gas beracun dan perubahan ekosistem dapat mendukung berkembangnya patogen baru atau meningkatkan populasi vektor penyakit. Pemanasan global dan perubahan iklim juga dapat

memperluas wilayah endemis beberapa penyakit infeksi yang berdampak pada sistem saraf, seperti malaria, DBD, dan schistosomiasis. Peningkatan suhu dan curah hujan yang tidak menentu dapat mempercepat siklus hidup vektor dan meningkatkan penyebaran penyakit ini di daerah yang sebelumnya tidak terdampak (Kemenkes, 2023).

Selain faktor lingkungan dan budaya, akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai menjadi faktor penentu dalam pengendalian penyakit infeksi yang berdampak pada sistem saraf. Wilayah lahan basah yang terpencil sering kali memiliki akses terbatas terhadap layanan medis, vaksinasi, dan obat-obatan, yang meningkatkan risiko komplikasi serius dari penyakit ini. Pencegahan dan pengendalian gangguan persyarafan akibat infeksi dan penyakit endemik memerlukan pendekatan multisektoral. Program vaksinasi, pengendalian vektor, peningkatan sanitasi, serta edukasi kesehatan bagi masyarakat menjadi langkah penting dalam mengurangi beban penyakit ini. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami pola penyebaran penyakit infeksi di lingkungan lahan basah serta faktor-faktor risiko spesifik yang mempengaruhi masyarakat dengan budaya tertentu, seperti suku Banjar. Dengan pendekatan berbasis bukti, diharapkan strategi pencegahan dan pengobatan dapat lebih efektif dalam mengurangi dampak penyakit ini terhadap kesehatan masyarakat (Aridamayanti, Agianto, et al., 2024).

D. Peran Gaya Hidup dalam Memengaruhi Penyakit Neurodegeneratif

Penyakit neurodegeneratif merupakan salah satu tantangan kesehatan yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia harapan hidup manusia. Penyakit ini mencakup berbagai kondisi yang ditandai oleh degenerasi progresif dari sel-sel saraf, yang pada akhirnya menyebabkan gangguan kognitif, motorik, dan otonom. Penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, dan Huntington adalah beberapa contoh utama dari penyakit neurodegeneratif yang berdampak luas pada individu dan masyarakat (Iannaccone et al., 2024; Jahromi et al., 2024).

1. Pengaruh Pola Hidup terhadap Penyakit Neurodegeneratif

Faktor genetik memang memiliki peran dalam penyakit neurodegeneratif, tetapi pola hidup juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan risiko seseorang untuk mengembangkan kondisi ini. Beberapa faktor gaya hidup yang berkontribusi terhadap risiko dan

perkembangan penyakit neurodegeneratif meliputi pola makan, aktivitas fisik, tingkat stres, kualitas tidur, paparan toksin lingkungan, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial dan mental. Pola makan yang sehat sangat berpengaruh terhadap kesehatan otak dan dapat membantu mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif. Diet Mediterania, yang terdiri dari konsumsi tinggi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan, dan minyak zaitun, telah dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit Alzheimer dan Parkinson. Nutrisi seperti asam lemak omega-3 yang ditemukan dalam ikan salmon dan kacang-kacangan memiliki sifat neuroprotektif yang membantu melindungi neuron dari kerusakan oksidatif dan peradangan. Sebaliknya, pola makan yang tinggi lemak jenuh, gula, dan makanan olahan dapat menyebabkan stres oksidatif dan peradangan kronis, yang merupakan faktor risiko utama dalam perkembangan penyakit neurodegeneratif. Konsumsi makanan olahan dan minuman tinggi gula dapat meningkatkan risiko resistensi insulin di otak, yang berhubungan dengan penurunan kognitif.

2. Aktivitas Fisik dan Olahraga

Kurangnya aktivitas fisik telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit Alzheimer dan Parkinson. Aktivitas fisik secara teratur, seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, atau latihan aerobik lainnya, dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan merangsang produksi neurotropin, yang mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel saraf. Olahraga juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi peradangan, yang berkontribusi terhadap perlindungan saraf. Studi telah menunjukkan bahwa individu yang berolahraga secara rutin memiliki risiko lebih rendah mengalami penurunan kognitif dibandingkan mereka yang tidak aktif secara fisik.

3. Stimulasi Mental dan Sosial

Otak adalah organ yang memerlukan stimulasi terus-menerus untuk tetap sehat. Aktivitas seperti membaca, bermain teka-teki silang, belajar bahasa baru, atau bermain alat musik dapat membantu memperkuat koneksi saraf dan menunda onset penyakit neurodegeneratif. Aktivitas sosial juga penting, karena isolasi sosial telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit Alzheimer. Interaksi sosial yang aktif dapat meningkatkan produksi neurotransmitter yang penting untuk fungsi otak, seperti dopamin dan serotonin. Selain itu, keterlibatan dalam komunitas atau

kegiatan sosial dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan.

4. Kebiasaan Merokok dan Konsumsi Alkohol

Merokok telah terbukti meningkatkan risiko penyakit Alzheimer dan Parkinson. Zat beracun dalam rokok dapat menyebabkan peradangan sistemik dan stres oksidatif yang merusak neuron otak. Paparan jangka panjang terhadap nikotin dan zat berbahaya lainnya dalam rokok dapat menyebabkan penurunan volume otak dan gangguan kognitif. Konsumsi alkohol berlebihan juga memiliki efek neurotoksik yang dapat mempercepat degenerasi saraf. Konsumsi alkohol dalam jumlah besar dan berkepanjangan dapat menyebabkan sindrom Wernicke-Korsakoff, suatu kondisi neurologis yang disebabkan oleh defisiensi tiamin akibat konsumsi alkohol yang berlebihan.

5. Manajemen Stres dan Kesehatan Mental

Stres kronis berperan dalam perkembangan penyakit neurodegeneratif melalui peningkatan kadar hormon kortisol yang dapat merusak hippocampus, bagian otak yang bertanggung jawab atas pembelajaran dan memori. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan dalam dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan ketahanan mental. Praktik mindfulness juga dapat membantu individu mengelola stres dengan lebih baik, yang pada akhirnya mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa individu yang secara rutin berlatih meditasi memiliki risiko lebih rendah mengalami penurunan kognitif.

6. Kualitas Tidur dan Dampaknya pada Otak

Tidur yang berkualitas sangat penting untuk kesehatan otak. Selama tidur, otak membersihkan zat beracun seperti beta-amyloid, yang berkontribusi terhadap pembentukan plak Alzheimer. Kurang tidur kronis telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif karena gangguan pada mekanisme detoksifikasi otak. Disarankan untuk tidur selama 7-8 jam setiap malam dan menjaga pola tidur yang konsisten. Kebiasaan tidur yang buruk, seperti sering begadang atau tidur dalam lingkungan yang tidak nyaman, dapat meningkatkan risiko penurunan kognitif.

7. Pengaruh Lingkungan dan Paparan Toksin

Paparan terhadap polusi udara, logam berat seperti timbal dan merkuri, serta pestisida telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit Parkinson dan Alzheimer. Lingkungan yang sehat, dengan akses ke udara

bersih dan makanan bebas kontaminan, sangat penting untuk kesehatan otak. Individu yang tinggal di daerah dengan polusi tinggi atau bekerja di lingkungan yang memiliki paparan bahan kimia berbahaya harus mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti menggunakan masker atau meningkatkan ventilasi di tempat kerja, untuk mengurangi risiko terkena penyakit neurodegeneratif.

Pola hidup memiliki dampak besar terhadap risiko dan progresivitas penyakit neurodegeneratif. Dengan menerapkan pola makan sehat, rutin berolahraga, menjaga stimulasi mental dan sosial, menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, mengelola stres dengan baik, dan memastikan kualitas tidur yang optimal, individu dapat secara signifikan menurunkan risiko terkena penyakit ini. Pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pola hidup sehat. Kampanye edukasi, penyediaan fasilitas olahraga, serta regulasi terhadap polusi dan penggunaan zat beracun merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesehatan otak masyarakat secara luas (Valotto Neto et al., 2024).

E. Gangguan Saraf dalam Konteks Komunitas

Gangguan persyarafan akibat infeksi dan penyakit endemik merupakan masalah kesehatan yang sering dijumpai di masyarakat lahan basah, termasuk komunitas Banjar di Kalimantan Selatan. Faktor lingkungan, seperti paparan air yang terkontaminasi, gigitan serangga vektor penyakit, serta pola hidup yang dipengaruhi oleh budaya setempat, berkontribusi terhadap tingginya prevalensi gangguan neurologis di wilayah ini. Salah satu studi kasus yang menarik adalah seorang laki-laki berusia 42 tahun yang mengalami kelemahan anggota gerak bawah setelah mengalami demam tinggi selama beberapa hari. Pasien ini memiliki riwayat bekerja sebagai petani di daerah rawa dan sering terpapar air banjir (Cordell, 2024).

Pasien datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan utama berupa kelemahan progresif pada kedua tungkai bawah yang disertai kesemutan dan nyeri. Sebelumnya, pasien mengalami demam tinggi, nyeri kepala, serta muntah yang berlangsung selama lima hari. Pemeriksaan fisik menunjukkan refleks tendon yang melemah, tonus otot yang menurun, serta adanya tanda-tanda dehidrasi. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya

leukositosis, peningkatan kadar protein dalam cairan serebrospinal, serta hasil serologi yang positif terhadap infeksi leptospirosis. Berdasarkan temuan klinis dan hasil laboratorium, pasien didiagnosis dengan *Guillain-Barré Syndrome (GBS)* yang dicetuskan oleh infeksi leptospira (Agianto et al., 2025). Dalam diagnosis keperawatan, terdapat beberapa masalah utama yang diidentifikasi, antara lain gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan otot, risiko gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan disfungsi otonom, nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi saraf perifer, dan kecemasan berhubungan dengan perubahan kondisi kesehatan yang mendadak. Diagnosis keperawatan ini menjadi dasar dalam menentukan intervensi yang tepat guna memperbaiki kondisi pasien dan mencegah komplikasi lebih lanjut (Agianto et al., 2025).

Intervensi keperawatan yang dilakukan mencakup berbagai aspek perawatan pasien dengan GBS akibat leptospirosis. Intervensi pertama adalah pemantauan status neurologis secara ketat untuk menilai perkembangan kelemahan otot serta mendeteksi kemungkinan keterlibatan otot pernapasan. Perawat juga memberikan terapi suportif, seperti memastikan keseimbangan cairan dan elektrolit, mengoptimalkan posisi tubuh pasien untuk mencegah dekubitus, serta memberikan latihan rentang gerak pasif guna mencegah kontraktur. Selain itu, manajemen nyeri dilakukan dengan pemberian analgesik sesuai indikasi serta edukasi teknik non-farmakologis, seperti relaksasi dan distraksi (Agianto et al., 2025).

Dalam implementasi intervensi, tim keperawatan bekerja sama dengan tim medis untuk memastikan pemberian antibiotik yang tepat guna mengatasi infeksi leptospira. Pemberian *imunoglobulin intravena (IVIg)* atau plasmaferesis dipertimbangkan sesuai dengan kondisi klinis pasien untuk mempercepat pemulihan fungsi saraf. Terapi rehabilitasi juga mulai diterapkan secara bertahap dengan tujuan mengembalikan fungsi motorik pasien dan mencegah atrofi otot yang berkepanjangan. Intervensi psikososial tidak kalah penting, di mana perawat berperan dalam memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarganya guna meningkatkan motivasi serta kepatuhan terhadap terapi yang diberikan (Agianto et al., 2025).

Evaluasi terhadap intervensi keperawatan menunjukkan adanya perbaikan bertahap pada kondisi pasien. Setelah dua minggu perawatan, pasien mengalami peningkatan kekuatan otot secara perlahan, mulai mampu menggerakkan kaki dengan bantuan, dan nyeri berkurang signifikan. Pasien juga menunjukkan adaptasi yang lebih baik terhadap kondisinya serta memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dibandingkan saat pertama kali dirawat. Pemantauan jangka panjang tetap dilakukan untuk menilai kemungkinan komplikasi serta memberikan dukungan dalam program rehabilitasi (Agianto et al., 2025).

Kasus ini menunjukkan bahwa gangguan persyarafan akibat infeksi endemik di masyarakat lahan basah merupakan permasalahan kesehatan yang kompleks. Faktor lingkungan dan budaya memiliki peran penting dalam meningkatkan risiko terjadinya infeksi yang berdampak pada sistem saraf. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin yang melibatkan tenaga medis, tenaga keperawatan, serta peran aktif dari masyarakat sangat diperlukan untuk menangani serta mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, penggunaan alat pelindung diri saat bekerja di area berisiko, serta akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan akan berkontribusi terhadap pengurangan kejadian gangguan persyarafan akibat penyakit endemik di wilayah lahan basah (Agianto et al., 2025).

F. Penutup

Studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa lingkungan unik lahan basah memberikan tantangan kesehatan yang signifikan, terutama dalam aspek neurologis. Paparan terhadap neurotoksin, infeksi endemik, dan pola hidup yang khas menjadi faktor utama yang mempengaruhi prevalensi gangguan persyarafan di komunitas ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisiplin yang mencakup intervensi medis, edukasi masyarakat, serta kebijakan kesehatan yang berbasis bukti untuk mengatasi permasalahan ini secara holistik.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap gangguan persyarafan di lahan basah adalah paparan lingkungan terhadap zat-zat berbahaya, seperti pestisida, logam berat, dan senyawa organik lainnya. Kontaminasi air dan tanah akibat aktivitas pertanian dan industri meningkatkan risiko

terpaparnya masyarakat terhadap bahan-bahan yang bersifat neurotoksik. Efek jangka panjang dari paparan ini dapat berupa neuropati perifer, gangguan kognitif, hingga penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson dan Alzheimer. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat dalam penggunaan pestisida serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya paparan lingkungan terhadap kesehatan saraf. Selain faktor lingkungan, infeksi endemik yang sering terjadi di wilayah lahan basah juga berkontribusi besar terhadap gangguan persyarafan. Penyakit seperti malaria serebral, leptospirosis, filariasis, dan Japanese encephalitis dapat menyebabkan komplikasi neurologis yang serius, bahkan permanen.

Peran sistem imun dalam merespons infeksi ini sering kali mengarah pada reaksi inflamasi yang berlebihan, yang pada akhirnya berdampak pada sistem saraf pusat maupun perifer. Pencegahan melalui vaksinasi, pengendalian vektor, dan peningkatan sanitasi lingkungan merupakan langkah strategis yang dapat menekan angka kejadian penyakit-penyakit ini. Pola hidup masyarakat lahan basah, termasuk kebiasaan mengonsumsi makanan tertentu dan keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, turut mempengaruhi kejadian gangguan persyarafan. Misalnya, konsumsi ikan yang terkontaminasi merkuri dapat meningkatkan risiko neurotoksisitas, sementara kebiasaan merokok dan pola makan tinggi lemak dapat mempercepat proses neurodegenerasi. Upaya edukasi kesehatan yang berbasis budaya sangat diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya pola makan sehat dan gaya hidup yang lebih baik untuk menjaga kesehatan saraf.

Intervensi medis dalam penanganan gangguan persyarafan harus mempertimbangkan aspek spesifik dari populasi lahan basah. Diagnosis yang cepat dan akurat sangat penting untuk menghindari komplikasi yang lebih berat. Dalam kasus *Guillain-Barré Syndrome* yang diakibatkan oleh infeksi leptospira, misalnya, perawatan suportif yang melibatkan imunoglobulin intravena atau plasmaferesis dapat meningkatkan prognosis pasien secara signifikan. Begitu pula dengan kasus-kasus neuropati akibat paparan lingkungan, yang memerlukan pendekatan farmakologis dan terapi rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi saraf yang optimal.

Kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam upaya penanggulangan gangguan persyarafan di wilayah lahan basah. Pelayanan kesehatan primer harus diperkuat dengan pelatihan tenaga medis mengenai deteksi dini dan penanganan gangguan neurologis yang sering ditemukan di daerah ini. Program kesehatan berbasis komunitas juga harus digalakkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko gangguan persyarafan serta langkah-langkah preventif yang dapat mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya penelitian lebih lanjut dalam memahami gangguan persyarafan di lahan basah tidak dapat diabaikan. Studi epidemiologi diperlukan untuk mengidentifikasi pola kejadian penyakit neurologis serta faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus di wilayah ini. Penelitian eksperimental juga harus terus dilakukan untuk mengungkap mekanisme molekuler dan seluler yang mendasari efek neurotoksin dan infeksi terhadap sistem saraf. Dengan data yang lebih akurat, kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran dapat dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahan basah.

Selain aspek medis, aspek sosial dan ekonomi juga harus dipertimbangkan dalam strategi penanganan gangguan persyarafan. Banyak masyarakat lahan basah yang bekerja sebagai petani atau nelayan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan serta keterbatasan ekonomi yang membuat mereka sulit mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas dengan dukungan dari pemerintah dalam bentuk subsidi kesehatan dan peningkatan infrastruktur kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan layanan yang memadai.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengadopsi pendekatan berbasis bukti dalam setiap intervensi yang dilakukan. Program pencegahan dan pengobatan harus didasarkan pada data ilmiah yang valid serta mempertimbangkan faktor budaya dan sosial masyarakat setempat. Penggunaan teknologi dalam pemantauan kesehatan, seperti sistem surveilans penyakit berbasis digital, dapat membantu mendeteksi tren kejadian gangguan persyarafan lebih awal dan memungkinkan tindakan intervensi yang lebih cepat.

Secara keseluruhan, buku referensi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai gangguan persyarafan di masyarakat lahan basah, khususnya di komunitas Banjar. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti, diharapkan upaya pencegahan, diagnosis, dan penanganan gangguan persyarafan dapat terus ditingkatkan. Kerja sama antara berbagai pihak, termasuk akademisi, tenaga medis, pemerintah, dan masyarakat, sangat penting dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Kesadaran akan pentingnya kesehatan persyarafan harus terus disebarluaskan, baik melalui edukasi formal maupun kampanye kesehatan di tingkat komunitas. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lahan basah dapat lebih memahami risiko yang mereka hadapi dan mampu mengambil langkah-langkah preventif yang lebih baik untuk menjaga kesehatan sistem saraf mereka. Pada akhirnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat di lahan basah akan tercapai melalui pendekatan yang lebih terstruktur dalam menangani gangguan persyarafan yang mereka hadapi.

G. Referensi

- Abdurrahman, & Dkk. (2022). Deteritorialisasi Lingkungan Lahan Basah Di Kabupaten Banjar Studi di Kecamatan Kertak hanyar dan Kecamatan Gambut. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 7(1), 143–149. <http://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/687>
- Agianto, Aridamayanti, B. G., Firdausi, R., Septiany, M., & Hasibuan, N. A. (2025). Perawatan Stroke di Komunitas. In *Nuansa Fajar Cemerlang*.
- Agianto, Herry Setiawan, & Nasri, N. M. (2022). Identifikasi Diagnosis Keperawatan dan Etiologi Pasca Banjir Pada Masyarakat Kalimantan Selatan. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 10(1), 51–63. <https://doi.org/10.20527/jdk.v10i1.104>
- Albarnawi, H. M., Alroqabi, S. M., Ogdi, W. Z., Jalal, A. A., Agdi, J. Z., AL-Eid, H. S., Almutairy, A. K., Alanazi, M. K., Qawfashi, F. Y., & Alhadidi, A. M. (2023). Community nursing interventions for chronic disease management. *International Journal Of Community Medicine And Public Health*, 11(1), 464–468. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20233858>
- Aridamayanti, B. G., Agianto, Septiany, M., Chrisnawati, Khairina, N., Amilia,

- E., Fayza, E. N., & Vebrina, E. (2024). Personal Hygiene pada Masyarakat dengan Keluhan Penyakit Kulit. *Jurnal Dunia Keperawatan*, 12(July), 244–253. <https://doi.org/10.20527/dk.v12i2.660>
- Aridamayanti, B. G., Nurhidayah, S. D., Rahmah, J., Sintia, Humaira, A., Meidiani, Meiliana, D., Amalia, N. P., Amilia, E., Adibah, J. D., Badriah, S., Agustia, Z. A., Rahimi, F., Alisa, R., Kamil, M. R., Hafiz, C., & Ghani, Z. (2024). Manajemen Antisipasi Bencana. *CV. Gita Lentera*, 6.
- Aridamayanti, B. G., Yakin, R., Nisvia, N., & ... (2024). Gambaran Diagnosis dan Intervensi Keperawatan Kerusakan Integritas Kulit pada Masyarakat Terdampak Banjir di Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 15(1), 110–116. <http://www.forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/4194>
- Bicknell, B., Liebert, A., Borody, T., Herkes, G., McLachlan, C., & Kiat, H. (2023). Neurodegenerative and Neurodevelopmental Diseases and the Gut-Brain Axis: The Potential of Therapeutic Targeting of the Microbiome. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(11). <https://doi.org/10.3390/ijms24119577>
- Cordell, G. A. (2024). The contemporary nexus of medicines security and bioprospecting: a future perspective for prioritizing the patient. *Natural Products and Bioprospecting*, 14(1). <https://doi.org/10.1007/s13659-024-00431-5>
- Flynn, B. C. (2024). Community health nursing education. *Annual Review of Nursing Research*, 6, 167–190. <https://doi.org/10.1891/0739-6686.6.1.167>
- Gorris, M. E., Ardon-Dryer, K., Campuzano, A., Castañón-Olivares, L. R., Gill, T. E., Greene, A., Hung, C. Y., Kaufeld, K. A., Lacy, M., & Sánchez-Paredes, E. (2023). Advocating for Coccidioidomycosis to Be a Reportable Disease Nationwide in the United States and Encouraging Disease Surveillance across North and South America. *Journal of Fungi*, 9(1). <https://doi.org/10.3390/jof9010083>
- Gözübatık Çelik, R. G., Toprak, U. E., & Kıran, S. (2022). Neurotoxicological Effects of Environmental and Occupational Agents. *Türk Noroloji Dergisi*, 28(2), 63–72. <https://doi.org/10.4274/tnd.2022.90023>
- Graham, P. (2023). Neurotoxicity of Environmental Pollutants. *European Parliament Directorate-General for Research*, 570(July).
- Iannaccone, P. M., Ryznar, R. J., & Van Winkle, L. J. (2024). Genetics, Epigenetics, and the Environment: Are Precision Medicine, Provider Compassion, and Social Justice Effective Public Health Measures to Mitigate Disease Risk and Severity? *International Journal of*

Environmental Research and Public Health, 21(11), 1–18.
<https://doi.org/10.3390/ijerph21111522>

- Ifansyah, M. N., & Waluya, J. G. (2024). *Keperawatan Komunitas Pendekatan Holistik untuk Perlindungan, Pemberdayaan dan Intervensi Strategis*.
- Jahromi, F., Al Mannai, M., Alabed, A., Alkhlofi, S., Hejres, S., Alromaihi, D., Kumar, P., & Freije, A. (2024). Impact of Dust Events on UV Index and Vitamin D Synthesis in Bahrain and Its Correlation with Population Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels. *Atmosphere*, 15(12).
<https://doi.org/10.3390/atmos15121497>
- Justiz-Vaillant, A., Soodeen, S., Gopaul, D., Arozarena-Fundora, R., Thompson, R., Unakal, C., & Akpaka, P. E. (2025). Tackling Infectious Diseases in the Caribbean and South America: Epidemiological Insights, Antibiotic Resistance, Associated Infectious Diseases in Immunological Disorders, Global Infection Response, and Experimental Anti-Idiotypic Vaccine Candidates Agai. *Microorganisms*, 13(2).
<https://doi.org/10.3390/microorganisms13020282>
- Kapoor, R. (2022). Neurological, psychiatric, and developmental disorders: Meeting the challenge in the developing world Committee on Nervous System Disorders, Board on Global Health, Institute of Medicine. Washington DC. In *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene* (Vol. 96, Issue 3).
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0035920302901161>
- Kemenkes, R. (2023). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Hanta di Indonesia. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 1–23.
- Khiriyati, L., Marlinae, L., Waskito, A., Rahmat, A. N., & Ma'aruf, M. A. (2022). *Buku Ajar Pengantar Lingkungan Lahan Basah*.
- Khurtsilava, I., kanjaradze, D., Tsirdava, N., Parulava, T., & Darsania, I. (2024). Rare Presentation of Pediatric Nervous System Lyme Disease: A Case Report. *Cureus*, 16(5). <https://doi.org/10.7759/cureus.60535>
- Kurmalawati, R., Ir Meldi Septiana, Ms., Norma Yuni Kartika, Ms., & Aiga, D. (2023). *Studi Kasus Utama Lingkungan Lahan Basah Suku Banjar di Kalimantan Selatan*.
- Landrigan, P. J., Graham, D. G., & Thomas, R. D. (2024). Environmental neurotoxic illness: Research for prevention. *Environmental Health Perspectives*, 102(SUPPL. 2), 117–120.
<https://doi.org/10.1289/ehp.94102117>
- Lazarova, S., & Petrova-Antonova, D. (2025). Health-Promoting Behaviors in Bulgaria: A Cross-Sectional Study on Non-Communicable Diseases and Lifestyle. *Societies*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.3390/soc15010015>

- Maysarah. (2021). Buku Digital Ilmu Kesehatan Masyarakat. In *Buku Digital Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Issue February).
- Mustakim, M., & Kas, S. R. (2023). Hubungan Paparan Pestisida Pada Petani Sayuran dengan Efek Neurobehavioral di Desa Pana Kabupaten Enrekang. *Jurnal Dinamika Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 28–33. <https://jpii.upri.ac.id/index.php/jdkm/article/view/88>
- Nurwidodo, N. (2024). Pencegahan dan Promosi Kesehatan secara Tradisional untuk Peningkatan Status Masyarakat di Sumenep Madura. *Jurnal Humanity*, 1(2), 11409. <https://www.neliti.com/publications/11409/>
- Ortega, R., & Carmona, A. (2022). Neurotoxicity of Environmental Metal Toxicants: Special Issue. *Toxics*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/toxics10070382>
- Orywal, K., Socha, K., Iwaniuk, P., Kaczyński, P., Farhan, J. A., Zoń, W., Łozowicka, B., Perkowski, M., & Mroczko, B. (2025). Vitamins in the Prevention and Support Therapy of Neurodegenerative Diseases. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(3), 1–22. <https://doi.org/10.3390/ijms26031333>
- Pugh, J. D., McCoy, K., Williams, A. M., Bentley, B., & Monterosso, L. (2022). Rapid evidence assessment of approaches to community neurological nursing care for people with neurological conditions post-discharge from acute care hospital. *Health and Social Care in the Community*, 27(1), 43–54. <https://doi.org/10.1111/hsc.12576>
- Rachmawati, K., & Herawati. (2022). Pengkajian Keperawatan Kesehatan Lahan Basah Berfokus Pada Keperawatan Komunitas: Literatur Review. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan ...*, 10(3), 381. <https://doi.org/10.20527/dk.v10i3.199>
- Sandstrom, T. S., Kavanoor Sridhar, K., Joshi, J., Aunas, A., Halani, S., & Boggild, A. K. (2025). Acute Febrile Illness Accompanied by 7th and 12th Cranial Nerve Palsy Due to Lyme Disease Following Travel to Rural Ecuador: A Case Report and Mini-Review. *Tropical Medicine and Infectious Disease*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.3390/tropicalmed10010021>
- Sihombing, R. J. (2023). Perilaku Keluarga dan Peran Perawat dengan Tindakan Keluarga Dalam Melakukan Mobilisasi Pasien Stroke. *Jik Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(1), 138. <https://doi.org/10.33757/jik.v7i1.675>
- Syahrin, M. N. Al, & Hamid, I. (2021). *Alih Fungsi Lahan dan Deteritorialisasi Lingkungan di Kabupaten Banjar* (Issue December).
- Valotto Neto, L. J., Reverete de Araujo, M., Moretti Junior, R. C., Mendes Machado, N., Joshi, R. K., dos Santos Buglio, D., Barbalho Lamas, C., Direito, R., Fornari Laurindo, L., Tanaka, M., & Barbalho, S. M. (2024).

Investigating the Neuroprotective and Cognitive-Enhancing Effects of *Bacopa monnieri*: A Systematic Review Focused on Inflammation, Oxidative Stress, Mitochondrial Dysfunction, and Apoptosis. *Antioxidants*, 13(4). <https://doi.org/10.3390/antiox13040393>

Vilar-Pereira, G., Gibaldi, D., Castaño-Barrios, L., da Silva, A. A., Pereira, I. R., Moreira, O. C., Britto, C., Dos Santos, H. A. M., Lopes, R. de O., Tinoco, L. W., Oliveira, W., & Lannes-Vieira, J. (2024). The beneficial effect of fluoxetine on behavioral and cognitive changes in chronic experimental Chagas disease unveils the role of serotonin fueling astrocyte infection by *Trypanosoma cruzi*. In *PLoS Neglected Tropical Diseases* (Vol. 18, Issue 5). <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0012199>

Yang, R., Liu, X., Zhao, Z., Zhao, Y., & Jin, X. (2025). Burden of neurological diseases in Asia, from 1990 to 2021 and its predicted level to 2045: a Global Burden of Disease study. *BMC Public Health*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-025-21928-9>

Bab 5

Preventif, Intervensi, dan Implementasi Keperawatan

A. Pendahuluan

Gangguan persyarafan merupakan masalah kesehatan yang signifikan dan kompleks, terutama di wilayah lahan basah yang memiliki karakteristik lingkungan dan budaya spesifik, seperti masyarakat Banjar. Pendekatan keperawatan yang efektif dalam pencegahan, pengelolaan, dan intervensi gangguan persyarafan memerlukan pemahaman mendalam tentang budaya lokal dan kearifan setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa intervensi kesehatan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai dan praktik budaya masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas dan penerimaan intervensi tersebut. Strategi pencegahan berbasis budaya dan kearifan lokal memainkan peran penting dalam upaya kesehatan masyarakat. Budaya menentukan perilaku individu terkait kesehatan, termasuk persepsi tentang penyakit, praktik pengobatan tradisional, dan pola hidup sehari-hari. Oleh karena itu, integrasi promosi kesehatan yang mencerminkan kepekaan budaya sangat penting bagi perawat dalam merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan kegiatan promosi kesehatan. Pemahaman terhadap latar belakang budaya dan etnis klien, serta penghormatan terhadap nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik budaya mereka, dapat meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan (Lazarova & Petrova-Antonova, 2025).

Pendekatan keperawatan komunitas dalam menangani gangguan persyarafan harus mempertimbangkan sensitivitas budaya. Model keperawatan transkultural, seperti yang dikembangkan oleh Leininger, menekankan pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai budaya klien dalam pemberian asuhan keperawatan. Pendekatan ini memungkinkan perawat untuk merencanakan intervensi yang sesuai dengan konteks budaya

masyarakat, sehingga meningkatkan keterlibatan dan kepatuhan klien terhadap program kesehatan yang ditawarkan. Peran tenaga kesehatan dalam edukasi dan promosi kesehatan sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan pengelolaan gangguan persyarafan. Tenaga kesehatan perlu memiliki kompetensi budaya untuk dapat berkomunikasi efektif dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Hal ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat menyampaikan informasi kesehatan yang relevan dan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat (Orywal et al., 2025).

Model intervensi berbasis masyarakat untuk kesehatan saraf menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengelolaan gangguan persyarafan. Pemberdayaan masyarakat melalui model perilaku berbasis perawatan transkultural telah terbukti efektif dalam mencegah dan menangani masalah kesehatan pada anak, seperti stunting dan karies. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan, dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas intervensi. Intervensi kesehatan yang mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program kesehatan. Misalnya, tradisi "nganyep" pada masyarakat Jawa di Konawe, yang membatasi konsumsi makanan bergizi bagi ibu nifas, dapat diatasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam memberikan edukasi tentang pentingnya asupan gizi seimbang bagi ibu menyusui. Pendekatan ini menunjukkan bahwa intervensi kesehatan yang sensitif budaya dapat mengubah perilaku kesehatan masyarakat tanpa menimbulkan resistensi. Pendekatan budaya dalam intervensi kesehatan juga penting dalam mengatasi stigma terkait penyakit tertentu. Misalnya, stigma terhadap penderita kusta di Pamekasan, Madura, dapat dikurangi dengan melibatkan pemuka agama dalam memberikan pemahaman yang benar tentang penyakit tersebut kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang mempertimbangkan aspek budaya dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan dan mengurangi diskriminasi terhadap penderita penyakit tertentu (Bicknell et al., 2023).

Dalam konteks masyarakat Banjar di lahan basah, pemahaman tentang budaya lokal sangat penting dalam merancang intervensi kesehatan yang efektif. Masyarakat Banjar memiliki kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan dalam program pencegahan dan pengelolaan gangguan persyarafan. Misalnya, penggunaan obat-obatan tradisional yang telah lama digunakan oleh masyarakat setempat dapat diintegrasikan dalam program kesehatan, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan efektivitasnya. Selain itu, pendekatan keperawatan komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin adat dapat meningkatkan efektivitas program kesehatan. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam menentukan norma dan perilaku kesehatan masyarakat. Dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan, pesan-pesan kesehatan dapat lebih mudah diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Peran tenaga kesehatan dalam edukasi dan promosi kesehatan juga harus disesuaikan dengan konteks budaya masyarakat Banjar. Tenaga kesehatan perlu memahami bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Hal ini akan memudahkan komunikasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan, sehingga program edukasi dan promosi kesehatan dapat berjalan lebih efektif. Model intervensi berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat Banjar dapat meningkatkan keberhasilan program kesehatan. Misalnya, pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang bertugas memantau dan melaporkan kasus gangguan persyarafan dapat meningkatkan deteksi dini dan penanganan yang cepat. Selain itu, pelatihan bagi kader kesehatan lokal tentang pencegahan dan pengelolaan gangguan persyarafan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah kesehatan tersebut (Sihombing, 2023).

Pentingnya integrasi promosi kesehatan dalam program-program kesehatan juga harus diperhatikan. Integrasi ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan kesehatan berbasis komunitas, pemberdayaan masyarakat melalui kelompok dukungan kesehatan, serta penguatan akses terhadap layanan kesehatan yang berbasis budaya dan kebutuhan lokal. Dalam masyarakat Banjar yang tinggal di lahan basah, faktor lingkungan dan tradisi memainkan peran besar dalam praktik kesehatan sehari-hari. Oleh karena itu, strategi promosi kesehatan harus mengakomodasi kebiasaan dan kepercayaan yang sudah ada agar pesan-pesan kesehatan lebih mudah

diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Selain itu, intervensi keperawatan berbasis budaya juga harus mempertimbangkan faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Pada masyarakat lahan basah, akses terhadap fasilitas kesehatan bisa menjadi tantangan akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau, tingkat pendidikan yang beragam, serta keterbatasan ekonomi yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu mengembangkan strategi berbasis komunitas yang melibatkan sumber daya lokal, seperti kader kesehatan dan dukun beranak yang telah lama dipercaya masyarakat, untuk memperkuat sistem kesehatan di daerah tersebut (Agianto et al., 2025).

Pemberdayaan masyarakat menjadi elemen utama dalam keberhasilan intervensi keperawatan komunitas. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kesehatan yang diterapkan di lingkungan mereka. Misalnya, dalam menangani gangguan persyarafan, program edukasi berbasis komunitas dapat dilakukan dengan metode yang sesuai dengan budaya lokal, seperti diskusi kelompok, cerita rakyat, atau pendekatan agama yang melibatkan pemuka agama setempat. Selain pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan berbagai pihak juga sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program kesehatan. Tenaga kesehatan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta sektor swasta untuk mengembangkan program intervensi yang lebih komprehensif. Dengan dukungan dari berbagai pihak, program kesehatan dapat lebih mudah dijalankan, memiliki cakupan yang lebih luas, dan lebih efektif dalam mencapai tujuannya (Agianto et al., 2025).

Dalam konteks keperawatan komunitas, penting untuk menerapkan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga aspek psikososial dan lingkungan. Gangguan persyarafan tidak hanya berdampak pada kondisi fisik pasien, tetapi juga pada kesejahteraan emosional dan sosial mereka. Oleh karena itu, perawat perlu memberikan dukungan psikososial yang mencakup edukasi tentang manajemen stres, dukungan keluarga, serta peningkatan kualitas hidup pasien dengan gangguan persyarafan. Selain itu, model intervensi berbasis masyarakat juga

harus mempertimbangkan keberlanjutan program kesehatan. Program yang hanya bersifat sementara sering kali tidak memberikan dampak jangka panjang bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan strategi yang dapat memastikan bahwa program-program yang telah berjalan dapat terus berlanjut dan berkembang, baik melalui pelatihan kader kesehatan, penyediaan sumber daya yang memadai, maupun dengan mengintegrasikan program tersebut ke dalam kebijakan kesehatan daerah (Agianto et al., 2025).

B. Strategi Pencegahan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal

Gangguan persyarafan merupakan masalah kesehatan yang signifikan dan dapat mempengaruhi kualitas hidup individu. Pada masyarakat lahan basah, khususnya suku Banjar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, faktor lingkungan dan budaya memiliki peran penting dalam prevalensi dan pencegahan gangguan ini. Pendekatan pencegahan berbasis budaya dan kearifan lokal dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi risiko gangguan persyarafan. Masyarakat Banjar telah lama beradaptasi dengan lingkungan lahan basah melalui praktik pertanian tradisional yang selaras dengan alam. Sistem surjan Banjar, misalnya, merupakan teknik pertanian multikultur berkelanjutan yang berhasil di lahan rawa lebak. Sistem ini melibatkan pembuatan lahan tabukan yang tergenang untuk budidaya padi atau ikan, serta lahan tembokan untuk tanaman palawija, sayuran, buah-buahan, dan tanaman tahunan. Pengolahan tanah menggunakan alat tradisional seperti tajak, yang menjaga lapisan tanah agar tidak terlalu dalam dan mencegah oksidasi pirit yang dapat meningkatkan keasaman tanah. Kearifan lokal ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan lingkungan tetapi juga pada kesehatan masyarakat. Dengan menjaga kualitas tanah dan air, masyarakat Banjar secara tidak langsung mengurangi paparan terhadap zat-zat berbahaya yang dapat mempengaruhi sistem saraf. Selain itu, praktik gotong royong dan kerjasama dalam komunitas memperkuat ikatan sosial, yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental dan mencegah gangguan persyarafan terkait stres (Agianto et al., 2025).

Namun, tantangan muncul ketika modernisasi dan perubahan gaya hidup mulai mengikis praktik tradisional ini. Penggunaan bahan kimia dalam pertanian, misalnya, dapat meningkatkan risiko paparan neurotoksin. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pengetahuan medis modern

dengan kearifan lokal dalam strategi pencegahan. Edukasi mengenai penggunaan pestisida yang aman dan promosi pertanian organik dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Selain itu, penguatan nilai-nilai budaya melalui program keserasian sosial dapat mencegah konflik sosial yang berdampak negatif pada kesehatan mental. Kementerian Sosial telah membentuk Forum Keserasian Sosial (FKS) dan Kearifan Lokal (KL) untuk mencegah konflik sosial dan deradikalisasi di masyarakat. Forum ini mendorong masyarakat untuk bekerja sama dan mengenal satu sama lain, sehingga dapat mendeteksi dini potensi konflik dan menjaga keharmonisan sosial. Penguatan kearifan lokal juga dapat mencegah perilaku yang berisiko terhadap kesehatan. Misalnya, dalam budaya Melayu Bengkulu, terdapat prosesi pernikahan dengan "Kelambu Berlapis Tujuh" yang mengajarkan penghormatan terhadap tubuh dan mencegah perilaku seksual pra-nikah. Nilai-nilai seperti ini dapat diadaptasi dalam budaya Banjar untuk mencegah perilaku yang dapat meningkatkan risiko gangguan persyarafan, seperti penyalahgunaan zat (Maysarah, 2021).

Penting juga untuk mempertimbangkan faktor lingkungan dalam pencegahan gangguan persyarafan. Lahan basah yang tercemar dapat menjadi sumber paparan neurotoksin. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan melalui praktik tradisional yang ramah lingkungan dapat mengurangi risiko ini. Misalnya, masyarakat Banjar memiliki kebiasaan mengelola gulma dengan menebas dan menyebarkannya kembali ke tanah sebagai pupuk organik, yang tidak hanya menjaga kesuburan tanah tetapi juga mencegah penggunaan bahan kimia berbahaya. Selain itu, pengembangan sanggar seni dan kelompok budaya dapat menjadi sarana edukasi dan promosi kesehatan. Melalui pertunjukan seni tradisional, pesan-pesan mengenai pencegahan gangguan persyarafan dapat disampaikan dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Kementerian Sosial telah memberikan bantuan untuk pengembangan sanggar seni sebagai bagian dari program kearifan lokal, yang diharapkan dapat menjadi tempat tujuan wisata sekaligus media edukasi. Dalam konteks medis, kolaborasi antara tenaga kesehatan dan tokoh adat dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan. Tenaga kesehatan dapat memanfaatkan pengaruh tokoh adat untuk menyampaikan informasi mengenai faktor risiko dan gejala awal gangguan persyarafan. Pendekatan ini lebih mudah diterima oleh masyarakat karena disampaikan oleh figur yang mereka hormati dan

percaya. Selain itu, pelatihan bagi tenaga kesehatan mengenai budaya dan kearifan lokal dapat meningkatkan sensitivitas budaya dalam pelayanan kesehatan. Dengan memahami nilai-nilai dan praktik tradisional masyarakat Banjar, tenaga kesehatan dapat memberikan layanan yang lebih sesuai dan efektif. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan formal (Abdurrahman & Dkk, 2022).

Penting juga untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian kearifan lokal. Melalui pendidikan formal dan non-formal, nilai-nilai budaya dan praktik tradisional yang mendukung kesehatan dapat diajarkan dan dilestarikan. Ini tidak hanya menjaga warisan budaya tetapi juga memastikan keberlanjutan strategi pencegahan berbasis budaya. Selain itu, penelitian mengenai efektivitas kearifan lokal dalam pencegahan gangguan persyarafan perlu dilakukan. Data empiris dapat mendukung integrasi praktik tradisional dalam program kesehatan nasional. Misalnya, penelitian mengenai dampak sistem surjan Banjar terhadap kualitas tanah dan air dapat memberikan bukti ilmiah mengenai manfaatnya bagi kesehatan masyarakat. Penggunaan media lokal, seperti radio komunitas dan pertunjukan seni tradisional, dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi mengenai pencegahan gangguan persyarafan. Dengan menggunakan bahasa dan konteks budaya yang familiar, pesan kesehatan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan strategi yang mengintegrasikan budaya, kearifan lokal, dan ilmu medis, diharapkan gangguan persyarafan pada masyarakat lahan basah dapat diminimalkan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga memperkuat identitas budaya dan keberlanjutan lingkungan (Pugh et al., 2022).

C. Pendekatan Keperawatan Komunitas dalam Menangani Gangguan Persyarafan

Masyarakat lahan basah di Kalimantan Selatan, yang dikenal sebagai masyarakat Banjar, memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik. Namun, kondisi geografis lahan basah dan karakteristik budaya setempat dapat mempengaruhi kesehatan, termasuk risiko gangguan persyarafan. Pendekatan keperawatan komunitas yang efektif diperlukan untuk menangani masalah ini dengan mempertimbangkan konteks budaya dan lingkungan setempat. Lahan basah merupakan wilayah dengan tingkat kelembaban tinggi dan seringkali terendam air. Kondisi ini dapat

mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan penyakit infeksi yang dapat berdampak pada sistem saraf. Misalnya, penyakit seperti malaria dan demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk lebih umum terjadi di daerah dengan genangan air. Infeksi ini dapat menyebabkan komplikasi neurologis seperti ensefalitis atau neuropati perifer. Selain faktor lingkungan, budaya Banjar juga memainkan peran penting dalam kesehatan masyarakat. Masyarakat Banjar memiliki tradisi gotong royong dan kekerabatan yang kuat, yang dapat dimanfaatkan dalam program kesehatan komunitas. Namun, beberapa praktik tradisional mungkin tidak sejalan dengan praktik kesehatan modern, sehingga diperlukan pendekatan yang sensitif budaya dalam intervensi keperawatan (Kapoor, 2022).

Pendekatan keperawatan komunitas menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya masyarakat dalam merancang dan melaksanakan intervensi kesehatan. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh determinan sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks masyarakat Banjar, perawat komunitas perlu memahami nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik kesehatan tradisional yang ada. Salah satu strategi intervensi yang efektif adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah proses memberikan kekuatan atau dorongan sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatannya sendiri. Dalam konteks ini, perawat dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemimpin adat untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan penyakit yang dapat mempengaruhi sistem saraf. Misalnya, edukasi tentang pentingnya menguras dan menutup tempat penampungan air untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Pendidikan kesehatan juga merupakan komponen kunci dalam pendekatan keperawatan komunitas. Melalui penyuluhan dan kampanye kesehatan, masyarakat dapat diberikan informasi tentang gejala awal gangguan persyarafan dan pentingnya mencari perawatan medis segera. Pendidikan kesehatan yang efektif harus disampaikan dalam bahasa dan metode yang sesuai dengan budaya setempat untuk memastikan pemahaman dan penerimaan oleh masyarakat (Flynn, 2024).

Kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak juga penting dalam intervensi keperawatan komunitas. Perawat dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk

menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Misalnya, kerjasama dengan dinas kebersihan untuk memastikan pengelolaan sampah yang baik guna mencegah tempat perkembangbiakan nyamuk. Proses kelompok atau group process adalah pendekatan lain yang dapat digunakan. Dengan membentuk kelompok-kelompok swabantu atau self-help groups, anggota masyarakat dapat saling berbagi pengalaman dan strategi dalam mencegah dan menangani gangguan persyarafan. Kelompok ini juga dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi bersama. Intervensi profesional keperawatan juga diperlukan, terutama dalam memberikan perawatan langsung kepada individu yang mengalami gangguan persyarafan. Perawat dapat memberikan terapi modalitas dan komplementer, serta melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi jika diperlukan. Pendekatan ini memastikan bahwa individu mendapatkan perawatan yang sesuai dan tepat waktu (Albarnawi et al., 2023).

Pentingnya pendekatan yang holistik dalam keperawatan komunitas tidak dapat diabaikan. Perawat harus mempertimbangkan faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dalam merancang intervensi. Misalnya, memahami bahwa beberapa praktik tradisional mungkin mempengaruhi kepatuhan terhadap pengobatan modern, sehingga diperlukan pendekatan yang sensitif dan kolaboratif. Selain itu, perawat komunitas harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Kemampuan mendengarkan dan memahami kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat adalah kunci dalam merancang intervensi yang efektif dan diterima oleh masyarakat. Evaluasi dan monitoring juga merupakan bagian penting dari pendekatan keperawatan komunitas. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, perawat dapat menilai efektivitas intervensi yang dilakukan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hal ini memastikan bahwa program kesehatan tetap relevan dan efektif dalam menangani gangguan persyarafan di masyarakat lahan basah (Ifansyah & Waluya, 2024).

Peran perawat sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan kesehatan juga sangat penting. Perawat dapat membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan dan memastikan bahwa informasi kesehatan disampaikan dengan cara yang dapat dipahami oleh

masyarakat. Peran ini memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam akses terhadap perawatan kesehatan yang dibutuhkan. Selain itu, perawat komunitas dapat berperan dalam pengembangan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan masukan berdasarkan pengalaman lapangan, perawat dapat membantu pembuat kebijakan merancang program yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks lokal. Penting juga untuk melibatkan keluarga dalam intervensi keperawatan komunitas. Keluarga seringkali menjadi sumber dukungan utama bagi individu yang mengalami gangguan persyarafan. Dengan melibatkan keluarga, perawat dapat memastikan bahwa individu mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam proses penyembuhan (Ifansyah & Waluya, 2024).

Pendekatan berbasis komunitas juga memungkinkan adanya deteksi dini terhadap gangguan persyarafan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanda dan gejala awal, intervensi dapat dilakukan lebih cepat, yang dapat meningkatkan prognosis. Masyarakat lahan basah di Kalimantan Selatan, yang dikenal sebagai masyarakat Banjar, memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik. Namun, kondisi geografis lahan basah dan karakteristik budaya setempat dapat mempengaruhi kesehatan, termasuk risiko gangguan persyarafan. Pendekatan keperawatan komunitas yang efektif diperlukan untuk menangani masalah ini dengan mempertimbangkan konteks budaya dan lingkungan setempat. Lahan basah merupakan wilayah dengan tingkat kelembaban tinggi dan seringkali terendam air. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan penyakit infeksi yang dapat berdampak pada sistem saraf. Misalnya, penyakit seperti malaria dan demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk lebih umum terjadi di daerah dengan genangan air. Infeksi ini dapat menyebabkan komplikasi neurologis seperti ensefalitis atau neuropati perifer. Selain faktor lingkungan, budaya Banjar juga memainkan peran penting dalam kesehatan masyarakat. Masyarakat Banjar memiliki tradisi gotong royong dan kekerabatan yang kuat, yang dapat dimanfaatkan dalam program kesehatan komunitas. Namun, beberapa praktik tradisional mungkin tidak sejalan dengan praktik kesehatan modern, sehingga diperlukan pendekatan yang sensitif budaya dalam intervensi keperawatan (Ifansyah & Waluya, 2024).

Pendekatan keperawatan komunitas menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya masyarakat dalam merancang dan melaksanakan intervensi kesehatan. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh determinan sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks masyarakat Banjar, perawat komunitas perlu memahami nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik kesehatan tradisional yang ada. Salah satu strategi intervensi yang efektif adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah proses memberikan kekuatan atau dorongan sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatannya sendiri.

Dalam konteks ini, perawat dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemimpin adat untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan penyakit yang dapat mempengaruhi sistem saraf. Misalnya, edukasi tentang pentingnya menguras dan menutup tempat penampungan air untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Pendidikan kesehatan juga merupakan komponen kunci dalam pendekatan keperawatan komunitas. Melalui penyuluhan dan kampanye kesehatan, masyarakat dapat diberikan informasi tentang gejala awal gangguan persyarafan dan pentingnya mencari perawatan medis segera. Pendidikan kesehatan yang efektif harus disampaikan dalam bahasa dan metode yang sesuai dengan budaya setempat untuk memastikan pemahaman dan penerimaan oleh masyarakat. Kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak juga penting dalam intervensi keperawatan komunitas. Perawat dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Misalnya, kerjasama dengan dinas kebersihan untuk memastikan pengelolaan sampah yang baik guna mencegah tempat perkembangbiakan nyamuk (Ifansyah & Waluya, 2024).

Proses kelompok atau group process adalah pendekatan lain yang dapat digunakan. Dengan membentuk kelompok-kelompok swabantu atau self-help groups, anggota masyarakat dapat saling berbagi pengalaman dan strategi dalam mencegah dan menangani gangguan persyarafan. Kelompok ini juga dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi bersama. Intervensi profesional keperawatan juga diperlukan, terutama dalam memberikan perawatan

langsung kepada individu yang mengalami gangguan persyarafan. Perawat dapat memberikan terapi modalitas dan komplementer, serta melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi jika diperlukan. Pendekatan ini memastikan bahwa individu mendapatkan perawatan yang sesuai dan tepat waktu. Pentingnya pendekatan yang holistik dalam keperawatan komunitas tidak dapat diabaikan. Perawat harus mempertimbangkan faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dalam merancang intervensi. Misalnya, memahami bahwa beberapa praktik tradisional mungkin mempengaruhi kepatuhan terhadap pengobatan modern, sehingga diperlukan pendekatan yang sensitif dan kolaboratif (Ifansyah & Waluya, 2024).

Selain itu, perawat komunitas harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Kemampuan mendengarkan dan memahami kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat adalah kunci dalam merancang intervensi yang efektif dan diterima oleh masyarakat. Evaluasi dan monitoring juga merupakan bagian penting dari pendekatan keperawatan komunitas. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, perawat dapat menilai efektivitas intervensi yang dilakukan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hal ini memastikan bahwa program kesehatan tetap relevan dan efektif dalam menangani gangguan persyarafan di masyarakat lahan basah. Peran perawat sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan kesehatan juga sangat penting. Perawat dapat membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan dan memastikan bahwa informasi kesehatan disampaikan dengan cara yang dapat dipahami oleh masyarakat. Peran ini memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam akses terhadap perawatan kesehatan yang dibutuhkan (Nurwidodo, 2024).

Selain itu, perawat komunitas dapat berperan dalam pengembangan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan masukan berdasarkan pengalaman lapangan, perawat dapat membantu pembuat kebijakan merancang program yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks lokal. Penting juga untuk melibatkan keluarga dalam intervensi keperawatan komunitas. Keluarga seringkali menjadi sumber dukungan utama bagi individu yang mengalami gangguan persyarafan. Dengan melibatkan keluarga, perawat dapat memastikan bahwa individu

mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam proses penyembuhan. Pendekatan berbasis komunitas juga memungkinkan adanya deteksi dini terhadap gangguan persyarafan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanda dan gejala awal, intervensi dapat dilakukan lebih cepat, yang dapat meningkatkan prognosis pasien. Deteksi dini ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan rutin yang diinisiasi oleh tenaga kesehatan di komunitas, seperti program skrining neurologis berbasis masyarakat. Dengan pendekatan ini, kasus gangguan persyarafan dapat diidentifikasi lebih awal, memungkinkan intervensi segera yang dapat mencegah komplikasi lebih lanjut (Nurwidodo, 2024).

Selain itu, dalam konteks masyarakat lahan basah, penting untuk mengembangkan sistem rujukan yang efektif. Banyak daerah di lahan basah memiliki keterbatasan dalam akses terhadap fasilitas kesehatan tingkat lanjut, sehingga sistem rujukan yang terstruktur akan memastikan bahwa pasien dengan gangguan persyarafan mendapatkan perawatan yang optimal. Perawat komunitas dapat berperan dalam memfasilitasi rujukan ini dengan bekerja sama dengan pusat kesehatan primer, rumah sakit daerah, serta tenaga medis spesialis. Pendekatan multidisiplin juga diperlukan dalam menangani gangguan persyarafan di masyarakat Banjar. Kerjasama antara perawat, dokter, ahli gizi, fisioterapis, dan pekerja sosial kesehatan akan memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang komprehensif. Sebagai contoh, pasien dengan neuropati perifer akibat diabetes tidak hanya membutuhkan pengobatan farmakologis, tetapi juga intervensi gizi, terapi fisik, serta edukasi kesehatan yang berkelanjutan (Aridamayanti, Agianto, et al., 2024).

Dalam implementasi intervensi keperawatan komunitas, penting juga untuk mempertimbangkan keberlanjutan program yang dijalankan. Program kesehatan yang efektif harus memiliki strategi untuk mempertahankan dampaknya dalam jangka panjang. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan melatih kader kesehatan dari masyarakat setempat, yang dapat bertindak sebagai agen perubahan dalam menyebarluaskan informasi kesehatan dan membantu deteksi dini gangguan persyarafan. Penting pula untuk melakukan penelitian berbasis komunitas guna memahami lebih dalam faktor risiko spesifik yang berkontribusi terhadap gangguan persyarafan di masyarakat lahan basah. Data epidemiologi lokal akan sangat

berguna dalam menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Dengan adanya penelitian ini, pendekatan keperawatan komunitas dapat terus berkembang dan disesuaikan dengan dinamika sosial serta perubahan lingkungan yang terjadi (Aridamayanti, Agianto, et al., 2024). Secara keseluruhan, pendekatan keperawatan komunitas dalam menangani gangguan persyarafan pada masyarakat lahan basah dengan budaya Banjar harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan akses layanan kesehatan. Dengan memadukan edukasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pendekatan multidisiplin, serta sistem rujukan yang efektif, perawat komunitas dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang rentan terhadap gangguan persyarafan. Upaya ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Kurmalawati et al., 2023).

D. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi dan Promosi Kesehatan

Gangguan persyarafan merupakan masalah kesehatan yang signifikan dan kompleks, terutama di wilayah lahan basah yang dihuni oleh masyarakat dengan budaya tertentu, seperti masyarakat Banjar. Kondisi lingkungan lahan basah yang khas, ditambah dengan praktik budaya dan kebiasaan setempat, dapat mempengaruhi prevalensi dan jenis gangguan persyarafan yang terjadi. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan memiliki peran krusial dalam melakukan edukasi dan promosi kesehatan untuk mencegah dan menangani gangguan persyarafan tersebut. Masyarakat Banjar, yang mayoritas tinggal di bantaran sungai, memiliki budaya dan praktik kesehatan tradisional yang dikenal sebagai "batatamba". Batatamba adalah proses pengobatan tradisional yang melibatkan penyembuh tradisional atau "pananamba" untuk mengatasi berbagai penyakit, termasuk gangguan psikologis seperti gelisah dan gangguan tidur. Dalam praktik batatamba, penyakit seringkali dikategorikan menjadi "sakit nyata" dan "sakit tidak nyata". Sakit nyata merujuk pada penyakit yang dapat dilihat dan dirasakan dengan jelas, sementara sakit tidak nyata adalah penyakit yang sulit ditemukan penyebabnya dan sering dianggap lebih berbahaya karena sulit diobati (Kurmalawati et al., 2023).

Pemahaman masyarakat Banjar tentang penyakit dan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan nilai-nilai budaya mereka. Misalnya, gangguan persyarafan yang tidak memiliki gejala fisik jelas mungkin dianggap sebagai "sakit tidak nyata" dan dikaitkan dengan teguran dari leluhur atau pelanggaran pantangan adat. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih pengobatan tradisional daripada medis modern. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan perlu memahami dan menghormati nilai-nilai budaya setempat saat memberikan edukasi dan promosi kesehatan. Peran tenaga kesehatan sebagai edukator sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gangguan persyarafan. Mereka harus mampu menjelaskan secara jelas dan mudah dipahami tentang apa itu gangguan persyarafan, gejala-gejalanya, faktor risikonya, serta pentingnya deteksi dini dan pengobatan yang tepat. Misalnya, perawat komunitas dapat melakukan kunjungan rumah untuk memberikan penyuluhan kesehatan mengenai cara pencegahan dan penanganan awal gangguan persyarafan. Selain sebagai edukator, tenaga kesehatan juga berperan sebagai role model atau teladan bagi masyarakat. Dengan menunjukkan perilaku hidup sehat dan praktik kesehatan yang baik, mereka dapat menginspirasi masyarakat untuk mengikuti jejak mereka. Misalnya, perawat yang selalu menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, dan mengelola stres dengan baik dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat tentang bagaimana mencegah gangguan persyarafan melalui gaya hidup sehat (Agianto et al., 2025).

Sebagai fasilitator, tenaga kesehatan membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan. Mereka dapat memandu masyarakat dalam memahami prosedur medis, membantu dalam proses rujukan ke spesialis, atau menjelaskan manfaat dan risiko dari berbagai pilihan pengobatan. Dalam konteks masyarakat Banjar, tenaga kesehatan perlu menjalin hubungan baik dengan penyembuh tradisional atau pananamba untuk menciptakan kolaborasi yang harmonis antara pengobatan tradisional dan modern. Peran tenaga kesehatan sebagai motivator juga tidak kalah penting. Mereka harus mampu mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mengambil tindakan proaktif dalam menjaga kesehatan persyarafan mereka. Ini bisa dilakukan dengan memberikan dukungan emosional, membangun kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola kesehatan mereka, dan memberikan penghargaan atas perubahan positif yang telah dicapai. Advokasi adalah peran lain yang harus dijalankan oleh tenaga

kesehatan. Mereka perlu memperjuangkan kebijakan dan program yang mendukung kesehatan persyarafan masyarakat, seperti penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang gangguan persyarafan, dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya kesehatan persyarafan (Agianto et al., 2025).

Dalam melaksanakan peran-peran tersebut, tenaga kesehatan harus mempertimbangkan faktor-faktor budaya yang mempengaruhi persepsi dan perilaku kesehatan masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat Banjar, kepercayaan terhadap penyebab supranatural dari penyakit mungkin mempengaruhi keputusan mereka untuk mencari pengobatan medis. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu menggunakan pendekatan yang sensitif budaya dan menghormati kepercayaan serta praktik tradisional masyarakat (Agianto et al., 2025).

Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan penyembuh tradisional dapat menjadi strategi efektif dalam promosi kesehatan. Dengan bekerja sama, mereka dapat menggabungkan pengetahuan medis modern dengan praktik tradisional yang dipercaya masyarakat, sehingga meningkatkan penerimaan dan efektivitas intervensi kesehatan. Misalnya, penyembuh tradisional dapat dilibatkan dalam program edukasi kesehatan untuk menjelaskan bagaimana praktik batatamba dapat dikombinasikan dengan pengobatan medis untuk hasil yang lebih baik. Penting bagi tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kompetensi mereka dalam memahami dan menangani gangguan persyarafan. Ini dapat dicapai melalui pelatihan berkelanjutan, partisipasi dalam seminar dan workshop, serta pembaruan informasi terkini tentang perkembangan dalam bidang neurologi. Dengan pengetahuan yang *up-to-date*, mereka dapat memberikan edukasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat (Agianto et al., 2025).

Selain itu, penggunaan media massa dan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam promosi kesehatan. Tenaga kesehatan dapat memanfaatkan platform seperti radio lokal, televisi, dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pencegahan dan penanganan gangguan persyarafan. Dengan demikian, pesan kesehatan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Evaluasi dan monitoring program edukasi dan promosi kesehatan juga merupakan tugas

penting bagi tenaga kesehatan. Dengan melakukan evaluasi, mereka dapat menilai efektivitas program yang telah dijalankan, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan merencanakan strategi yang lebih efektif di masa mendatang. Dalam menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya tingkat pendidikan, dan kuatnya kepercayaan terhadap pengobatan tradisional, tenaga kesehatan perlu mengadopsi pendekatan yang adaptif dan inovatif. Mereka harus mengembangkan metode komunikasi yang lebih efektif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta membangun hubungan yang lebih erat dengan pemimpin adat dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, edukasi dan promosi kesehatan dapat lebih mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar (Agianto et al., 2025).

Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi gangguan persyarafan di wilayah lahan basah. Pemerintah dan institusi kesehatan perlu memastikan bahwa fasilitas kesehatan tersedia di daerah terpencil dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di bantaran sungai. Mobile clinic atau layanan kesehatan keliling bisa menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses pusat kesehatan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kesehatan persyarafan perlu didorong melalui program berbasis komunitas. Pelatihan bagi kader kesehatan lokal dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali tanda-tanda awal gangguan persyarafan serta cara-cara pencegahannya. Dengan keterlibatan masyarakat, program kesehatan dapat lebih berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang (Agianto et al., 2025).

Penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara faktor lingkungan di lahan basah dan gangguan persyarafan juga sangat diperlukan. Polusi air, konsumsi makanan yang terkontaminasi logam berat, serta paparan zat beracun lainnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kasus gangguan neurologis di masyarakat Banjar. Dengan adanya penelitian yang komprehensif, intervensi kesehatan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Peran tenaga kesehatan dalam edukasi dan promosi kesehatan mengenai gangguan persyarafan pada masyarakat lahan basah, khususnya dalam konteks budaya Banjar, sangatlah penting. Mereka harus mampu beradaptasi dengan nilai-nilai budaya setempat, menjalin

kolaborasi dengan penyembuh tradisional, serta mengoptimalkan teknologi dan media dalam menyebarkan informasi kesehatan. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis komunitas, diharapkan angka kejadian gangguan persyarafan dapat diminimalkan, serta kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara keseluruhan (Agianto et al., 2025).

E. Model Intervensi Berbasis Masyarakat untuk Kesehatan Syaraf

Gangguan persyarafan merupakan masalah kesehatan yang kompleks dan memerlukan pendekatan intervensi yang komprehensif. Pada masyarakat lahan basah dengan budaya Banjar, pendekatan berbasis komunitas yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan. Masyarakat Banjar memiliki praktik pengobatan tradisional yang dikenal sebagai "batatamba", yang melibatkan penyembuh tradisional atau "pananamba" dalam menangani berbagai penyakit, termasuk gangguan psikologis seperti gelisah dan gangguan tidur. Penyakit seringkali dikategorikan menjadi "sakit nyata" dan "sakit tidak nyata", di mana yang terakhir dianggap lebih berbahaya karena sulit diobati. Pemahaman masyarakat Banjar tentang penyakit sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan nilai-nilai budaya mereka. Gangguan persyarafan tanpa gejala fisik jelas mungkin dianggap sebagai "sakit tidak nyata" dan dikaitkan dengan teguran dari leluhur atau pelanggaran pantangan adat. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih memilih pengobatan tradisional daripada medis modern. Dalam konteks ini, model intervensi berbasis komunitas yang efektif harus mengintegrasikan praktik kesehatan tradisional dengan layanan kesehatan modern (Agianto et al., 2025).

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah kolaborasi antara tenaga kesehatan dan penyembuh tradisional dalam program promosi kesehatan. Misalnya, penggunaan kesenian tradisional Banjar sebagai media promosi kesehatan telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak. Pertunjukan seperti Madihin, Mamanda, Jepin Carita, dan Damarwulan digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan dengan cara yang menarik dan sesuai dengan budaya lokal. Selain itu, pengembangan layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi geografis masyarakat lahan basah juga penting. Inisiatif seperti klinik terapan yang diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat (FKIK ULM) merupakan contoh inovasi

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai. Klinik terapung ini memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk deteksi dan penanganan dini gangguan persyarafan. Penting juga untuk memberdayakan kader kesehatan lokal melalui pelatihan yang sesuai, sehingga mereka dapat berperan sebagai penghubung antara tenaga kesehatan profesional dan masyarakat. Kader kesehatan yang memahami nilai-nilai budaya setempat dapat membantu menyampaikan informasi kesehatan dengan cara yang lebih diterima oleh masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tentang pencegahan dan penanganan gangguan persyarafan. Dengan demikian, pesan kesehatan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Evaluasi dan monitoring program intervensi berbasis komunitas harus dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Data yang diperoleh dari evaluasi dapat digunakan untuk merancang strategi intervensi yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (Agianto et al., 2025).

Dalam menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya tingkat pendidikan, dan kuatnya kepercayaan terhadap pengobatan tradisional, tenaga kesehatan perlu mengadopsi pendekatan yang adaptif dan inovatif. Mereka harus mengembangkan metode komunikasi yang efektif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta membangun hubungan yang erat dengan pemimpin adat dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, edukasi dan promosi kesehatan dapat lebih mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi gangguan persyarafan di wilayah lahan basah. Pemerintah dan institusi kesehatan perlu memastikan bahwa fasilitas kesehatan tersedia di daerah terpencil dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di bantaran sungai. *Mobile clinic* atau layanan kesehatan keliling bisa menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses pusat kesehatan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kesehatan persyarafan perlu didorong melalui program berbasis komunitas. Pelatihan bagi kader kesehatan lokal dapat membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali tanda-tanda awal gangguan persyarafan serta cara-cara pencegahannya. Dengan

keterlibatan masyarakat, program kesehatan dapat lebih berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang (Agianto et al., 2025).

Penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara faktor lingkungan di lahan basah dan gangguan persyarafan juga sangat diperlukan. Polusi air, konsumsi makanan yang terkontaminasi logam berat, serta paparan zat beracun lainnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kasus gangguan neurologis di masyarakat Banjar. Dengan adanya penelitian yang komprehensif, intervensi kesehatan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Model intervensi berbasis komunitas yang efektif untuk menangani gangguan persyarafan pada masyarakat lahan basah dengan budaya Banjar harus mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, kolaborasi antara pengobatan tradisional dan modern, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis komunitas, diharapkan angka kejadian gangguan persyarafan dapat diminimalkan, serta kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara keseluruhan (Agianto et al., 2025).

F. Penutup

Gangguan persyarafan pada masyarakat lahan basah, khususnya di lingkungan budaya Banjar, merupakan tantangan kesehatan yang kompleks dan memerlukan pendekatan intervensi yang holistik dan berbasis komunitas. Sepanjang pembahasan dalam buku ini, telah dijelaskan berbagai aspek penting terkait pencegahan, pengelolaan, dan intervensi keperawatan yang mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, serta kondisi lingkungan khas masyarakat lahan basah. Pendekatan transkultural dalam keperawatan komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan kesehatan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal. Pemanfaatan metode edukasi berbasis budaya, seperti integrasi dengan pengobatan tradisional dan penggunaan media komunikasi lokal, dapat meningkatkan efektivitas program kesehatan saraf.

Dengan memahami pola kepercayaan masyarakat Banjar tentang penyakit, tenaga kesehatan dapat lebih mudah menjalin komunikasi yang baik dan memberikan intervensi yang lebih diterima oleh masyarakat. Keberhasilan intervensi kesehatan tidak terlepas dari keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, pemuka adat, penyembuh tradisional, serta

keluarga dan komunitas setempat. Model intervensi berbasis masyarakat yang mengedepankan pendekatan kolaboratif dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan persyarafan. Selain itu, peran kader kesehatan sebagai jembatan antara masyarakat dan tenaga medis juga menjadi elemen kunci dalam upaya pencegahan dan deteksi dini gangguan persyarafan.

Di sisi lain, tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi program kesehatan saraf di masyarakat lahan basah mencakup faktor aksesibilitas layanan kesehatan, keterbatasan sumber daya, serta masih kuatnya kepercayaan terhadap praktik pengobatan tradisional yang tidak selalu sesuai dengan prinsip medis modern. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif, berbasis bukti, serta didukung oleh kebijakan kesehatan yang berkelanjutan agar dampak intervensi dapat bertahan dalam jangka panjang. Selain aspek medis, pendekatan kesehatan berbasis ekologi dan lingkungan juga perlu mendapatkan perhatian serius. Faktor lingkungan, seperti paparan polusi air, konsumsi bahan pangan yang terkontaminasi zat berbahaya, serta kondisi geografis yang mempengaruhi mobilitas masyarakat, harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun strategi pencegahan gangguan persyarafan.

Secara keseluruhan, pada bab ini memberikan landasan ilmiah dan praktik bagi tenaga kesehatan dalam menangani gangguan persyarafan di masyarakat lahan basah dengan pendekatan berbasis komunitas. Dengan terus melakukan penelitian, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, serta memperkuat keterlibatan masyarakat, diharapkan kesehatan persyarafan masyarakat Banjar dapat terus meningkat, sehingga kualitas hidup mereka juga menjadi lebih baik. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam inovasi program kesehatan berbasis budaya serta penguatan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam bidang kesehatan. Dengan komitmen bersama, gangguan persyarafan di masyarakat lahan basah dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih sehat serta produktif di tengah dinamika perubahan sosial dan lingkungan yang terus berkembang.

G. Referensi

- Abdurrahman, & Dkk. (2022). Deteritorialisasi Lingkungan Lahan Basah Di Kabupaten Banjar Studi di Kecamatan Kertak hanyar dan Kecamatan Gambut. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 1(1), 143–149. <http://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/687>
- Agianto, Aridamayanti, B. G., Firdausi, R., Septiany, M., & Hasibuan, N. A. (2025). Perawatan Stroke di Komunitas. In *Nuansa Fajar Cemerlang*.
- Agianto, Herry Setiawan, & Nasri, N. M. (2022). Identifikasi Diagnosis Keperawatan dan Etiologi Pasca Banjir Pada Masyarakat Kalimantan Selatan. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 10(1), 51–63. <https://doi.org/10.20527/jdk.v10i1.104>
- Albarnawi, H. M., Alroqabi, S. M., Ogdi, W. Z., Jalal, A. A., Agdi, J. Z., AL-Eid, H. S., Almutairy, A. K., Alanazi, M. K., Qawfashi, F. Y., & Alhadidi, A. M. (2023). Community nursing interventions for chronic disease management. *International Journal Of Community Medicine And Public Health*, 11(1), 464–468. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20233858>
- Aridamayanti, B. G., Agianto, Septiany, M., Chrisnawati, Khairina, N., Amilia, E., Fayza, E. N., & Vebrina, E. (2024). Personal Hygiene pada Masyarakat dengan Keluhan Penyakit Kulit. *Jurnal Dunia Keperawatan*, 12(July), 244–253. <https://doi.org/10.20527/dk.v12i2.660>
- Aridamayanti, B. G., Nurhidayah, S. D., Rahmah, J., Sintia, Humaira, A., Meidiani, Meiliana, D., Amalia, N. P., Amilia, E., Adibah, J. D., Badriah, S., Agustia, Z. A., Rahimi, F., Alisa, R., Kamil, M. R., Hafiz, C., & Ghani, Z. (2024). Manajemen Antisipasi Bencana. *CV. Gita Lentera*, 6.
- Aridamayanti, B. G., Yakin, R., Nisvia, N., & ... (2024). Gambaran Diagnosis dan Intervensi Keperawatan Kerusakan Integritas Kulit pada Masyarakat Terdampak Banjir di Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 15(1), 110–116. <http://www.forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/4194>
- Bicknell, B., Liebert, A., Borody, T., Herkes, G., McLachlan, C., & Kiat, H. (2023). Neurodegenerative and Neurodevelopmental Diseases and the Gut-Brain Axis: The Potential of Therapeutic Targeting of the Microbiome. *International Journal of Molecular Sciences*, 24(11). <https://doi.org/10.3390/ijms24119577>
- Cordell, G. A. (2024). The contemporary nexus of medicines security and bioprospecting: a future perspective for prioritizing the patient. *Natural Products and Bioprospecting*, 14(1). <https://doi.org/10.1007/s13659-024-00431-5>

- Flynn, B. C. (2024). Community health nursing education. *Annual Review of Nursing Research*, 6, 167–190. <https://doi.org/10.1891/0739-6686.6.1.167>
- Gorris, M. E., Ardon-Dryer, K., Campuzano, A., Castañón-Olivares, L. R., Gill, T. E., Greene, A., Hung, C. Y., Kaufeld, K. A., Lacy, M., & Sánchez-Paredes, E. (2023). Advocating for Coccidioidomycosis to Be a Reportable Disease Nationwide in the United States and Encouraging Disease Surveillance across North and South America. *Journal of Fungi*, 9(1). <https://doi.org/10.3390/jof9010083>
- Gözübatık Çelik, R. G., Toprak, U. E., & Kıran, S. (2022). Neurotoxicological Effects of Environmental and Occupational Agents. *Türk Noroloji Dergisi*, 28(2), 63–72. <https://doi.org/10.4274/tnd.2022.90023>
- Graham, P. (2023). Neurotoxicity of Environmental Pollutants. *European Parliament Directorate-General for Research*, 570(July).
- Iannaccone, P. M., Ryznar, R. J., & Van Winkle, L. J. (2024). Genetics, Epigenetics, and the Environment: Are Precision Medicine, Provider Compassion, and Social Justice Effective Public Health Measures to Mitigate Disease Risk and Severity? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(11), 1–18. <https://doi.org/10.3390/ijerph21111522>
- Ifansyah, M. N., & Waluya, J. G. (2024). *Keperawatan Komunitas Pendekatan Holistik untuk Perlindungan, Pemberdayaan dan Intervensi Strategis*.
- Jahromi, F., Al Mannai, M., Alabed, A., Alkhlofi, S., Hejres, S., Alromaihi, D., Kumar, P., & Freije, A. (2024). Impact of Dust Events on UV Index and Vitamin D Synthesis in Bahrain and Its Correlation with Population Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels. *Atmosphere*, 15(12). <https://doi.org/10.3390/atmos15121497>
- Justiz-Vaillant, A., Soodeen, S., Gopaul, D., Arozarena-Fundora, R., Thompson, R., Unakal, C., & Akpaka, P. E. (2025). Tackling Infectious Diseases in the Caribbean and South America: Epidemiological Insights, Antibiotic Resistance, Associated Infectious Diseases in Immunological Disorders, Global Infection Response, and Experimental Anti-Idiotypic Vaccine Candidates Agai. *Microorganisms*, 13(2). <https://doi.org/10.3390/microorganisms13020282>
- Kapoor, R. (2022). Neurological, psychiatric, and developmental disorders: Meeting the challenge in the developing world Committee on Nervous System Disorders, Board on Global Health, Institute of Medicine. Washington DC. In *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene* (Vol. 96, Issue 3).

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0035920302901161>

- Kemenkes, R. (2023). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Hanta di Indonesia. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 1–23.
- Khiriyati, L., Marlinae, L., Waskito, A., Rahmat, A. N., & Ma'aruf, M. A. (2022). *Buku Ajar Pengantar Lingkungan Lahan Basah*.
- Khurtsilava, I., kanjaradze, D., Tsirdava, N., Parulava, T., & Darsania, I. (2024). Rare Presentation of Pediatric Nervous System Lyme Disease: A Case Report. *Cureus*, 16(5). <https://doi.org/10.7759/cureus.60535>
- Kurmalawati, R., Ir Meldi Septiana, Ms., Norma Yuni Kartika, Ms., & Aiga, D. (2023). *Studi Kasus Utama Lingkungan Lahan Basah Suku Banjar di Kalimantan Selatan*.
- Landrigan, P. J., Graham, D. G., & Thomas, R. D. (2024). Environmental neurotoxic illness: Research for prevention. *Environmental Health Perspectives*, 102(SUPPL. 2), 117–120. <https://doi.org/10.1289/ehp.94102117>
- Lazarova, S., & Petrova-Antonova, D. (2025). Health-Promoting Behaviors in Bulgaria: A Cross-Sectional Study on Non-Communicable Diseases and Lifestyle. *Societies*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.3390/soc15010015>
- Maysarah. (2021). Buku Digital Ilmu Kesehatan Masyarakat. In *Buku Digital Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Issue February).
- Mustakim, M., & Kas, S. R. (2023). Hubungan Paparan Pestisida Pada Petani Sayuran dengan Efek Neurobehavioral di Desa Pana Kabupaten Enrekang. *Jurnal Dinamika Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 28–33. <https://jpii.upri.ac.id/index.php/jdkm/article/view/88>
- Nurwidodo, N. (2024). Pencegahan dan Promosi Kesehatan secara Tradisional untuk Peningkatan Status Masyarakat di Sumenep Madura. *Jurnal Humanity*, 1(2), 11409. <https://www.neliti.com/publications/11409/>
- Ortega, R., & Carmona, A. (2022). Neurotoxicity of Environmental Metal Toxicants: Special Issue. *Toxics*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/toxics10070382>
- Orywal, K., Socha, K., Iwaniuk, P., Kaczyński, P., Farhan, J. A., Zoń, W., Łozowicka, B., Perkowski, M., & Mroczko, B. (2025). Vitamins in the Prevention and Support Therapy of Neurodegenerative Diseases. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(3), 1–22. <https://doi.org/10.3390/ijms26031333>
- Pugh, J. D., McCoy, K., Williams, A. M., Bentley, B., & Monterosso, L. (2022). Rapid evidence assessment of approaches to community neurological nursing care for people with neurological conditions post-discharge

- from acute care hospital. *Health and Social Care in the Community*, 27(1), 43–54. <https://doi.org/10.1111/hsc.12576>
- Rachmawati, K., & Herawati. (2022). Pengkajian Keperawatan Kesehatan Lahan Basah Berfokus Pada Keperawatan Komunitas: Literatur Review. *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan Dan ...*, 10(3), 381. <https://doi.org/10.20527/dk.v10i3.199>
- Sandstrom, T. S., Kavanoor Sridhar, K., Joshi, J., Aunas, A., Halani, S., & Boggild, A. K. (2025). Acute Febrile Illness Accompanied by 7th and 12th Cranial Nerve Palsy Due to Lyme Disease Following Travel to Rural Ecuador: A Case Report and Mini-Review. *Tropical Medicine and Infectious Disease*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.3390/tropicalmed10010021>
- Sihombing, R. J. (2023). Perilaku Keluarga dan Peran Perawat dengan Tindakan Keluarga Dalam Melakukan Mobilisasi Pasien Stroke. *Jik Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(1), 138. <https://doi.org/10.33757/jik.v7i1.675>
- Syahrin, M. N. Al, & Hamid, I. (2021). *Alih Fungsi Lahan dan Deteritorialisasi Lingkungan di Kabupaten Banjar* (Issue December).
- Valotto Neto, L. J., Reverete de Araujo, M., Moretti Junior, R. C., Mendes Machado, N., Joshi, R. K., dos Santos Buglio, D., Barbalho Lamas, C., Direito, R., Fornari Laurindo, L., Tanaka, M., & Barbalho, S. M. (2024). Investigating the Neuroprotective and Cognitive-Enhancing Effects of Bacopa monnieri: A Systematic Review Focused on Inflammation, Oxidative Stress, Mitochondrial Dysfunction, and Apoptosis. *Antioxidants*, 13(4). <https://doi.org/10.3390/antiox13040393>
- Vilar-Pereira, G., Gibaldi, D., Castaño-Barrios, L., da Silva, A. A., Pereira, I. R., Moreira, O. C., Britto, C., Dos Santos, H. A. M., Lopes, R. de O., Tinoco, L. W., Oliveira, W., & Lannes-Vieira, J. (2024). The beneficial effect of fluoxetine on behavioral and cognitive changes in chronic experimental Chagas disease unveils the role of serotonin fueling astrocyte infection by Trypanosoma cruzi. In *PLoS Neglected Tropical Diseases* (Vol. 18, Issue 5). <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0012199>
- Yang, R., Liu, X., Zhao, Z., Zhao, Y., & Jin, X. (2025). Burden of neurological diseases in Asia, from 1990 to 2021 and its predicted level to 2045: a Global Burden of Disease study. *BMC Public Health*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-025-21928-9>

Bab 6

Penutup

Masyarakat lahan basah, khususnya suku Banjar di Kalimantan, memiliki karakteristik unik yang terbentuk dari interaksi panjang dengan lingkungan sekitarnya. Lahan basah mencakup wilayah rawa, sungai, dan daerah pasang surut yang memiliki ekosistem khas dan menjadi sumber utama penghidupan masyarakat setempat. Masyarakat Banjar telah beradaptasi dengan kondisi ini melalui pola hidup yang khas, termasuk dalam aspek mata pencaharian, budaya, dan kebiasaan sehari-hari. Lahan basah didefinisikan sebagai wilayah yang tergenang air secara permanen atau musiman, mencakup rawa-rawa, hutan bakau, dan daerah pasang surut. Karakteristik utama lahan basah meliputi keberadaan vegetasi khas, tanah yang jenuh air, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Masyarakat yang tinggal di daerah ini bergantung pada lingkungan lahan basah untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari pertanian lebak, perikanan, hingga transportasi air. Pola hidup masyarakat Banjar sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan lahan basah. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani di lahan pasang surut, menangkap ikan, serta berdagang di sepanjang aliran sungai. Sistem perdagangan yang berbasis sungai telah lama berkembang, menciptakan jaringan ekonomi yang dinamis di wilayah ini. Selain itu, rumah panggung yang tahan terhadap banjir merupakan salah satu bentuk adaptasi unik terhadap lingkungan yang sering mengalami perubahan ketinggian air (Agianto et al., 2025).

Budaya Banjar juga memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan sekitarnya. Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Banjar mencerminkan hubungan harmonis dengan lahan basah. Contohnya adalah tradisi Bapanduk, yaitu berpindah tempat untuk menyesuaikan dengan pasang surut air, serta upacara adat yang terkait dengan kehidupan sungai dan laut. Penggunaan bahan alami dari lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-

hari, seperti tanaman obat dan kayu ulin untuk pembangunan rumah, juga menunjukkan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Faktor sosial dan ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat Banjar. Akses terhadap fasilitas kesehatan sering kali terbatas karena faktor geografis dan infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, tingkat ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tradisional seperti perikanan dan pertanian membuat mereka rentan terhadap fluktuasi lingkungan dan perubahan iklim. Ketahanan masyarakat terhadap berbagai tantangan kesehatan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Paparan lingkungan yang khas di lahan basah memiliki dampak terhadap kesehatan saraf masyarakat Banjar. Faktor seperti kualitas air, kandungan logam berat dalam tanah dan sungai, serta paparan zat kimia dari aktivitas industri dan pertanian dapat meningkatkan risiko gangguan persyarafan. Selain itu, pola konsumsi masyarakat yang mengandalkan sumber daya lokal seperti ikan, hasil pertanian, dan air sungai dapat menjadi faktor risiko jika tidak dikelola dengan baik (Kurmalawati et al., 2023).

Kebiasaan kerja masyarakat lahan basah juga berkontribusi terhadap risiko gangguan persyarafan. Misalnya, nelayan yang bekerja dalam kondisi cuaca ekstrem, petani yang terpapar pestisida, serta pekerja tambang yang berisiko terpapar logam berat. Faktor ergonomis seperti postur tubuh yang buruk saat bekerja di atas perahu atau dalam kondisi tanah yang lembek juga dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal yang berpengaruh pada sistem saraf. Selain faktor lingkungan dan pola hidup, aspek genetik juga berperan dalam predisposisi gangguan persyarafan. Beberapa penyakit neurodegeneratif memiliki kecenderungan genetik yang dapat diperparah oleh paparan lingkungan dan gaya hidup. Studi mengenai prevalensi gangguan persyarafan di masyarakat lahan basah dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai interaksi antara faktor genetik dan lingkungan.

A. Ringkasan

Gangguan persyarafan yang dialami masyarakat lahan basah dapat dikategorikan berdasarkan penyebabnya. Salah satu penyebab utama adalah paparan neurotoksik dari lingkungan. Bahan kimia seperti merkuri, timbal, dan pestisida yang mencemari air dan tanah dapat berdampak langsung

pada sistem saraf. Paparan jangka panjang terhadap zat-zat ini dapat menyebabkan gangguan kognitif, tremor, serta berbagai bentuk neuropati. Selain zat kimia, infeksi juga merupakan faktor risiko yang signifikan. Masyarakat lahan basah memiliki risiko tinggi terhadap penyakit endemik seperti malaria dan leptospirosis, yang dapat menyebabkan komplikasi neurologis. Infeksi parasit tertentu juga dapat menyerang sistem saraf pusat dan perifer, mengakibatkan gangguan motorik dan sensorik yang berkepanjangan. Pola hidup masyarakat Banjar turut berkontribusi terhadap perkembangan penyakit neurodegeneratif. Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak dan rendah serat, serta kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan preventif, dapat mempercepat proses degenerasi saraf. Selain itu, kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol juga menjadi faktor risiko tambahan yang dapat memperburuk kondisi saraf.

Beberapa studi kasus telah menunjukkan hubungan antara lingkungan lahan basah dan gangguan persyarafan. Misalnya, terdapat laporan tentang peningkatan kasus neuropati di komunitas yang tinggal di daerah tambang emas tradisional akibat paparan merkuri. Demikian pula, kasus gangguan motorik pada nelayan yang sering terpapar air yang tercemar logam berat juga menjadi perhatian utama dalam penelitian kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi pencegahan berbasis budaya dan kearifan lokal. Edukasi mengenai cara mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pola konsumsi yang lebih sehat dapat membantu mengurangi risiko gangguan persyarafan. Program kesehatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat dan agama dapat meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan. Pendekatan keperawatan komunitas memainkan peran penting dalam menangani gangguan persyarafan. Tenaga kesehatan harus mampu mengidentifikasi faktor risiko spesifik di lingkungan lahan basah dan memberikan edukasi serta layanan kesehatan yang sesuai. Penyuluhan mengenai ergonomi kerja, pengelolaan stres, serta deteksi dini gangguan persyarafan dapat membantu masyarakat lebih memahami dan mencegah penyakit sejak dini.

Peran tenaga kesehatan dalam edukasi dan promosi kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan saraf. Kampanye kesehatan mengenai bahaya neurotoksin, pentingnya pola

makan sehat, serta pencegahan penyakit infeksi dapat membantu mengurangi angka kejadian gangguan persyarafan di masyarakat lahan basah. Sebagai solusi jangka panjang, model intervensi berbasis masyarakat perlu dikembangkan. Program kesehatan yang melibatkan komunitas lokal, dukungan pemerintah, serta pendekatan lintas sektor dapat menjadi langkah efektif dalam meningkatkan kesehatan saraf masyarakat lahan basah. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan risiko gangguan persyarafan dapat diminimalkan, sehingga kualitas hidup masyarakat Banjar dapat terus meningkat (Kurmawati et al., 2023).

B. Implikasi Sosial-Budaya dan Lingkungan terhadap Pendidikan Keperawatan dan Pelayanan Kesehatan

Gangguan persyarafan merupakan masalah kesehatan yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus, terutama di wilayah lahan basah yang dihuni oleh masyarakat dengan budaya tertentu, seperti masyarakat Banjar. Kondisi lingkungan lahan basah yang khas, ditambah dengan praktik budaya dan kebiasaan setempat, dapat mempengaruhi prevalensi dan jenis gangguan persyarafan yang terjadi. Dalam konteks ini, kebijakan kesehatan dan pendidikan keperawatan harus disesuaikan untuk mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Masyarakat Banjar, yang mayoritas tinggal di bantaran sungai, memiliki budaya dan praktik kesehatan tradisional yang unik. Misalnya, tradisi "bapukung" atau menggendong bayi dengan kain memiliki manfaat bagi kesehatan anak dan memudahkan orang tua dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun, praktik ini juga perlu diperhatikan dalam konteks kesehatan persyarafan, terutama jika tidak dilakukan dengan benar dapat menyebabkan masalah pada perkembangan saraf anak (Aridamayanti, Nurhidayah, et al., 2024).

Kebijakan kesehatan harus mempertimbangkan integrasi antara praktik tradisional dan medis modern. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program yang menghormati dan memanfaatkan kearifan lokal, sambil memastikan bahwa praktik tersebut aman dan tidak membahayakan kesehatan. Misalnya, pelatihan bagi bidan dan tenaga kesehatan lainnya tentang cara yang tepat dalam mendukung praktik bapukung dapat membantu mencegah potensi gangguan persyarafan pada bayi. Selain itu, faktor lingkungan lahan basah juga berperan dalam kesehatan persyarafan. Pencemaran air sungai akibat pembuangan sampah dan limbah rumah

tangga dapat membawa dampak negatif pada kesehatan manusia, termasuk meningkatkan risiko penyakit yang mempengaruhi sistem saraf (Flynn, 2024). Oleh karena itu, kebijakan kesehatan harus mencakup upaya pengelolaan lingkungan yang efektif, seperti penyediaan fasilitas pembuangan sampah yang memadai dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pendidikan keperawatan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat lahan basah. Kurikulum keperawatan perlu memasukkan materi tentang pengkajian kesehatan di lingkungan lahan basah, termasuk pemahaman tentang penyakit yang umum terjadi dan faktor risiko yang ada. Pengkajian keperawatan komunitas pada masyarakat di lahan basah dapat difokuskan dengan memperhatikan aspek kesehatan khas yang terdapat pada lahan basah. Selain itu, pendidikan keperawatan harus menekankan pentingnya pemahaman budaya dalam memberikan asuhan keperawatan. Mahasiswa keperawatan perlu dibekali dengan kemampuan untuk menghormati dan memahami praktik budaya setempat, sehingga dapat memberikan edukasi dan intervensi kesehatan yang sesuai dan diterima oleh masyarakat. Penting juga bagi tenaga kesehatan untuk menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat dan penyembuh tradisional. Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan penyembuh tradisional dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan dan memastikan bahwa intervensi yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat (Albarnawi et al., 2023).

Kebijakan kesehatan harus mencakup program pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang cara berkomunikasi efektif dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pesan-pesan kesehatan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, program promosi kesehatan harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks budaya dan lingkungan setempat. Misalnya, kampanye tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit dapat disampaikan melalui media yang populer di kalangan masyarakat Banjar, seperti pertunjukan seni tradisional atau acara komunitas. Pendidikan keperawatan juga harus menekankan pentingnya penelitian dan pengumpulan data tentang kesehatan masyarakat di lahan basah. Mahasiswa keperawatan perlu dilatih untuk melakukan penelitian komunitas, sehingga dapat mengidentifikasi masalah kesehatan yang spesifik dan mengembangkan intervensi yang efektif. Selain itu, kebijakan

kesehatan harus mendukung pengembangan infrastruktur kesehatan yang memadai di wilayah lahan basah. Pembangunan fasilitas kesehatan yang mudah diakses dan dilengkapi dengan peralatan yang sesuai sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penting juga untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam menghadapi krisis kesehatan akibat bencana yang sering terjadi di wilayah lahan basah. Pedoman teknis penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana harus disosialisasikan dan diterapkan dengan baik oleh tenaga kesehatan (Albarnawi et al., 2023).

Selain itu, pendidikan keperawatan harus mencakup pelatihan tentang manajemen bencana dan penanggulangan krisis kesehatan. Mahasiswa keperawatan perlu dibekali dengan keterampilan untuk merespons situasi darurat dan memberikan asuhan keperawatan yang efektif dalam kondisi krisis. Kebijakan kesehatan juga harus mendukung penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara faktor lingkungan di lahan basah dan gangguan persyarafan. Dengan adanya penelitian yang komprehensif, intervensi kesehatan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Selain itu, pendidikan keperawatan harus mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan ilmu keperawatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat di lahan basah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik keperawatan didasarkan pada bukti ilmiah yang relevan dan terkini. Kebijakan kesehatan juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan persyarafan. Program edukasi dan promosi kesehatan harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks budaya dan lingkungan setempat, sehingga pesan-pesan kesehatan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat (Aridamayanti, Agianto, et al., 2024).

Pendidikan keperawatan harus menekankan pentingnya peran perawat sebagai edukator dan advokat bagi masyarakat. Mahasiswa keperawatan perlu dibekali dengan keterampilan komunikasi yang efektif dan pemahaman tentang strategi edukasi yang sesuai dengan budaya setempat. Dengan demikian, mereka dapat berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat dan membantu mencegah gangguan persyarafan di komunitas lahan basah. Selain itu, kebijakan kesehatan harus mencakup strategi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan yang bekerja

di daerah terpencil, termasuk di wilayah lahan basah. Insentif yang memadai, program pelatihan berkelanjutan, serta dukungan psikososial bagi tenaga kesehatan dapat meningkatkan motivasi mereka dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan keperawatan dan layanan kesehatan juga harus diperkuat. Telemedicine dan e-learning dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan akses terhadap sumber daya kesehatan dan pendidikan di daerah lahan basah. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan jarak jauh bagi tenaga kesehatan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan spesialis, serta mempercepat deteksi dan penanganan dini gangguan persyarafan (Ifansyah & Waluya, 2024).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan. Pemerintah, institusi pendidikan, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, serta pemimpin adat perlu bekerja sama dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lahan basah. Kesimpulannya, implikasi bagi kebijakan kesehatan dan pendidikan keperawatan dalam konteks gangguan persyarafan pada masyarakat lahan basah yang berkaitan dengan budaya Banjar sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan multidisipliner. Dengan kebijakan yang berbasis bukti, edukasi yang berorientasi pada budaya, serta dukungan infrastruktur dan teknologi, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Keberlanjutan program dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan juga diperlukan agar dampak positif dapat terus dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang (Ifansyah & Waluya, 2024).

C. Strategi Kesehatan dan Pendidikan Keperawatan Berbasis Budaya dan Lingkungan di Komunitas Lahan Basah

Kondisi lingkungan lahan basah yang khas, ditambah dengan praktik budaya dan kebiasaan setempat, dapat mempengaruhi prevalensi dan jenis gangguan persyarafan yang terjadi. Dalam konteks ini, rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan kebijakan kesehatan masyarakat harus disesuaikan untuk mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor risiko spesifik yang berkontribusi terhadap gangguan

persyarafan di masyarakat lahan basah. Misalnya, paparan terhadap bahan kimia atau logam berat yang mungkin terdapat di lingkungan lahan basah dapat menjadi faktor risiko yang signifikan. Studi epidemiologi yang komprehensif dapat membantu mengidentifikasi prevalensi dan insiden gangguan persyarafan serta faktor-faktor risiko yang terkait. Selain itu, penelitian kualitatif yang mendalam diperlukan untuk memahami persepsi dan pengetahuan masyarakat Banjar tentang gangguan persyarafan. Pemahaman ini penting untuk mengembangkan intervensi kesehatan yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat. Misalnya, penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan lahan basah dan lahan kering dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mereka memandang kesehatan dan penyakit. Kebijakan kesehatan masyarakat harus mempertimbangkan integrasi antara praktik tradisional dan medis modern. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program yang menghormati dan memanfaatkan kearifan lokal, sambil memastikan bahwa praktik tersebut aman dan tidak membahayakan kesehatan. Misalnya, pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang cara yang tepat dalam mendukung praktik tradisional dapat membantu mencegah potensi gangguan persyarafan (Ifansyah & Waluya, 2024).

Selain itu, faktor lingkungan lahan basah juga berperan dalam kesehatan persyarafan. Pencemaran air sungai akibat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga dapat membawa dampak negatif pada kesehatan manusia, termasuk meningkatkan risiko penyakit yang mempengaruhi sistem saraf. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan harus mencakup upaya pengelolaan lingkungan yang efektif, seperti penyediaan fasilitas pembuangan sampah yang memadai dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penting juga bagi tenaga kesehatan untuk menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat dan penyembuh tradisional. Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan penyembuh tradisional dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan dan memastikan bahwa intervensi yang diberikan sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Kebijakan kesehatan harus mencakup program pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang cara berkomunikasi efektif dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pesan-pesan kesehatan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, program promosi

kesehatan harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks budaya dan lingkungan setempat. Misalnya, kampanye tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit dapat disampaikan melalui media yang populer di kalangan masyarakat Banjar, seperti pertunjukan seni tradisional atau acara komunitas (Ifansyah & Waluya, 2024).

Pendidikan keperawatan juga harus menekankan pentingnya penelitian dan pengumpulan data tentang kesehatan masyarakat di lahan basah. Mahasiswa keperawatan perlu dilatih untuk melakukan penelitian komunitas, sehingga dapat mengidentifikasi masalah kesehatan yang spesifik dan mengembangkan intervensi yang efektif. Selain itu, kebijakan kesehatan harus mendukung pengembangan infrastruktur kesehatan yang memadai di wilayah lahan basah. Pembangunan fasilitas kesehatan yang mudah diakses dan dilengkapi dengan peralatan yang sesuai sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penting juga untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam menghadapi krisis kesehatan akibat bencana yang sering terjadi di wilayah lahan basah. Pedoman teknis penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana harus disosialisasikan dan diterapkan dengan baik oleh tenaga kesehatan. Selain itu, pendidikan keperawatan harus mencakup pelatihan tentang manajemen bencana dan penanggulangan krisis kesehatan. Mahasiswa keperawatan perlu dibekali dengan keterampilan untuk merespons situasi darurat dan memberikan asuhan keperawatan yang efektif dalam kondisi krisis. Kebijakan kesehatan juga harus mendukung penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara faktor lingkungan di lahan basah dan gangguan persyarafan. Dengan adanya penelitian yang komprehensif, intervensi kesehatan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (Ifansyah & Waluya, 2024).

Selain itu, pendidikan keperawatan harus mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan ilmu keperawatan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat di lahan basah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik keperawatan didasarkan pada bukti ilmiah yang relevan dan terkini. Kebijakan kesehatan juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan persyarafan. Program edukasi dan promosi kesehatan harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks budaya dan lingkungan

setempat, sehingga pesan-pesan kesehatan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Pendidikan keperawatan harus menekankan pentingnya peran perawat sebagai edukator dan advokat bagi masyarakat. Mahasiswa keperawatan perlu dibekali dengan keterampilan komunikasi yang efektif dan pemahaman tentang strategi edukasi yang sesuai dengan budaya setempat. Dengan demikian, mereka dapat berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat dan membantu mencegah gangguan persyarafan di komunitas lahan basah. Selain itu, kebijakan kesehatan harus mencakup strategi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil, termasuk di wilayah lahan basah. Insentif yang memadai, program pelatihan berkelanjutan, serta dukungan psikososial bagi tenaga kesehatan dapat meningkatkan motivasi mereka dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Ifansyah & Waluya, 2024).

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan keperawatan dan layanan kesehatan juga harus diperkuat. Telemedicine dan e-learning dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan akses terhadap sumber daya kesehatan dan pendidikan di daerah lahan basah. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan jarak jauh bagi tenaga kesehatan, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan spesialis, serta mempercepat deteksi dan penanganan dini gangguan persyarafan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan. Pemerintah, institusi pendidikan, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, serta pemimpin adat perlu bekerja sama dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lahan basah. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan kebijakan kesehatan masyarakat dalam konteks gangguan persyarafan pada masyarakat lahan basah yang berkaitan dengan budaya Banjar sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan multidisipliner. Dengan kebijakan yang berbasis bukti, edukasi yang berorientasi pada budaya, serta dukungan infrastruktur dan teknologi, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Keberlanjutan program dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan juga diperlukan agar dampak positif dapat terus dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, dan masyarakat

dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Agianto et al., 2025).

Diperlukan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan kesehatan. Masyarakat lahan basah, khususnya yang memiliki budaya Banjar, harus diberikan ruang untuk berkontribusi dalam perumusan strategi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal mereka. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak hanya berbasis bukti ilmiah tetapi juga relevan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Selain itu, penting untuk mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan kesehatan yang diterapkan. Data yang akurat dan terkini harus dikumpulkan secara berkala untuk menilai dampak dari berbagai intervensi kesehatan yang dilakukan. Dengan adanya sistem pemantauan yang baik, kebijakan dapat terus disesuaikan dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Di masa depan, penelitian mengenai hubungan antara faktor lingkungan dan sosial di lahan basah dengan gangguan persyarafan harus terus dikembangkan. Penelitian ini dapat mencakup aspek genetika, nutrisi, pola hidup, serta dampak perubahan iklim terhadap kesehatan saraf masyarakat di wilayah ini. Kolaborasi dengan berbagai institusi penelitian dan universitas juga dapat memperkaya wawasan dan solusi yang dapat diterapkan di tingkat kebijakan. Pendidikan keperawatan dan kesehatan masyarakat harus terus diperbarui agar mampu menghadapi tantangan kesehatan yang spesifik di daerah lahan basah. Kurikulum pendidikan harus memasukkan aspek kesehatan lingkungan, budaya, serta pendekatan multidisipliner dalam menangani gangguan persyarafan. Hal ini akan memastikan bahwa tenaga kesehatan masa depan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat (Agianto et al., 2025).

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan kesehatan dalam menangani gangguan persyarafan pada masyarakat lahan basah akan sangat bergantung pada komitmen bersama dari berbagai pihak. Upaya yang berkelanjutan dalam penelitian, pendidikan, dan kebijakan akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkualitas bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan khas lahan basah (Agianto et al., 2025).

D. Penutup

Gangguan persyarafan pada masyarakat lahan basah yang berkaitan dengan budaya Banjar merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, pola hidup, kebiasaan budaya, serta akses terhadap layanan kesehatan. Selama pembahasan dalam buku ini, telah dijelaskan bagaimana kondisi geografis lahan basah, yang kaya akan sumber daya namun juga memiliki tantangan tersendiri, dapat berkontribusi terhadap berbagai risiko kesehatan saraf. Faktor-faktor seperti paparan zat beracun dari lingkungan, pola makan, dan kebiasaan kerja yang tidak ergonomis berperan dalam meningkatkan risiko gangguan persyarafan pada masyarakat Banjar. Upaya untuk mengatasi gangguan persyarafan di komunitas ini tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan multidisipliner yang mencakup penelitian lebih lanjut, kebijakan kesehatan berbasis bukti, serta pendidikan keperawatan yang responsif terhadap tantangan lokal. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, akademisi, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan intervensi yang tepat guna dan berkelanjutan.

Salah satu langkah penting dalam penanggulangan gangguan persyarafan adalah peningkatan kesadaran masyarakat mengenai faktor risiko dan pencegahannya. Edukasi kesehatan yang berbasis budaya harus diperkuat agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pendekatan yang mengintegrasikan praktik tradisional dengan ilmu medis modern dapat meningkatkan efektivitas program kesehatan dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor lingkungan spesifik yang berkontribusi terhadap peningkatan gangguan persyarafan di daerah lahan basah. Studi tentang kontaminasi air oleh logam berat, dampak pestisida terhadap sistem saraf, serta pengaruh pola makan berbasis ikan dan hasil sungai perlu dikembangkan untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti yang lebih akurat. Dari sisi kebijakan, perlu adanya regulasi yang lebih ketat dalam pengelolaan lingkungan untuk mengurangi paparan zat beracun yang berpotensi merusak sistem saraf. Program kesehatan masyarakat yang berbasis pada deteksi dini gangguan persyarafan, rehabilitasi, serta peningkatan infrastruktur layanan kesehatan juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dan institusi terkait.

Peran tenaga kesehatan, khususnya perawat, menjadi sangat krusial dalam upaya mitigasi gangguan persyarafan. Pendidikan keperawatan harus memasukkan materi terkait dengan kesehatan lingkungan, ergonomi kerja, serta pendekatan holistik dalam asuhan keperawatan yang mempertimbangkan aspek budaya masyarakat Banjar. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan pendekatan berbasis komunitas juga sangat diperlukan agar program kesehatan dapat berjalan secara efektif. Keberlanjutan program intervensi kesehatan bergantung pada dukungan kebijakan yang konsisten serta partisipasi aktif dari masyarakat. Model intervensi yang mengedepankan pemberdayaan komunitas akan lebih efektif dalam membangun kesadaran jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lahan basah. Program kesehatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat dan pemuka masyarakat dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap intervensi kesehatan yang diberikan.

Sebagai langkah konkret, perlu dikembangkan sistem pemantauan kesehatan berbasis komunitas yang memungkinkan deteksi dini terhadap gangguan persyarafan. Teknologi kesehatan, seperti aplikasi pemantauan kesehatan berbasis digital, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Selain itu, kebijakan kesehatan harus memperhatikan faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Subsidi layanan kesehatan bagi kelompok rentan, pelatihan kerja yang memperhatikan aspek ergonomis, serta peningkatan akses terhadap makanan sehat yang bebas dari kontaminasi merupakan beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk mengurangi prevalensi gangguan persyarafan di komunitas lahan basah. Pendidikan keperawatan harus terus diperbarui agar relevan dengan tantangan kesehatan yang terus berkembang. Kurikulum yang mencakup pendekatan transdisipliner dalam menangani gangguan persyarafan akan menghasilkan tenaga kesehatan yang lebih kompeten dalam memberikan asuhan yang berbasis bukti dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Dari perspektif akademik, penelitian yang lebih luas dan mendalam mengenai hubungan antara faktor lingkungan, genetika, dan kebiasaan hidup masyarakat lahan basah dengan gangguan persyarafan akan sangat

membantu dalam pengembangan strategi pencegahan dan pengobatan yang lebih efektif. Studi yang berfokus pada adaptasi budaya terhadap perubahan lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan juga perlu dikembangkan untuk memberikan solusi yang lebih holistik. Dengan berbagai upaya yang telah diuraikan, diharapkan risiko gangguan persyarafan pada masyarakat lahan basah dapat diminimalkan dan kualitas hidup masyarakat Banjar dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan literasi kesehatan, penelitian berbasis bukti, serta kebijakan yang responsif terhadap kondisi lokal menjadi pilar utama dalam membangun sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Gangguan persyarafan di masyarakat lahan basah bukan hanya permasalahan medis, tetapi juga mencerminkan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus diatasi secara terpadu. Upaya yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesehatan masyarakat Banjar. Dengan sinergi antara ilmu pengetahuan, kebijakan yang tepat, serta peran aktif masyarakat, maka harapan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari gangguan persyarafan dapat terwujud dalam jangka panjang.

E. Referensi

- Agianto, Aridamayanti, B. G., Firdausi, R., Septiany, M., & Hasibuan, N. A. (2025). Perawatan Stroke di Komunitas. In *Nuansa Fajar Cemerlang*.
- Albarnawi, H. M., Alroqabi, S. M., Ogdi, W. Z., Jalal, A. A., Agdi, J. Z., AL-Eid, H. S., Almutairy, A. K., Alanazi, M. K., Qawfashi, F. Y., & Alhadidi, A. M. (2023). Community nursing interventions for chronic disease management. *International Journal Of Community Medicine And Public Health*, 11(1), 464–468. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20233858>
- Aridamayanti, B. G., Agianto, Septiany, M., Chrisnawati, Khairina, N., Amilia, E., Fayza, E. N., & Vebrina, E. (2024). Personal Hygiene pada Masyarakat dengan Keluhan Penyakit Kulit. *Jurnal Dunia Keperawatan*, 12(July), 244–253. <https://doi.org/10.20527/dk.v12i2.660>
- Aridamayanti, B. G., Nurhidayah, S. D., Rahmah, J., Sintia, Humaira, A., Meidiani, Meiliana, D., Amalia, N. P., Amilia, E., Adibah, J. D., Badriah, S., Agustia, Z. A., Rahimi, F., Alisa, R., Kamil, M. R., Hafiz, C., & Ghani, Z. (2024). Manajemen Antisipasi Bencana. *CV. Gita Lentera*, 6.
- Flynn, B. C. (2024). Community health nursing education. *Annual Review of Nursing Research*, 6, 167–190. <https://doi.org/10.1891/0739-6686.6.1.167>
- Ifansyah, M. N., & Waluya, J. G. (2024). *Keperawatan Komunitas Pendekatan Holistik untuk Perlindungan, Pemberdayaan dan Intervensi Strategis*.
- Kurmalawati, R., Ir Meldi Septiana, Ms., Norma Yuni Kartika, Ms., & Aiga, D. (2023). *Studi Kasus Utama Lingkungan Lahan Basah Suku Banjar di Kalimantan Selatan*.

Glosarium

A

Anemia: Kondisi medis yang ditandai dengan rendahnya jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah, yang dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan.

Apoptosis: Proses kematian sel yang terprogram sebagai bagian dari regulasi pertumbuhan dan perkembangan tubuh.

B

Banjar: Suku asli yang mendiami daerah Kalimantan Selatan, dengan budaya yang erat kaitannya dengan lingkungan lahan basah.

Bekam: Terapi tradisional dengan cara menyedot darah kotor melalui pembentukan vakum pada kulit menggunakan alat khusus.

C

Cerebrovaskular: Berhubungan dengan pembuluh darah otak, sering dikaitkan dengan penyakit seperti stroke.

Cytokine: Protein kecil yang berperan dalam komunikasi antar sel dalam sistem kekebalan tubuh.

D

Diabetes Mellitus: Penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi akibat gangguan produksi atau respons terhadap insulin.

Dopamin: Neurotransmitter yang berperan dalam mengontrol gerakan, motivasi, dan sistem penghargaan otak.

E

Edema: Pembengkakan akibat penumpukan cairan dalam jaringan tubuh.

Ensefalitis: Peradangan pada otak yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri.

F

Fibrilasi Atrium: Gangguan irama jantung yang dapat meningkatkan risiko stroke dan masalah kardiovaskular lainnya.

Fungsi Motorik: Kemampuan sistem saraf untuk mengontrol pergerakan otot tubuh.

G

Gangguan Persyarafan: Kondisi yang mempengaruhi fungsi sistem saraf, baik pusat maupun perifer.

Glukosa: Gula sederhana yang merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh.

H

Hipertensi: Kondisi tekanan darah tinggi yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan stroke.

Hipoksia: Kekurangan oksigen dalam jaringan tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan organ.

I

Inflamasi: Reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi atau cedera, yang ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, dan nyeri.

Iskemia: Kondisi di mana pasokan darah ke suatu jaringan atau organ terganggu, menyebabkan kekurangan oksigen dan nutrisi.

J

Jaringan Saraf: Struktur dalam tubuh yang terdiri dari sel-sel saraf yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal listrik dan kimiawi.

Jerawat Neuropatik: Gangguan kulit yang disebabkan oleh kerusakan saraf, sering dikaitkan dengan diabetes.

K

Kelembapan Tinggi: Kondisi lingkungan dengan kadar air di udara yang tinggi, yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, termasuk sistem saraf.

Keperawatan Neurologi: Cabang keperawatan yang berfokus pada perawatan pasien dengan gangguan sistem saraf.

L

Lahan Basah: Wilayah yang tergenang air secara permanen atau musiman, seperti rawa dan sungai, yang memiliki pengaruh terhadap pola hidup masyarakat setempat.

Leptospirosis. Infeksi bakteri yang dapat menyerang sistem saraf dan organ lain, sering ditemukan di daerah dengan sanitasi yang kurang baik.

M

Mielin. Lapisan lemak yang melapisi dan melindungi serat saraf untuk mempercepat transmisi sinyal listrik.

Migrain: Gangguan neurologis yang ditandai dengan sakit kepala parah yang bisa disertai mual dan sensitivitas terhadap cahaya.

N

Neuropati: Gangguan atau kerusakan pada saraf perifer yang menyebabkan mati rasa, kesemutan, atau nyeri.

Neurotransmitter. Zat kimia yang berperan dalam mengirimkan sinyal antar sel saraf.

O

Oksidatif Stress: Ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan kemampuan tubuh untuk menetralkannya, yang dapat menyebabkan kerusakan sel.

Otak Kecil (*Cerebellum*): Bagian otak yang mengatur koordinasi gerakan dan keseimbangan tubuh.

P

Paralisis: Kehilangan kemampuan gerak pada satu bagian tubuh akibat gangguan saraf atau otot.

Peredaran Darah: Proses di mana darah mengalir ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi.

R

Radikulopati: Kondisi akibat tekanan atau iritasi pada akar saraf tulang belakang yang menyebabkan nyeri atau kelemahan otot.

Reseptor Saraf: Struktur khusus pada sel saraf yang menerima dan merespons rangsangan dari luar.

S

Sensori: Kemampuan sistem saraf untuk merasakan rangsangan dari lingkungan sekitar.

Stroke: Gangguan aliran darah ke otak yang dapat menyebabkan kerusakan sel otak dan gangguan fungsi tubuh.

T

Tremor: Gerakan gemetar yang tidak disengaja, biasanya akibat gangguan pada sistem saraf.

Tulang Belakang: Struktur utama dalam sistem saraf pusat yang menghubungkan otak dengan tubuh bagian bawah.

V

Vaskularisasi: Proses pembentukan pembuluh darah baru untuk mendukung suplai darah ke jaringan tubuh.

Vertigo: Sensasi pusing atau merasa lingkungan sekitar berputar, sering dikaitkan dengan gangguan sistem keseimbangan di telinga dalam.

Neurologis Komunitas di Lahan Basah mengangkat isu gangguan sistem saraf pada masyarakat yang tinggal di wilayah lahan basah, dengan sorotan khusus pada komunitas Banjar di Kalimantan Selatan. Buku ini menyoroti bagaimana gangguan neurologis tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga membawa konsekuensi luas bagi keluarga dan tatanan sosial masyarakat.

Melalui pendekatan yang komprehensif, buku ini menelusuri pengaruh faktor lingkungan khas lahan basah seperti kelembapan tinggi, paparan air dalam jangka panjang, dan keterbatasan akses layanan kesehatan terhadap meningkatnya risiko gangguan persyarafan. Selain faktor ekologis, Neurologis Komunitas di Lahan Basah juga menyajikan analisis mendalam mengenai dimensi budaya, mulai dari praktik pengobatan tradisional, pola makan tinggi garam, hingga keyakinan terhadap aspek spiritual dalam pemahaman penyakit saraf.

Dengan menggabungkan pendekatan ilmiah dan kearifan lokal, buku ini menawarkan perspektif baru dalam merancang strategi kesehatan yang kontekstual dan lebih tepat sasaran untuk masyarakat lahan basah. Ditujukan bagi tenaga medis, akademisi, dan pembuat kebijakan, buku ini menjadi kontribusi penting dalam mendorong kesadaran, pemahaman, dan upaya peningkatan kualitas hidup bagi komunitas yang rentan terhadap gangguan neurologis.

Neurologis Komunitas di Lahan Basah mengangkat isu gangguan sistem saraf pada masyarakat yang tinggal di wilayah lahan basah, dengan sorotan khusus pada komunitas Banjar di Kalimantan Selatan. Buku ini menyoroti bagaimana gangguan neurologis tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga membawa konsekuensi luas bagi keluarga dan tatanan sosial masyarakat.

Melalui pendekatan yang komprehensif, buku ini menelusuri pengaruh faktor lingkungan khas lahan basah seperti kelembapan tinggi, paparan air dalam jangka panjang, dan keterbatasan akses layanan kesehatan terhadap meningkatnya risiko gangguan persyarafan. Selain faktor ekologis, Neurologis Komunitas di Lahan Basah juga menyajikan analisis mendalam mengenai dimensi budaya, mulai dari praktik pengobatan tradisional, pola makan tinggi garam, hingga keyakinan terhadap aspek spiritual dalam pemahaman penyakit saraf.

Dengan menggabungkan pendekatan ilmiah dan kearifan lokal, buku ini menawarkan perspektif baru dalam merancang strategi kesehatan yang kontekstual dan lebih tepat sasaran untuk masyarakat lahan basah. Ditujukan bagi tenaga medis, akademisi, dan pembuat kebijakan, buku ini menjadi kontribusi penting dalam mendorong kesadaran, pemahaman, dan upaya peningkatan kualitas hidup bagi komunitas yang rentan terhadap gangguan neurologis.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-45-9



9

786347

219459